ACENOCUMAROL
ACCIÓN TERAPÉUTICA: Inhibidor del metabolismo de la vitamina K
INDICACIÓN: Tratamiento y profilaxis de afecciones tromboembólicas.
POSOLOGIA: Dosis de carga: < 1 año: 0,2 mg/kg; 1-5 años: 0,09 mg/kg; 6-10 años: 0,07 mg/kg; 11-18 años: 0,06 mg/kg. Se administra una sola vez al día, por la tarde.
EFECTOS ADVERSOS: Sangrado, osteoporosis, necrosis cutánea, calcificación traqueal, alopecia. Efecto teratogénico: condrodisplasia punctata
PRESENTACIÓN: Comprimidos 1 mg y 4 mg.
OBSERVACIONES: Existe un período de latencia en el comienzo de acción terapéutica.
INTERACCIONES: Potencian el efecto anticoagulante: allopurinol, esteroides anabólicos, andrógenos, antiarrítmicos (amiodarona, quinidina), antibióticos (eritromicina, cloranfenicol, tetraciclina, neomicina), glucagon, derivados del imidazol, sulfamidas de accion prolongada, antidiabéticos orales, hormonas tiroideas. Modifican la hemostasia y aumenta el riesgo de hemorragias gastrointestinales: heparina, acido salicílico y sus derivados. Disminuye el efecto anticoagulante: barbitúricos, carbamazepina, colestiramina, griseofulvina, anticonceptivos orales, rifampicina y diuréticos tiazídicos.
ATC: B. Sangres y Organos Hematopoyeticos B01A. Agentes Antitromboticos B01AA. Antagonistas de la Vitamina K

ACETAZOLAMIDA
ACCIÓN TERAPÉUTICA: Diurético, inhibidor de la anhidrasa carbónica. Disminuye producción de LCR y humor acuoso (glaucoma). Tratamiento de la alcalosis metabólica.
INDICACIÓN: edema, hidrocefalia, glaucoma.
POSOLOGIA: Edema: < 12 años: 5 mg/kg/día cada 24 hs; > 12 años: 250-375 mg/día. Hidrocefalia: 25-50 mg/kg/día cada 8 hs, dosis máxima: 100 mg/kg/día. Glaucoma: 8-30 mg/kg/día cada 6-8 hs; dosis máxima: < 12 años: 750 mg/día, > 12 años: 1 g/día; adultos: 250 mg/dosis, puede repetirse cada 2-4 hs hasta el alivio del síntoma. Pseudotumor cerebri: 40-50 mg/kg/día cada 6-8 hs, dosis máxima: 2 g/día.
EFECTOS ADVERSOS: Parestesia, confusión, rash, náuseas, cristaluria, nefrolitiasis, hematuria, acidosis hiperclorémica hipokalémica, fatiga, irritabilidad.
PRESENTACIÓN: Comprimido 250 mg.
OBSERVACIONES: Controlar los niveles en sangre de bicarbonato, sodio y potasio. Alcaliniza la orina. Usar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática.
INTERACCIONES: Aumenta la excreción de salicilatos y fenobarbital
ATC: C03 Diureticos C03BX Otros Diureticos de techo bajo

ACICLOVIR
ACCION TERAPEUTICA: Antiviral. Análogo nucleósido de la guanina.
INDICACIÓN: Activo frente al virus herpes simple 1 y 2 (VHS) y el virus varicela zóster (VVZ).

POSOLOGIA: **Encefalitis herpética:** < 12 años: 60 mg/kg/día (EV) cada 8 hs; > 12 años: 30 mg/kg/día (EV) cada 8 hs. **Infección por VHS (mucocutánea, localizada, progresiva o diseminada) en huésped inmunocomprometido**: < 12 años: 30 mg/kg/día (EV) cada 8 hs; > 12 años: 15 mg/kg/día (EV) cada 8 hs. V.O.: 80 mg/kg/día cada 6 hs (dosis máxima: 3,2 g), adultos: 200-800 mg cada 6-8 hs. Varicela en inmunocomprometido: 30 mg/k/dia (EV) cada 8 hs. **Varicela complicada en inmunocompetente (Neumonia,Encefalitis)**: 30 mg/k/dia (EV) cada 8 hs. **Varicela en inmunocomprometido:** 30 mg/k/dia (EV) cada 8 hs. **Herpes Zoster:** 30 mg/k/dia (EV) cada 8 hs, via oral: ≥2 años: 80 mg/kg/día cada 6 hs. **Profilaxis post exposicion a varicela en paciente inmunocomprometidos:** 80 mg/k/dia (VO) cada 6 hs. comenzando entre los 7 y 10 dias post exposicion. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS:Cefalea, signos encefalopáticos, hipotensión, rash, prurito, náuseas, vómitos, diarrea, hematuria, artralgia.

PRESENTACIÓN: FCO AMPOLLA 500 MG - COMPRIMIDOS - SUSPENSION

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD:
IV: Reconstituir el vial con 10ml de AD (50mg/ml). Estabilidad: 12hs a temperatura ambiente, no refrigerar por riesgo a precipitación.
Concentración de la dilución: solo administrar por vía IV, diluir con dextrosa al 5% o con solución fisiológica a una Concentración Recomendada: 2,5-5mg/ml. Máxima concentración: 7mg/ml. Infundir en 60 minutos.
VO: con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal. Conservar la suspensión a temperatura ambiente. Agitar antes de usar.

OBSERVACIONES:Riesgo de flebitis o inflamación en el sitio de inyección a altas concentraciones (muy alcalino). Infundir en al menos 1 hora a una concentración final < a 7 mg/ml. Para prevenir la precipitación del aciclovir en los túbulos renales es necesario una hidratación adecuada. No refrigerar el vial reconstituído.

INTERACCIONES: Con ciclosporina, glucopéptidos, aminoglucósidos, cefalosporinas aumentan la posibilidad de cristaluria. Probenecid y cimetidina disminuyen la secreción tubular del aciclovir y con aumento de la concentración plasmática y liquido cefalorraquídeo.

ATC: J05AB Nucleosidos y Nucleotidos, Excluyendo inhibidores de la transcriptasa reversa

ACIDO ACETILSALICILICO

ACCION TERAPEUTICA: Analgésico, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, antipirético.

INDICACIÓN: Enf. De kawasaki

POSOLOGIA: Analgésica-Antipirética: niños: 10 mg/kg/dosis cada 6 hs; adultos: 500 mg cada 6 hs. Antiinflamatorio reumático: 60-100 mg/kg/día cada 6 hs. Antiagregante plaquetario: niños: 3-5 mg/kg/día cada 24 hs; adultos: 325 mg día por medio. Dosis máxima: 3,6 g/día

EFECTOS ADVERSOS: Úlcera gastrointestinal, náuseas, vómitos, anemia ferropénica. Inhibe función plaquetaria. Promueve retención de agua y sal. Alcalosis respiratoria. Acidosis metabólica. Hepatotoxicidad. Zumbidos, cefalea

PRESENTACIÓN: Comprimidos 100 mg, 325 mg, 500 mg, 650 mg

OBSERVACIONES: Administrar con las comidas. Controlar transaminasas y concentración plasmática en dosis elevadas. Concentración plasmática: antiinflamatoria 150-300 µg/ml; analgésica-antipirética: < 60 µg/ml. Contraindicado en niños y adolescentes con varicela o influenza. Suspender 1 semana previa a cirugías.

INTERACCIONES:Antiacidos- Espironolactona- anticoagulantes- antiagregantes plaquetarios-hipoglucemiantes orales- antianginosos- corticoides

ATC: B01AC. Inhibidores de la Agregacion Plaquetaria

ACIDO BORICO (HIPOGLOS)

INDICACIÓN: Cada 100 g contienen: Concentrado de vitamina A (equivalente a 50,000 U.I. de vitamina A) Óxido de zinc 15 g Ácido bórico 2 g Alantoína 1 g Excipiente, c.b.p. 100 g. Actúa de inmediato aliviando la comezón, el ardor y el dolor provocado por las rozaduras. Además ayuda a prevenir las infecciones en la piel del bebé por su contenido de vitamina A y alantoína, favorece a una rápida reparación de la piel dañada.

POSOLOGIA: Limpiar previamente, si fuera necesario, con agua hervida entibiada o aceite el área de la piel afectada: epidermis infantil escaldada (dermatitis del pañal). Aplicar luego suavemente, cubriendo, de ser conveniente, con una gasa esterilizada. Repetir el tratamiento 2 ó 3 veces por día de ser necesario, hasta lograr la completa remisión de la sintomatología (salvo otra indicación del médico). Para obtener el máximo beneficio, se recomienda limpiar cuidadosamente la piel afectada por dermatitis del pañal, quemaduras, heridas, úlceras por decúbito, irritaciones producidas por la luz solar y otros agentes, etc.
EFECTOS ADVERSOS: Reacciones de hipersensibilidad o irritación.
PRESENTACIÓN: Pomada conteniendo 50 ó 100 g; y polvo con 30 g.
OBSERVACIONES: Debido a que existe una cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina A, los riesgos de efectos secundarios aumentan cuando la superficie de aplicación es extensa, se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada (particularmente quemada) o se trata de mucosas.
ATC: D – Terapia Dermatologica D08AD - Preparados con Acido Borico

ACIDO FUSIDICO / ACIDO FUSIDICO + BETAMETASONA
ACCION TERAPEUTICA: Antibiótico bacteriostático. Activo a gérmenes Gram positivo (Staphylococcus y Corynebacterium)
INDICACIÓN: impétigo, eczemas, sicosis de la barba, acné, foliculitis, otitis externa y en general infecciones de la piel debidas a gérmenes sensibles.
POSOLOGIA: Niños: 3 veces al día, durante un máximo de 2 semanas.
EFECTOS ADVERSOS:Trastornos locales (dermatitis eczema) de frecuencia desconocida.
PRESENTACIÓN: Crema
OBSERVACIONES: Debido a la absorción percutánea del producto, el tratamiento no debería exceder una semana,Penetración ocular puede producir glaucoma.
ATC: D – Terapia Dermatologica D 06 Antibioticos y Quimioterapicos para uso dermatologico. D06A Antibioticos para uso Topico

ACIDO AMINOCAPROICO
ACCION TERAPEUTICA: Antifibrinolítico, para fibrinólisis primaria. Inhibe enzimas fibrinolíticas
INDICACIÓN: Hemorragias asociadas a hiperfibrinólisis. Tratamiento y profilaxis de hemorragias postquirúrgicas. Hemorragias intensas inducidas por un trombolítico. Hemorragias asociadas a procesos hematológicos. Hematuria esencial de los hemofílicos; menstruación profusa, menorragia y metropatía hemorrágica, edema angioneurótico.
POSOLOGIA: E.V.: inicial: 70 mg/kg/dosis; sostén 1ras 8 hs: 15 mg/kg/h. En insuficiencia renal disminuir 15-25% de la dosis normal.
EFECTOS ADVERSOS: Trombosis, cefalea, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, bradicardia, hipotensión, insuficiencia renal.
PRESENTACIÓN: Ampolla 2 g/10 ml.
OBSERVACIONES: Uso excepcional en pediatría. Máxima concentración de administración E.V.: 20 mg/ml, en dextrosa 5% o solución fisiológica. Administrar en al menos 1 hora
ATC: B02. Antihemorragicos B02A. Antifibrinoliticos

ACIDO FOLICO
ACCION TERAPEUTICA: Factor vitamínico. Interviene como cofactor en síntesis de nucleoproteínas y en eritropoyesis.
INDICACIÓN: Prevención y tto. de deficiencia de ác. fólico especialmente durante la gestación, lactancia, periodos de crecimiento rápidos, anemias megaloblásticas, alcoholismo, síndromes de malabsorción.
POSOLOGIA: Dosis pediátricas: suplemento dietético: 0,1mg/día. Se aumenta de 0,5mg a 1mg cuando existan estados que produzcan un aumento de las necesidades.
EFECTOS ADVERSOS: La relación riesgo-beneficio debe evaluarse en presencia de anemia perniciosa
PRESENTACIÓN: Comprimidos 5 mg y de 10 mg.
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: VO: 20 minutos antes de las comidas.

OBSERVACIONES: Puede disminuir las concentraciones séricas de la DifenilHidantoina. Se absorbe bien por V.O., aún en estados de malabsorción. Antes de inciar el tratamiento de anemia megaloblástica con ácido fólico debe descartarse deficiencia de vitamina B12 para evitar la aparición de neuropatía periférica.

INTERACCIONES: Disminuye la concentración sérica de fenitoína. Los antagonistas del ácido fólico (metotrexate, pirimetamina, trimetoprima) impiden la formación de ácido tetrahidrofólico, por consiguiente, el ácido fólico no es eficaz para el tratamiento de sobredosis de estos fármacos (debe usarse leucovorina); la sulfasalazina y el ácido aminosalicílico disminuyen la absorción de ácido fólico; la fenitoína, la primidona y el ácido paraaminosalicílico reducen la concentración de ácido fólico.

ATC: B03 Preparados Antianemicos B03BB Ácido Folico y Derivados

ACIDO TRANEXAMICO

INDICACIÓN: Es un agente antifibrinolítico, hemostásico para el tratamiento de la hemofilia.

POSOLOGIA:Neonatos: dosis prequirúrgica: 4 mg/kg/dosis y luego 1 mg/kg/hora durante 24 hs. V.O.: Niños: 25 mg/kg/día c/6 - 8 hs; Adultos: 1300 mg c/8 hs durante 5 días. E.V.: 10 - 25 mg/kg/dosis c/6-8 hs; E.V. continua: 5 - 10 mg/kg/hora Ajuste de dosis por insuficiencia renal: CLcr 50-80 ml/min: Administrar 50% de la dosis de la dosis normal ó E.V.: 10mg/kg/dosis cada 12 hs; V.O.: 15 mg/kg/dosis cada 12 hs; Clcr: 10-50 ml/min: Administrar 25 % de la dosis ó E.V.: 10 mg/kg/dosis cada 24 hs; V.O.: 15 mg/kg/dosis c/ 24hs; CLcr: < 10 ml/min: administrar 10 % de la dosis ó E.V.: 10 mg/kg/dosis c/ 48 hs; V.O.: 15 mg/kg/dosis c/ 48 hs

EFECTOS ADVERSOS:Trastornos gastrointestinales, cefalea, anemia, hipertensión, reacciones de hipersensibilidad.

PRESENTACIÓN: Comprimidos: 500 mg; Ampollas por 5 ml: 100 mg/ml

OBSERVACIONES: Contraindicado en hemorragia subaracnoidea. No utilizar si hay hematuria. V.O.: se puede administrar la ampolla por vía oral. Administración E.V.: sin diluir en push lento para evitar hipotensión o diluido en 50 ml de dextrosa 5% ó solución fisiológica y administrar en media hora.

ATC: B02 Antihemorrágicos B02A Antifibrinolíticos. B02AA Aminoácidos

ADENOSINA

ACCION TERAPEUTICA: Reversión rápida a ritmo sinusal normal de taquicardias paroxísticas supraventriculares, incluyendo s. de Wolff-Parkinson-White. Diagnóstico de taquicardias supraventriculares.

INDICACIÓN: Terapéutico: conversión rápida a ritmo sinusal de taquicardias paroxísticas supraventriculares. Diagnóstico: ayuda al diagnóstico de taquicardias supraventriculares con complejos QRS anchos o estrechos. Tratamiento de hipertensión pulmonar primaria (adultos), persistente (recién nacidos) o secundaria a cardiopatías congénitas.

POSOLOGIA: El rango de dosis autorizada para niños de de 37,5 µg – 250 µg. Dosis inicial: 50-100 µg/kg. Dosis subsecuentes: Si no hay respuesta, administrar a los 2 minutos una segunda dosis de 200 µg/kg, repetir el proceso hasta un máximo de 0.5mg/k/dosis en niños o 0.3mg/K/dosis en neonatos o hasta establecer ritmo sinusal (máximo 12 mg/dosis o bien 30mg/total).

EFECTOS ADVERSOS:
Cardiovasculares: dolor torácico, enrojecimiento facial (flush).
Respiratorio: disnea, hiperventilación, tos, broncoespasmo.
Sistema nervioso central: mareos, cefalea, temblor, visión borrosa, hipertensión endocraneal.
Gastrointestinales: náuseas, sabor metálico, molestias gastrointestinales.

PRESENTACIÓN: Ampolla 6mg/2 ml

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: administrar por vía periférica o central. Utilizar una vía venosa lo más cercana posible al corazón. IVD: Para dosis menores de 600 ug (0.2ml), realizar una dilución con SF a una Concentración Recomendada de 1-2mg/ml. Máxima Concentración: 3mg/ml. Se debe administrar de manera rápida de 1 a 2 segundos y lavar inmediatamente con 5-10 ml de solución fisiológica. IVI: contraindicado, se inactiva al ponerse en contacto con los glóbulos rojos.

OBSERVACIONES : Una vez reconstituida y preparada la solución, administrar inmediatamente. No refrigerar debido a que puede precipitar Uso exclusivamente hospitalario, ya que debe disponerse de monitorización electrocardiográfica y reanimación cardiorrespiratoria.

INTERACCIONES: Aminofilina, teofilina, cafeína, antagonizan los efectos de la adenosina (aumentar dosis). La carbamazepina puede incrementar el bloqueo cardíaco.La digoxina y verapamilo pueden causar fibrilación ventricular

ATC: C01EB Otros preparados para el corazon

ADRENALINA

ACCION TERAPEUTICA: Agonista adrenérgico, simpaticomimético, reacciones de hipersensibilidad, broncodilatador.
Relajación del músculo liso del árbol bronquial, estimulación cardíaca, dilatación de vasos del músculo esquelético por estimulación receptores alfa, beta 1 y beta 2. Dosis pequeñas pueden causar vasodilatación a través de receptores vasculares beta 2. Dosis grandes pueden producir constricción del músculo esquelético y liso vascular. Dilata la pupila post contracción del músculo dilatador

INDICACIÓN: Tratamiento de broncoespasmo, reacciones anafilácticas, paro cardíaco. Glaucoma de ángulo abierto

POSOLOGIA: Reanimación: Recie nacido-lactantes-niños: 0.01 mg/kg (0.1 ml/kg/dosis de solución 1: 10000) cada 3-5 min. Dosis max: 1 mg. Adultos: 1 mg/dosis. Shock: Mantenimiento: Infusión continua: 0.1-1 µg/kg/min. Niños >40 kg: Inicial: 1 µg/min hasta 10 min µg/min, ajustar la dosis hasta efecto deseado. Dosis mayores a 0.5 µg/kg/min no debe usarse por periodos prolongado

EFECTOS ADVERSOS: Palidez, taquicardia, hipertensión, incremento del consumo del oxígeno miocárdico, arritmias cardíacas, muerte subita. Ansiedad, cefalea. Náuseas. Retención acida de orina en pacientes con obstrucción vesical. Debilidad , temblor. Exacerbación del glaucoma del ángulo estrecho. Disminución del flujo sanguíneo renal y esplácnico

PRESENTACIÓN: Solución inyectable 1mg/ml. Puede contener como excipientes bisulfito de sodio,clorobutanol,ácido clorhídrico

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: Equivalencias: 1mg=1ml (1:1000)
Anafilaxia: IM- SC. Repetir dosis cada 5 a 15 minutos, hasta un total de 3 dosis. En lo posible la vía de elección es la IM profunda en cara antero lateral del muslo, incluso a través de la ropa.
Crisis respiratoria- nebulizado: 3 a 5 mg + 4 ml de S.F con oxígeno a bajo flujo 4-6 l/min. Siempre administrar asociado a corticoide.
PCR: IVD: diluir 1ml en 9 ml de S.F o agua para inyección quedando una concentración de 1:10.000, administrar de forma lenta, tras cada dosis es preciso lavar la vía con bolos de 5-10 ml de S.F. Repetir cada 3 a 5 minutos. Dosis máxima 1 mg/ dosis. Estable 24 hs a temperatura ambiente. IVC: Diluir en 100 ml de solución fisiológica de 0,1 – 1mcg/kg/min. Proteger de la luz. Es estable 24hs a T° ambiente.
Endotraqueal: 0,1mg/kg (0.1ml/kg de adrenalina 1:1000, 1ml/1mg) máximo de 2,5mg, luego lavar con 2,5-5ml de solución fisiológica

OBSERVACIONES : Hipersensibilidad a la adrenalina o cualquiera de sus excipientes.
Arritmias cardíacas, glaucoma de ángulo cerrado. Proteger de la luz. No administrar si aparece coloración parda o rosácea. Incompatible con soluciones alcalinas por ej. Bicarbonato de sodio.

INTERACCIONES: Junto con anestésicos por inhalación halogenados, fármacos bloqueadores beta (propranolol); fármacos bloqueadores alfa (fentolamina),fármacos bloqueadores alfa y beta (labetalol), fenotiazinas con actividad bloqueadora alfa incrementan la irritabilidad cardíaca. Los antidepresivos tricíclicos aumentan la respuesta presora a la adrenalina.

ATC: C01C - Estimulantes cardiacos (excepto glucósidos cardiacos)

AGUA ESTERIL

PRESENTACIÓN: Ampollas x 5 - 10 Ml

ATC: V Varios V 03 Otros Preparados Terapeuticos

ALBUMINA HUMANA

ACCION TERAPEUTICA: Coloide natural que estabiliza el volumen hemático circulante; es portadora de hormonas, enzimas, medicamentos y toxinas.

INDICACIÓN: Restablecimiento y mantenimiento del volumen circulatorio cuando se haya demostrado un déficit de volumen y el uso de un coloide se considere apropiado.
POSOLOGIA: La dosis necesaria depende del peso del paciente, de la gravedad del traumatismo o de la enfermedad y de las pérdidas continuadas de fluidos y proteína. La dosis necesaria se basará en la medición del volumen circulante y no en la determinación de los niveles plasmáticos de albúmina.
EFECTOS ADVERSOS: Raramente pueden aparecer reacciones leves como, por ejemplo, sofoco, urticaria, fiebre y náuseas. Si existen sospechas de reacciones alérgicas o anafilácticas, se debe suspender de inmediato la perfusión.
PRESENTACIÓN: Albúmina Sérica Humana 20 % UNC por 50, 20 y 10 ml.
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: Concentración: albumina al 20% (200mg/ml) ***Concentración de la dilución*** IV: su administración puede ser directa sin diluir o diluir en dextrosa al 5% o solución fisiológica. Concentración recomendada: 50mg/ml. Máxima concentración: 200mg/ml. Adecuar la concentración y el ritmo de infusión a los requerimientos individuales según monitoreo hemodinámica y no según dosaje de niveles de albumina ni según niveles de PCO. Puede ser administrada pre infusión seguida de la Furosemida EV. Infundir en 4hs.
OBSERVACIONES: Administrar directamente por vía intravenosa o también se puede diluir en una solución isotónica . No diluir en agua destilada puede provocar hemolisis. No mezclar con otras drogas, sangre o plasma. No conservar una vez abierto.
ATC: B05 Sustitutos de la Sangre y Soluciones para perfusion B05AA Sustitutos de la Sangre y Fracciones proteicas del Plasma

ALLOPURINOL
ACCION TERAPEUTICA: Hipouricemiante. Antigotoso.
INDICACIÓN: Niños y adolescentes, nefropatía por ácido úrico durante el tratamiento de la leucemia. Adultos: hiperuricemias primarias y secundarias. Gota. Nefropatía errática. Nefrolitiasis por ácido úrico.
POSOLOGIA: En niños: 10mg/kg/día. En insuficiencia renal: comenzar con 100mg. Tomar los comprimidos después de las comidas.
EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, urticaria, fiebre, artralgia, síndrome de Stevens-Johnson.
PRESENTACIÓN: Comprimidos 150 mg y 300 mg.
OBSERVACIONES: Ingerir no menos de 2 litros de líquido por día y mantener el pH urinario entre 6,4 y 6,8.
INTERACCIONES: El allopurinol asociado a citostáticos aumenta la incidencia de discrasias sanguíneas. El allopurinol inhibe el metabolismo de azatioprina y tioguanina; con amoxicilina y ampicilina aumenta la incidencia de rash cutáneo; el hidróxido de aluminio disminuye la absorción de allopurinol. aumenta el riesgo osteomalacia en pacientes que reciben fenitoína o fenobarbital.
ATC: M04 Preparados antigotosos. M04AA Preparados que inhiben la producción de ácido úrico

AMIKACINA
ACCION TERAPEUTICA: Antibiótico aminoglucósido inhibicion de sintesis de proteinas que actuan sobre los ribosomas
INDICACIÓN: Antimicrobiano frente a bacterias gramnegativas (incluidas muchas resistentes a la gentamicina y/o la tobramicina), con alguna cobertura de bacterias grampositivas (estafilococos principalmente, aunque muestra sinergia en combinación con antibióticos β-lactámicos frente a otros tipos de microorganismos grampositivos).
POSOLOGIA: 15 mg/kg/día cada 24 hs, dosis máxima: 1500 mg/día. Fibrosis quística: 30 mg/kg/día cada 24 hs. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal*. .
EFECTOS ADVERSOS: Ototoxicidad, nefrotoxicidad, bloqueo neuromuscular.
PRESENTACIÓN: Ampolla de 2 ml: 250 mg/Ml

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: **Concentración de la dilución**: IVI: Diluir en DX 5% o SF a una Concentración Recomendada: 0,25-0,5 mg/ml. Máxima concentración: 5-10mg/ml. Infundir de 60 minutos a 2 horas.
Estabilidad: vial exclusivo de un solo uso. Por estabilidad microbiológica, se recomienda que una vez abierto desechar.
IM: administración profunda directa sin diluir

OBSERVACIONES: No administrar por vía IV directa. Administrar céfalosporinas o penicilinas 1 hora antes o después. Administrar por infusión en forma lenta (más de 30 minutos).

INTERACCIONES: Inactivación mutua con: ß-lactámicos (mezclas extemporáneas). Eliminación renal disminuida por: indometacina. Aumenta riesgo de oto, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular con: aminoglucósidos, capreomicina, antibióticos polipeptídicos. Aumenta riesgo de nefrotoxicidad con: anfotericina, clindamicina, vancomicina, inmunosupresores, citotóxicos, cefalosporinas, metoxiflurano. Aumenta ototoxicidad con: ác. etacrínico, furosemida. Aumenta bloqueo neuromuscular de: sales de Mg, hidrocarburos halogenados, transfusión masiva de sangre citrada, pancuronio, tubocurarina, malation, analgésicos opiáceos. Disminuye acción de: fármacos utilizados en tratamiento de miastenia gravis. Enmascaramiento de ototoxicidad por: antihistamínicos, buclizina, ciclizina, loxapina, meclozina, fenotiazinas, tioxantenos, trimetobenzamida

ATC: J01GB Otros Aminoglucosidos

AMINOFILINA

ACCION TERAPEUTICA: Aumenta la contractilidad diafragmática.

INDICACIÓN: Apnea del recién nacido.

POSOLOGIA: Dosis ataque E.V.: 7 mg/kg/dosis en 20-30 minutos. Dosis mantenimiento: 1-6 meses: 0,4 mg/kg/hora, 6-12 meses: 0,6 mg/kg/hora, 1-9 años: 0,8 mg/Kg/hora, > 10 años y adultos: 0,7 mg/kg/hora. Apnea del recién nacido: dosis de carga: 5 mg/kg, mantenimiento: 5 mg/kg/día cada 12 hs (monitorear niveles séricos para determinar la dosis apropiada).

EFECTOS ADVERSOS: Irritabilidad, inquietud, convulsiones, cefalea, insomnio, palpitaciones, hipotensión, extrasístoles, hiperglucemia, dolor abdominal, vómitos.

PRESENTACIÓN: Ampollas de 10 ml: 24 mg/ml

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD:
Concentración de la dilución IV: administrar 25 mg/ml (Poco recomendado para pediatría). IVI: diluir en SF o DX 5% a una Concentración Recomendada de 1mg/ml. Máxima concentración: 5 mg/ml. Infundir de 20-30 minutos. IVC: diluir en SF o DX 5% a una concentración: 2mg/ml. Infundir 0,1-1mg/kg/h (según edad)

OBSERVACIONES:Concentración sérica: apnea primaria R.N.: 3-10 µg/ml, broncodilatador pico 10-15 µg/ml. Para su administración diluir con solución fisiológica (preferentemente) o dextrosa 5% a una concentración de 1 mg/ml (máxima concentración: 25 mg/ml).Proteger de la luz durante su administración. El paciente debe estar en posición supina durante su administración

ATC: R03 Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias. R03D Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, inhalatorios para uso sistémico. R03DA Xantinas

AMIODARONA

ACCION TERAPEUTICA: Antiarritmicos

INDICACIÓN: Arritmias ventriculares.

POSOLOGIA: E.V.: Ataque: 5 mg/kg en goteo en 15 minutos; luego 5 mg/kg/día en infusión continua. V.O.: Mantenimiento: 10 mg/kg/día (máximo: 200 mg/dosis) cada 12-24 hs durante la primera semana, luego continuar a 5 mg/kg/día. Adultos: V.O.: dosis de carga: 800-1600 mg/día cada 12-24 hs durante 1-3 semanas, luego 600-800 mg/día, mantenimiento: 200-400 mg/día. Reducir la dosis en insuficiencia hepática.

EFECTOS ADVERSOS: Infiltrados pulmonares, fibrosis pulmonar, microdepósitos corneanos asintomáticos (controlar con lámpara de hendidura cada 6 meses), fotosensibilidad cutánea, hipo e hipertiroidismo, polineuropatías. QT prolongado.

PRESENTACIÓN: Comprimidos: 200 mg; Ampollas de 3 ml: 50 mg/ml

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: La dosis de carga se realiza en 30 minutos, seguida de la perfusión continua, diluir con DX 5% a una concentración recomendada de 1-6mg/ml. Máxima concentración: 6mg/ml. En emergencias: 15mg/ml. Infundir de 30 minutos a 2 horas. Concentraciones mayores a 2mg/ml, infundir por más de 1h por vía central.
OBSERVACIONES: Incompatible con bicarbonato. V.O.: administrar con alimentos.
INTERACCIONES: Digoxina (amiodarona aumenta la concentración de digoxina, reducir la dosis de digoxina aproximadamente el 50% y monitorear niveles de digoxina), beta-bloqueantes y bloqueadores de los canales del calcio (aumenta riesgo de bradicardia), difenilhidantoína (aumenta cc. sérica de fenitoína y disminuye la de amiodarona). Evitar la exposición al sol. Esta droga es muy eficaz pero debe ser usada con controles seriados, por sus efectos adversos.
ATC: C01A Glucósidos cardíacos. C01B Antiarrítmicos de clase I y III. C01BD Antiarrítmicos de clase III.

AMLODIPINA
ACCION TERAPEUTICA: Hipertensión. Bloqueante de los canales de calcio.
INDICACIÓN: HTA esencial. Angina de pecho vasoespástica y estable crónica.
POSOLOGIA: Niños: inicial: 0,06 mg/kg/día (hasta 5 mg/día), una vez por día; dosis máxima: 0,6 mg/kg/día, (hasta 10 mg/día). Adultos: inicial: 5 mg una vez por día, mantenimiento: 5 - 10 mg una vez por día.
EFECTOS ADVERSOS: Palpitaciones. edema periférico, cefalea, mareos, fatiga, angina, arritmia cardíaca (raro).
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 5 - 10 mg
OBSERVACIONES: No discontinuar abruptamente la droga.
ATC: C08 Bloqueantes de canales de calcio. C08C Bloqueantes selectivos de canales de calcio con efectos principalmente vasculares. C08CA Derivados de la dihidropiridina

AMOXICILINA
ACCION TERAPEUTICA: Antibiótico betalactámico inhibe la sintesis de pared celular bacteriana.
INDICACIÓN: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, infecciones en piel por microorganismos sensibles. Profilaxis de endocarditis.
POSOLOGIA: **Faringitis estreptococcica**: 50 mg/kg/día cada 8 - 12 hs (10 dias). **Infecciones respiratorias (otitis media aguda, sinusitis, neumonía)**: 80-90 mg/kg/día cada 8 - 12 hs; **Impetigo y celulitis por microorganismos sensible** *(Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus meticilino sensible) :* 40-50 mg/k/dia cada 8 hs. **Profilaxis esplenectomía**: < 5 años: 25 mg/kg/día cada 24 hs; **profilaxis endocarditis:** niños: 50 mg/kg, 1 hora antes del procedimiento. **Dosis máxima:** 3 g/día. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Reacciones de hipersensibilidad (el rash aparece en 5-10 % de los pacientes), vómitos, diarrea, anemia, trombocitopenia, eosinofilia, neutropenia. Existe un 10% de reacción cruzada con cefalosporinas.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 250-500 mg Suspensión.: 50-100 mg/ml
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: VO: Se puede administrar con alimentos. SNG: Polvo para suspensión oral en frasco. Conservar refrigerada. Estabilidad: 14 días. Agitar cada vez antes de usar.
ATC: J Antiinfecciosos en General para uso sistemico. J01C Antibacterianos betalactámicos, penicilinas

AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO
ACCION TERAPEUTICA: Asociación de penicilina semisintética, amoxicilina y de molécula inhibidora de β-lactamasas (ácido clavulánico) que transforma en sensibles a la amoxicilina a gérmenes productores de β-lactamasas *(Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli)*.
INDICACIÓN: tratamiento de infecciones respiratorias bajas, otitis media, sinusitis, piel y partes blandas. Infecciones tracto urinarias (ITU) causadas por microorganismos sensiblesT
POSOLOGIA: Dosis calculada en basa a amoxicilina: **Neumonia por broncoaspiracion**: 80-90 mg/k/dia cada 8 hs., **OMA y sinusitis:** 80-90 mg/k/dia cada 8-12 hs. Infeccion de tracto urinario **:** 40-50 mg/k/dia cada 8 hs., **Infeccion de piel y partes blandas:** 40-50 mg/k/dia cada 8-12 hs. **Dosis maxima**: Amoxicilina: 3 g/día, Acido Clavulánico: 15 mg/kg/día, sin superar 375 mg/día. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS:Similares a la ampicilina. Disturbios gastrointestinales, diarrea, elevación de transaminasas y bilirrubina, nefritis intersticial, reacciones de hipersensibilidad. Raros: leucopenia, neutropenia, eosinofilia.

PRESENTACIÓN: **Amoxiclina/clavulanico 4/1**: Susp: AMX125mg/clav 31.25mg en 5 ml; AMX:250mg/clav 62.5mg en 5 ml, Comprimidos: 500/125 mg; **Amoxiclina/clavulanico 7/1 DUO**: Susp: AMX 400mg/clav 57mg en 5 ml, Comprimidos 875/125 mg. ; **Amoxiclina/clavulanico 14/1** : Susp. AMX 600mg/clav 43 mg en 5 ml
OBSERVACIONES:
ATC: J Antiinfecciosos en General para uso sistemico. J01C Antibacterianos betalactámicos, penicilinas. J01CR Combinaciones de penicilinas, incl. inhibidores de la betalactamasa.

AMPICILINA
ACCION TERAPEUTICA: Penicilina semisintética, de acción bactericida. Actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana
INDICACIÓN: Neumonia y neumonia con derrame, Otitis, Sinusitis, Meningitis, Endocarditis.
POSOLOGIA: **Neumonía aguda de la comunidad (NAC):** 200 mg/kg/día cada 6 hs; **Neumonia con derrame:** 300 mg/k/dia cada 6 hs. **Otitis y sinusitis:** 100 mg/k/dia cada 6 hs. **Meningitis y Endocarditis**: 300 - 400 mg/kg/día cada 6 hs. **Dosis máxima**: 12 g/día. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, diarrea, glositis, anemia, trombocitopenia, eosinofilia, eritema, rash, urticaria.
PRESENTACIÓN: F.A.:1000 mg
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: Reconstituir el FA de 500mg en 5ml AD; el FA de 1g en 10ml de AD; obteniéndose una concentración de 100mg/ml. Estabilidad: 1hs T° ambiente y 2hs refrigerada. ***Concentración de la dilución***: IVD: Diluir con solución fisiológica a una Concentración Recomendada: 50mg/ml. Máxima concentración: 100mg/ml. Infundir en 5-10 minutos. IVI: Diluir con solución fisiológica a una Concentración Recomendada: 10-20 mg/ml. Máxima concentración: 30 mg/ml. Infundir en 30 minutos. IM: Reconstituir el frasco ampolla en 3,5 ml de agua estéril o lidocaína al 1%, obteniéndose una concentración de 250mg/ml.
OBSERVACIONES: Cuando se reconstituye el F.A. con una concentración de 100 mg/ml es estable sólo por 2 hs en heladera. E.V. push administrar en 3-5 minutos, infusión intermitente 15-30 minutos. Observar signos anafilaxia durante los primeros minutos tras la administración. No usar DX 5% acelera su hidrolisis, se inactiva en 2hs. No mezclar con soluciones que contengan aminoácidos.
ATC:J01C Antibacterianos betalactámicos, penicilinas. J01CA Penicilinas con espectro ampliado.
ATC: J Antiinfecciosos en General para uso sistemico. J01C Antibacterianos betalactámicos, penicilinas

AMPICILINA + SULBACTAM
ACCION TERAPEUTICA:Antibiótico de amplio espectro inhibidor de betalactamasa
INDICACIÓN: Infecciones causadas por microorganismos sensibles: infecciones de las vías respiratorias superiores (sinusitis, otitis media, epiglotitis); neumonías bacterianas; infecciones de las vías urinarias y pielonefritis; infecciones intraabdominales (peritonitis, colecistitis, endometritis y celulitis pelviana); infecciones de piel y partes blandas y osteoarticulares. Profilaxis y tratamineto en mordeduras de animales. Meningitis y endocarditis.
POSOLOGIA: Niños E.V.: 150 mg/kg/día cada 6 hs, meningitis y endocarditis: 300 - 400 mg/kg/día c/ 6 hs, dosis máxima: 12 g de ampicilina/sulbactam. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Dolor en sitio de inyección y flebitis, diarrea, rash, náuseas, cefaleas, eritema. Leve aumento de enzimas hepáticas. Raro: alteraciones hematológicas.
PRESENTACIÓN: F.A.: 1,5 g (ampicilina:1 g + sulbactam: 0,5 g)

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD:
IV: Reconstituir el FA de 1,5gr en 3,2ml de AD; el FA de 750mg en 1,6ml de AD, obteniéndose una concentración de 250mg/ml de Ampicilina. Es estable 1hs a T° ambiente y 2hs refrigerada.
Concentración de la dilución:
IVD: Diluir con solución fisiológica a una Concentración Recomendada: 30mg/ml. Infundir en 10-15 minutos. IVI: Diluir con solución fisiológica a una Concentración Recomendada: 10-20 mg/ml. Máxima concentración: 30mg/ml. Infundir en 30-60 minutos
IM: Reconstituir el frasco ampolla en 3,2 ml de agua estéril o lidocaína al 1%, obteniéndose una concentración de 250mg/ml.

OBSERVACIONES:En pacientes con restricción de Na, debe observarse que 1500 mg de Sultamicilina contienen 5 mEq de Na. Interacciona con allopurinol (puede aumentar la frecuencia de rash por ampicilina). Prepara y usar inmediatamente. Datos consignados en base a la ampicilina. IM administrar de forma lenta.

ATC:J01C Antibacterianos betalactámicos, penicilinas. J01CG Inhibidores de la betalactamasa.

ANFOTERICINA B DEOXICOLATO

ACCION TERAPEUTICA: Antifúngico de amplio espectro, de actividad fungicida.

INDICACIÓN: Activa frente a *Candida sp.* (excepto algunas cepas de *C. lusitaniae y C. guilliermondii)*, *Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp*. (excepto *A. terreus y algunas cepas de A. flavus*), *Zigomicetos* Y agentes causantes de micosis endémicas: *Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis y Paracoccidioides brasiliensis, y frente a Leishmania sp.* **Antimicrobiano de uso restringido.**

POSOLOGIA: Iniciar 0,5 mg/kg/día, aumentar 0,25 mg/kg/día cada 24 hs. Hasta 1 mg/Kg/día, dosis máxima: 50 mg/día. Forma rápida de administración: iniciar 0,25 mg/kg e ir aumentando con intervalos de 6 hs hasta 1 mg/kg/día . No exceder de 1,5 mg/kg/día.*Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS: Fiebre, escalofríos, vómitos (relacionadas con la infusión), hipokalemia (25%), hipomagnesemia. Nefrotoxicidad: puede prevenirse con infusión salina previa. Anemia (75%). Raros: leucopenia, trombocitopenia

PRESENTACIÓN:F.A.: 50 mg

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: Reconstituir el vial con 10 ml AD (5mg/ml). Estabilidad: 24hs a T° ambiente y 48hs refrigerado. Proteger de la luz.
Concentración de la dilución: administrar solo por IV: Diluir con dextrosa al 5% a una Concentración Recomendada: 0,1mg/ml, por vía periférica. Máxima concentración: 0,5 mg/ml, por vía central. Infundir de 4-6 horas.

OBSERVACIONES: Premedicar para disminuir reacciones adversas con hidrocortisona, difenhidramina 30 min. antes de la infusión. No administrar con soluciones que contengan electrolitos. Corregir hipokalemia pre-administración.

ATC: J01 Antibacterianos para uso sistémico. J01B Anfenicoles.

ANFOTERICINA LIPOSOMAL

ACCION TERAPEUTICA: Antifúngico de amplio espectro, de actividad fungicida

INDICACIÓN: Activa frente a *Candida sp. (excepto algunas cepas de C. lusitaniae y C. guilliermondii), Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp. (excepto A. terreus y algunas cepas de A. flavus), Zigomicetos Y agentes causantes de micosis endémicas: Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis y Paracoccidioides brasiliensis, y frente a Leishmania sp.* .Fallo renal grave durante el tratamiento con anfotericina B. **Antimicrobiano de uso restringido**

POSOLOGIA: 3- 5 mg/kg/día, dosis máxima: 250 mg/día. Si la indicación es empírica o en ciertas infecciones como candidemia: 3 mg/kg/día.
Mucormicosis: 5 a 10 mg/kg/día, según los focos implicados, con compromiso del sistema nervioso central las dosis varían de 7,5 a 10 mg/kg/día. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, arritmias, fiebre, escalofríos. Menor hepatotoxicidad y nefrotoxicidad que la anfotericina B deoxicolato.

PRESENTACIÓN: F.A.: 50 mg

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: Reconstituir el vial con 10 ml de AD (4mg/ml). Estabilidad: 24hs refrigerado y protegido de la luz. ***Concentración de la dilución***: administrar solo por IV: Diluir con dextrosa al 5% a una Concentración Recomendada: 0,2-0,5mg/ml. Máxima concentración: 2 mg/ml. Infundir de 60 minutos a 2 horas.
OBSERVACIONES: No es necesaria la administración concomitante de hidrocortisona o difenhidramina. No administrar con soluciones que contengan electrolitos. No usar solución fisiológica, se solidifica. Proteger de la luz durante su administración. Lavar la vía con Dx 5% antes y después de su administración.
ATC: J01 Antibacterianos para uso sistémico. J01B Anfenicoles.

ATENOLOL
ACCION TERAPEUTICA: Betabloqueante selectivo. Hipotensor. Antagonista beta adrenérgico.
INDICACIÓN: Hipertensión esencial. Angor pectoris. Arritmias cardíacas. Coadyuvante del tratamiento de la estenosis subaórtica hipertrófica.
POSOLOGIA: Niños: inicial: 0,5 a 1 mg/kg/día cada 12 -24 hs; dosis máxima: 2 mg/kg/día, hasta 100 mg/día. Adultos: 25-50 mg/día cada 24 hs, dosis máxima: hipertensión: 100 mg/día; angina: 200 mg/día.
EFECTOS ADVERSOS: Fatiga, letargia, alucinaciones, bradicardia, hipotensión, rash, náuseas, vómitos.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 50-100 mg
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: VO: Preferentemente en ayunas.
OBSERVACIONES:Evitar la suspensión abrupta. Usar con precaución en pacientes con broncoespasmo, diabetes mellitus, hipertiroidismo. Las dosis iniciales de los antihipertensivos son tentativas, deben ser modificadas según la respuesta clínica y efectos colaterales.
ATC: C07 Agentes beta-bloqueantes. C07A Agentes beta-bloqueantes. C07AB Agentes beta- bloqueantes selectivos.

ATRACURIO
INDICACIÓN: Relajante muscular de acción periférica. Indicado en insuficiencia hepética y renal severa.
POSOLOGIA: 0,5 mg/kg Infusión continua: 0,3 mg/kg/hora
EFECTOS ADVERSOS: Liberador de histamina.
PRESENTACIÓN: Ampollas de 5 ml: 10 mg/ml
OBSERVACIONES:De uso exclusivo del especialista.
INTERACCIONES: Bloqueo neuromuscular intensificado por: anestésicos por inhalación, tales como el halotano, el isoflurano, enflurano. Intensidad y/o duración del bloqueo aumentado por: antibióticos, incluyendo aminoglucósidos, tetraciclinas, clindamicina y vancomicina, lidocaína, procainamida, quinidina, propranolol.
ATC: M03AC04. Agentes relajantes musculares de acción periférica. BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES

ATROPINA
ACCION TERAPEUTICA: Intoxicación por insecticidas órganofosforados, carbamatos, fisostigmina, pilocarpina, nafazolina. ANTIARRÍTMICO - MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉGICOS
INDICACIÓN: Bradicardia. Para reducir secreciones de vía aérea superior y salivación. Oftalmología: midriático y cicloplégico.
POSOLOGIA: 20 µg/kg/dosis (dosis mínima: 100 µg); se puede repetir en intervalos de 5 minutos hasta una dosis máxima total: niños: 1 mg; adolescentes: 2 mg
EFECTOS ADVERSOS: Midriasis, boca seca, cicloplegía, fotofobia, bradicardia seguida de taquicardia, palpitaciones, arritmias, retención urinaria, confusión, alucinaciones.
PRESENTACIÓN: Ampollas: 1 mg/ml
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV ***Concentración de la dilución***: administrar E.V: sin diluir o diluido con SF a una concentración de 0,1mg/ml. Tiempo de administración menos de 1 minuto. Se puede administrar IM y SC.
OBSERVACIONES: No administrar I.M. en neonatos. Administrar sin diluir por vía E.V. Contraindicado en obstrucción del tracto urinario y glaucoma. Para la administración intratraqueal diluir con solución fisiológica, en un volumen total de 1-2 ml. La administración lenta puede provocar bradicardia paradojal.

INTERACCIONES: Efectos aditivos cuando se administra con otros fármacos anticolinérgicos; puede alterar la respuesta a bloqueadores adrenérgicos beta.
ATC: S01ED Agentes Betabloqueantes . S01FA Anticolinergicos

AZITROMICINA
ACCION TERAPEUTICA: Macrólido. Bacteriostático. Inhibe la síntesis de proteínas actuando sobre la subunidad 50 S de los ribosomas bacterianos.
INDICACIÓN: Los microrganismos generalmente sensibles son: *Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis o Neisseria gonorrhoeae,* y otros microorganismos: *Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Mycobacterium avium, Mycoplasma pneumoniae.* Infeccion de via aerea superior e inferior, Fibrosis quistica , Infeccion de transmicion sexual (ITS), Diarrea, profilaxis endocarditis e ITS.
POSOLOGIA: 10 mg/kg/día, cada 24 hs. Niños > de 40 kg: 500 mg el 1er día y 250 mg en los días siguientes. Faringitis: 12 mg/kg/día durante 5 días. Profilaxis de micobacterias atípicas en inmunocomprometidos: 20-30 mg/kg semanal, dosis máxima: 1200 mg/semana. Profilaxis para ITS: Niños: V.O.: 20 mg/kg/dosis, única dosis; Adolescentes: V.O.: 1 g/dosis, única dosis. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Nauseas, vómitos, diarrea, rash, neutropenia, trombocitopenia, aumento de enzimas hepáticas, cefaleas y ototoxicidad.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 250-500 mg; Polvo para suspensión oral: 40 mg/ml
OBSERVACIONES: No administrar con alimentos ni antiácidos. Interacciones: carbamazepina y digoxina.
INTERACCIONES: Incrementa las concentraciones de fenitoína, fentanilo, carbamazepina, ciclosporina, digoxina. Evitar el uso con pimozida debido al riesgo de cardiotoxicidad. Los antiácidos (aluminio y magnesio) disminuyen las concentraciones séricas
ATC: J01FA Macrolidos

BETAMETASONA CREMA
ACCION TERAPEUTICA: Corticosteroides
INDICACIÓN: Tratamiendo de dermatomitosis inflamatorias y pruriginosas que responden al tratamiento corticoide
POSOLOGIA: Aplicar una capa de crema delgada para cubrir completamente el área afectada, 2 o 3 veces por día
EFECTOS ADVERSOS: Puede inhibir el eje hipofiso-suprarrenal. Hipertricosis, atrofia, hiperpigmentación.
PRESENTACIÓN: Crema: 0,05 - 0,064 - 0,1 - 0,122%
OBSERVACIONES: Uso exclusivo del especialista
ATC: D07 Preparados dermatológicos con corticoesteroides. D07AC Corticoesteroides potentes (grupo III)

BETAMETASONA+GENTAMICINA
INDICACION: Indicado en el tratamiento tópico de infecciones primarias y secundarias de la piel por bacterias susceptibles a gentamicina, acompañadas por marcada reacción inflamatoria.
POSOLOGIA: Aplicar una pequeña cantidad sobre la región afectada 2-3 veces por día. De ser necesario puede efectuarse una cura oclusiva. Máx. 2 sem, si se usa en la cara máx. 1 sem.
EFECTOS ADVEROS: Puede inhibir el eje hipofiso-suprarrenal. Hipertricosis, atrofia, hiperpigmentación.
PRESENTACION: Crema x 15 g.
OBSERVACIONES: En uso prolongado riesgo de proliferación de microorganismos no sensibles, o si aparece irritación deberá suspenderse el tto. Embarazo: No debe ser usada en grandes cantidades ni por períodos de tiempo prolongados en mujeres gestantes. cat. C. Lactancia: No deben tratarse las mamas con el preparado.
ATC: D07. Preparados Dermatologicos con Corticosteroides. D07C. Corticosteroides en asociacion con Antibioticos

BETAMETASONA GOTAS
ACCION TERAPEUTICA: Efectos antiinflamatorios, antirreumáticos y antialérgicos en el tratamiento de las afecciones que corresponden a los corticosteroides.

INDICACIÓN: Tratamiento de varias enfermedades endocrinas, osteomusculares, del colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratorias, hematológicas, neoplásicas y de otros tipos.
POSOLOGIA: La dosis inicial pediátrica usual varía de 0.017 a 0.25 mg/kg de peso corporal diarios.
EFECTOS ADVERSOS:Retención de sodio, pérdida de potasio, Debilidad muscular, Úlcera péptica con posibilidad de perforación y hemorragia subsecuente, Alteración en la cicatrización de heridas,Convulsiones,Irregularidades menstruales, desarrollo de un estado cushingoide,cataratas subcapsulares posteriores, Euforia. Contraindicada en pacientes con infecciones virales o micóticas sistémicas.
PRESENTACIÓN: Gotas. Cada gota contiene: 0.03 mg de betametasona.
OBSERVACIONES:Conservar a temperatura ambiente preferentemente inferior a 25° C. No congelar. Proteger de la luz.
INTERACCIONES: Los barbitúricos, la fenitoína, y la rifampicina disminuyen los efectos de los corticoides; los salicilatos, los AINE , los diuréticos; la cafeína y el alcohol pueden agravar el peligro de ulcera gastrointestinal. El empleo sistémico, disminuye los efectos de las vacunas hechas de virus vivos.
ATC: R01A Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico. R01AD Corticosteroides

BICARBONATO DE SODIO
ACCION TERAPEUTICA: Agente alcalinizante, antiácido. Se disocia para dar un ión bicarbonato, el cual neutraliza la concentración de iones hidrógeno y aumenta el pH sanguíneo y urinario
INDICACIÓN: Tratamiento de acidosis metabólica; antiácido; alcalinización de la orina; estabilización del estado acido básico en paro cardiaco y tratamiento de hipercalemia letal.
POSOLOGIA: Acidosis metabólica (E.V.)se aplica la fórmula siguiente. Niños: mEq HCO3- requeridos= 0,3 x déficit de base (mEq/L) x peso (kg). Adultos: mEq HCO3- requeridos= 0,2 x déficit de base (mEq/L) x peso (kg). Acidosis metabólica crónica (V.O.) mEq requeridos = déficit de base (mEq/L) x 0,6 x peso (kg). [déficit de base = concentración HCO3 sérica deseada – concentración actual]
EFECTOS ADVERSOS: V.O. Distensión gástrica y flatulencia. E.V.: Necrosis tisular por la hipertonicidad del NaHCO3 (evitar extravasación) hipernatremia, alcalosis metabólica, hipocalcemia, tetania, edema pulmonar
PRESENTACIÓN: Solución oral 1 Molar = 1 mEq Bicarbonato/ml.
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución***: EV: en emergencias diluir al 50% con AD o DX 5%. Por vía EV: en menores de 2 años diluir con AD o DX 5% a una concentración recomendada menor a 0,5 mEq/ml. Máxima concentración: 0,5mEq/ml. Mayores de 2 años: concentración recomendada: 0,5mEq/ml. Máxima concentración: 1mEq/ml. Infundir de 60 minutos a 2 horas. No conservar el sachet por inestabilidad microbiológica. VO: Se puede administrar con o sin alimentos
OBSERVACIONES: Hipersensibilidad al NaHCO3; alcalosis, hipernatremia, hipokalemia. No usar SF, por su aporte en sodio. Administrar solo por su incompatibilidad con numerosos fármacos.
INTERACCIONES: Litio, metotrexato, salicilatos, y tetraciclinas aumentan su depuración renal con orina alcalina. Los simpaticomiméticos muestran un comportamiento opuesto (menor eliminación renal)
ATC: B05BB - Soluciones que afectan el balance electrolítico.

BUDESONIDE
ACCION TERAPEUTICA: Corticoide de acción local antiinflamatoria.
INDICACIÓN: Profilaxis de asma. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa.
POSOLOGIA: Asma moderada:(aerosol) 200 - 400 µg/día cada 12 hs, asma grave: 400 - 800 µg/día cada 12 hs. Enfermedad de Crohn: 12 a 18 años (cápsulas): V.O.: 9 mg una vez al día a la mañana, la interrupción de su administración debe ser gradual. Colitis ulcerosa: 12 a 18 años: rectal (tabletas): 1 enema una vez al día a la noche. Spray nasal: > 6 años: 1 ó 2 aplicaciones en cada fosa nasal, máximo 3 aplicaciones; adolescentes y adultos: 1 ó 2 aplicaciones en cada fosa nasal, máximo 5 aplicaciones. Nebulizaciones: > 3 meses: 5 a 10 gotas (250 µg - 500 µg), 2 veces por día; adultos: 10 a 20 gotas (500 µg - 1000 µg), 2 veces por día.
EFECTOS ADVERSOS:Candidiasis, aspergilosis en boca, laringe y faringe, se aconseja el enjuague bucal después del uso del aerosol. Dosis superiores a 800 µg/día: retraso del crecimiento, puede aparecer supresión del eje hipotalámico - adrenal.
PRESENTACIÓN: Aerosol: 50 - 200 µg/dosis. Gotas para nebulizar: 1 mg/ml.

OBSERVACIONES: Sólo se usa en pacientes que requieran tratamiento crónico con corticoides. No reemplaza el efecto sistémico de corticoides.
INTERACCIONES: El ketoconazol, itraconazol, eritromicina, ritonavir, indinavir, saquinavir pueden incrementar las concentraciones sericas del budesonide
ATC: R01A Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico. R01AD Corticosteroides

CALCIO CARBONATO
ACCION TERAPEUTICA: Minerales y Oligoelementos
INDICACIÓN: Como quelante del fósforo de la dieta. Separado de las comidas aporta Ca++
POSOLOGIA: Como quelante del fósforo: 1 a 2 g de carbonato de calcio con las comidas.
EFECTOS ADVERSOS: Constipación, irritación, hemorragia, distensión gástrica, náuseas, vómitos.
PRESENTACIÓN: Comprimidos masticables: 1250 mg (500 mg de ión calcio = 25 mEq de calcio)
OBSERVACIONES: Aumenta la toxicidad de los digitálicos y reduce la absorción de tetraciclinas, quinolonas y sales de zinc. Para una óptima absorción del calcio es necesario la vitamina D.
INTERACCIONES: El calcio puede potenciar el efecto tóxico de la digoxina;:puede antagonizar a los efectos de los bloqueadores de conductos de calcio, como el verapamilo; después de ingerido dicho material disminuye la absorción de tetraciclina, atenolol, hierro, antibióticos del tipo de la quinolona, alendronato, cloruro de sodio y zinc; las dosis altas de con diuréticos tiazidicos pueden originar el sindrome de leche y alcalinos e hipercalcemia; disminuye la capacidad de sulfonato de poliestireno de ligarse al potasio
ATC: A12 Suplementos Minerales A12AA Calcio

CASPOFUNGINA
ACCION TERAPEUTICA: Antifúngico sistémico perteneciente a la familia de las equinocandinas, inhibe la sintesis de polímeros de glucano, esenciales para la estructura de la pared fúngica. Actividad concentración-dependiente.
INDICACIÓN: **Antifungico de uso restringido.** Candidiasis invasiva y Aspergilosis invasiva que son refractarios o intolerantes a anfotericina B. La eficacia y seguridad de caspofungina no ha sido suficientemente estudiada en recién nacidos y lactantes menores de 12 meses, se recomienda utilizar con precaución en este grupo de edad (indicacion off label).
POSOLOGIA: La dosificación ha de calcularse en pacientes pediátricos en función de la superficie corporal, según la fórmula de Mosteller: SC (m2)= √ (altura × peso) / 3600 (raíz cuadrada de altura en cm por peso en kg dividido por 3600). **Niños 1-17 años:** dosis de carga única de 70 mg/m2 el primer día (máximo 70 mg), seguida de 50 mg/m2/día posteriormente (máximo 70 mg al día). Si la respuesta clínica es insuficiente y el fármaco se tolera bien, se puede aumentar a 70 mg/m2/día (máximo 70 mg al día). **Recién nacidos y lactantes menores de un año**: los datos existentes son limitados, pero indican que podría emplearse dosis de 25 mg/m2/día en menores de 3 meses y de 50 mg/m2/día en pacientes de 3-12 meses.
EFECTOS ADVERSOS: Pirexia, exantema, dolor de cabeza, erupcion, hipotensión, rash, diarrea, cefalea, latido cardíaco rápido, rubor, presión arterial baja, picor, erupción, aumento de transaminasas y fosfatasa alcalina. Transtornos generales, fiebre muy frecuentes , escalofrío.
PRESENTACIÓN: F.A.: 50 mg
OBSERVACIONES: Administrar lentamente, en 1 hora. No diluir en Dextrosa. Es estable 48 hs en heladera una vez que está diluído. Interacciones: con ciclosporina puede aumentar la concentración del caspofungín (se ha observado aumento de las transaminasas), evitar; con tacrólimus puede disminuir la concentración sérica del tacrólimus. Conservar a temperatura entre 2°C y 8°C
INTERACCIONES: La administración conjunta con anfotericina B puede ser sinérgica (incluso frente a hongos resistentes como Fusarium y Zygomicetes) o aditiva. Algunos fármacos inductores enzimáticos (carbamazepina, dexametasona, efavirenz, nevirapina, fenitoína, rifampicina) aumentan el aclaramiento de caspofungina disminuyendo por tanto sus niveles plasmáticos . Valorar en estos casos aumentar la dosis diaria de caspofungina a 70 mg/día en niños a 70 mg/m2/día (máximo 70 mg/ día). El uso conjunto con ciclosporina aumenta el riesgo de elevación de transaminasas, por lo que se debe sopesar la relación beneficio/riesgo en estos pacientes y monitorizar estrechamente a los que reciben ambos fármacos. El uso conjunto con tacrolimus puede reducir la concentración plasmática de este, por lo que se deben monitorizar sus niveles plasmáticos y valorar aumento de la dosis de tacrolimus.

ATC: J02AX

CALCITRIOL- Vitamina D3 (1 alfa-25 Dihidroxicolecalciferol)
ACCION TERAPEUTICA: Hipocalcemia.
INDICACIÓN: Profilaxis y tratamiento de osteodistrofia renal. Tratamiento de hipoparatiroidismo (comienzo más rápido de acción que vitamina D2). Tratamiento de hipocalcemia en pacientes bajo hemodiálisis por insuficiencia renal.
POSOLOGIA: Insuficiencia renal: niños con hemodiálisis: 0,5 - 2 µg/día, niños sin hemodiálisis: 0.014 - 0,041 µg/kg/día, adultos: 0,25 µg/día. Hipoparatiroidismo: < 1 año: 0,04-0,08 µg/kg/día, 1-5 años: 0,25-0,75 µg/día, > 5 años y adultos: 0,5-2 µg/día. Raquitismo: 1 µg/día. Hipocalcemia: 0,25 - 1 µg/día, aumentar gradualmente hasta obtener respuesta adecuada, niños prematuros: 1 µg/día por 5 días.
EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, sequedad de la boca, constipación, sabor metálico, poliuria, polidipsia, deterioro de la función renal. Con altas dosis: hipercalcemia, hipercalciuria, nefrocalcinosis.
PRESENTACIÓN: Cápsulas: 0,25 µg
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: VO: Con o sin alimentos. Administrar por las mañanas, separar de antiácidos. No triturar.
OBSERVACIONES: Útil en insuficiencia renal porque no requiere el segundo paso de hidroxilación renal para su activación. La efectividad del calcitriol es dependiente de una ingesta adecuada de calcio. Pude antagonizar los efectos de los bloqueantes del canal de calcio. Usar con precaución cuando se administra con otras drogas que modifiquen el calcio sérico.
INTERACCIONES: Puede antagonizar los efectos de los bloqueadores de conductos del calcio al incrementar la concentración del mineral en suero; puede vincularse con los efectos tóxicos de digoxina, al aumentar los niveles de calcio; hay un incremento aditivo en los valores del mineral por una menor excreción de el, a causa de los diuréticos tiazídicos; la absorción disminuye por acción de antiácidos que contienen magnesio (posible aparición de hipermagnesemia); colestiramina, colestipol, orlistat y consumo excesivo de aceite mineral reducen su absorción; los corticoides disminuyen la absorción de calcio, lo cual antagoniza la función del calcitriol de incrementar la absorción del mineral.
ATC: A11C Vitaminas A y D, incl. combinaciones de las dos. A11CC Vitamina D y análogos

CARBAMAZEPINA
ACCION TERAPEUTICA: Anticonvulsivante. Estructura tricíclica. Inhibe canales de sodio (prolonga el tiempo inactivo) voltaje y tiempo dependientes
INDICACIÓN: Trastorno bipolar. Epilepsia. Neuralgia del trigémino. Adyuvante en el tratamiento del dolor neuropático. Uso en psiquiatría: estabilizador del ánimo, antirrecurrencial
POSOLOGIA: La dosis debe ser ajustada de acuerdo a la respuesta del paciente y a su dosaje sérico (rango terapéutico: 4 - 12 µg/ml). Los intervalos para comprimidos: cada 8-12 hs Jarabe: cada 6 hs. > 6 años: iniciar 10-20 mg/kg/día, ir aumentando hasta 35 mg/kg/día; 6-12 años: iniciar 200 mg/día, dosis mantenimiento: 400-800 mg. > 12 años y adultos: iniciar 400 mg/día, dosis mantenimiento 800-1200 mg. Dosis máxima 12-15 años: 1000 mg; > 15 años: 1200 mg; adultos: 1600 mg/día. Dolor neuropático: 10 - 30 mg/kg/día,en 2 ó 3 dosis (dosis máxima: 800 mg/día).
EFECTOS ADVERSOS: Somnolencia, mareos, erupciones cutáneas, alteraciones hematológicas (neutropenia), alteraciones hepáticas, diplopía, visión borrosa.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 200 mg; Jarabe: 20 mg/ml
OBSERVACIONES: Realizar hemograma y hepatograma cada 3-6 meses. Claritromicina, eritromicina, isoniacida, ketoconazol, itraconazol, pueden inhibir el metabolismo hepático de la carbamacepina. La carbamacepina puede inducir el metabolismo de : ciclosporina, difenilhidantoína, teofilina, ritonavir, saquinavir, delavirdina, benzodiacepinas, etosuximida, ácido valproico, midazolam, corticosteroides y hormonas tiroideas. Administrar con alimentos para disminuir los efectos gastrointestinales.
INTERACCIONES: Es inductor de CYP3 A3 y 4 por lo que disminuye niveles plasmáticos de drogas sustrato de esas isoenzimas: haloperidol, clozapina, olanzapina, risperidona, corticosteroides, otros. Las drogas que inhiben CYP3 A4 pueden inhibir metabolismo de CBZ: algunos ISRS, diclofenac, eritromicina, Ac. Valproico, jugo de pomelo, otros. La asociación de carbamazepina con otros inductores enzimáticos (antiepilépticos) pueden aumentar 10-11 epóxido y dar signos de neurotoxicidad. La carbamazepina puede ser desplazada de su unión a proteínas plasmáticas.

ATC: N03AE Derivados de la Benzodiazepina . N03AF Derivados de la Carboxamida

CARBOXIMETILCELULOSA
INDICACIÓN: Lubricante Ocular
POSOLOGIA: Se recomienda 1 o 2 gotas en el(los) ojo(s) afectado(s) 4 veces por día, o según prescripción médica
EFECTOS ADVERSOS: Puede producirse ligera visión borrosa que desaparece cuando el producto se distribuye uniformemente sobre la superficie ocular
PRESENTACIÓN: Gotas al 1 %
OBSERVACIONES: La carboximetilcelulosa al 1 % se puede intercambiar por condroitín sulfato. No intercambiar por duasorb.Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas
ATC: S01XA Otros oftalmológicos

CARVEDILOL
ACCION TERAPEUTICA: Cardiotonicos
INDICACIÓN: Insuficiencia cardíaca congestiva. Antagonista alfa y beta adrenérgico.
POSOLOGIA: Insuficiencia cardíaca congestiva: niños: inicial: 0,08 mg/kg/dosis cada 12 hs durante 2 semanas, luego duplicar cada 2 semanas si es bien tolerada hasta un rango de dosis de mantenimiento de 0,3 a 0,7 mg/kg/día cada 12 hs (máximo: 50 mg/día); adultos: inicial: 3,125 mg cada 12 hs, si es tolerada puede duplicarse cada 2 semanas hasta una dosis máxima de 25 a 50 mg, 2 veces por día. Hipertensión: niños y adolescentes: inicial: 0,1 mg/kg/dosis (hasta 12,5 mg) cada 12 hs; dosis máxima: 0,5 mg/kg/dosis (hasta 25 mg) cada 12 hs.
EFECTOS ADVERSOS:Mareos, hipotensión, cefalea, fatiga, hiperglucemia, aumento de peso, diarrea, bradicardia, palpitaciones, etc.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 3,125 - 6,25 mg
OBSERVACIONES: Administrar con alimentos. Es contraindicado su uso en insuficiencia hepática.
INTERACCIONES: Clonidina aumenta niveles séricos del carvedilol. Carvedilol puede aumentar niveles séricos de ciclosporina; puede aumentar los efectos de otras drogas como digoxina, prazosín, adrenalina. Carvedilol puede enmascarar la taquicardia de la hipoglucemia causada por la insulina y los hipoglucemiantes orales. Rifampicina puede reducir la concentración plasmática del carvedilol hasta un 70%. Disminuye su efecto betabloqueante cuando se administra conjuntamente con antiácidos, bloqueantes de los canales de calcio, colestiramina, antiinflamatorios no esteroides, ampicilina y salicilatos
ATC: C07 Agentes beta-bloqueantes C07AG Agentes bloqueantes alfa y beta

CEFALEXINA
ACCION TERAPEUTICA: Cefalosporina de primera generación. Acción bactericida. Inhibe la síntesis de la pared bacteriana.
INDICACIÓN: Infecciones por bacterias sensibles de vías urinarias, piel y partes blandas, adenitis bacteriana y osteoarticulares
POSOLOGIA: **Infecciones de vias urinarias piel y partes blandas y adenitis**: 50-75 mg/kg/día cada 6 - 8 hs, **neumonia por SAMS** 50-100 mg/kg/día cada 6-8 hs (dosis maxima 3 g/dia), **infecciones osteoarticulares** 100-150 mg/k/dia cada 6-8hs (dosis máxima: 4 g/día). *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, diarrea leve, reacciones alérgicas, prurito, cefaleas, neutropenia, sobreinfecciones micóticas. Nefrotoxicidad (2%).
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 500 mg; Jarabe: 100 mg/ml
OBSERVACIONES: Administrar con el estómago vacío. No debería utilizarse para la profilaxis de infección urinaria en niños mayores a 2 meses para evitar la emergencia de cepas resistentes.
INTERACCIONES: Con probenecid produce aumento de la excreción renal.
ATC: J Antiinfecciosos en General para uso sistemico. J01D Otros antibacterianos betalactámicos . J01D B Cefalosporinas de 1ª generación

CEFALOTINA SODICA

ACCION TERAPEUTICA: Cefalosporina de primera generación. Betalactamico. Bactericida.
INDICACIÓN: Infecciones por bacterias sensibles de vías urinarias, piel y partes blandas, adenitis bacteriana y osteoarticulares
POSOLOGIA: 100 mg/kg/día cada 6 hs Adultos: 500-2000 mg cada 6 hs. Dosis máxima: 12 g. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Reacciones alérgicas, tromboflebitis , trombocitopenia, leucopenia, nefrotoxicidad.
PRESENTACIÓN: F.A.: 1000 mg
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: Reconstituir el vial con agua destilada a una concentración de 100mg/ml. Es estable 12hs a T° ambiente y 24días refrigerado. ***Concentración de la dilución***: IVD: Diluir con dextrosa al 5% o solución fisiológica a una Concentración Recomendada: 50mg/ml, Máxima concentración: 100mg/ml. Infundir de 3-5 minutos. IVI: Concentración Recomendada: 20mg/ml. Concentración Máxima: 50mg/ml. Infundir durante 30 min. IM: Reconstituir en 4ml de lidocaína al 1%, obteniéndose una concentración de 225mg/ml. No reconstituir el vial con solución fisiológica. Su administración IM es muy dolorosa.
OBSERVACIONES: Asociada con aminoglucósidos puede aumentar riesgo de nefrotoxicidad. El cambio de color no indica inactividad.
ATC: J Antiinfecciosos en General para uso sistemico. J01D Otros antibacterianos betalactámicos . J01D B Cefalosporinas de 1ª generación

CEFAZOLINA
ACCION TERAPEUTICA: Cefalosporina de primera generación. Betalactamico. Bactericida.
INDICACIÓN: En Hospital Infantil , antibiotico de uso restringido para profilaxis quirurgica (**ver indicaciones en PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DEL SITIO QUIRÚRGICO Y PROFILAXIS ANTIBIOTICA** https://sites.google.com/view/sitio-de-ceci-him/inicio **)**
POSOLOGIA: Profilaxis quirurgica segun indicacion : 30 mg/k/dosis. Maximo 1 gr. dosis. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Reacciones alérgicas, tromboflebitis , trombocitopenia, leucopenia, nefrotoxicidad.
PRESENTACIÓN: F.A.: 1000 mg
OBSERVACIONES: Los niveles altos de cefazolina, particularmente en fallo renal, pueden aumentar el riesgo de crisis en pacientes epilépticos con bajo umbral.
ATC: J Antiinfecciosos en General para uso sistemico. J01D Otros antibacterianos betalactámicos . J01D B Cefalosporinas de 1ª generación

CEFIXIMA
ACCION TERAPEUTICA: Cefalosporina de tercera generacion.
INDICACIÓN: Opcion terapeutica para secuenciar pasaje via oral en infecciones respieratorias altas y bajas, infecciones de vias urinarias, otorrinolaringologicas y diarreas por organismos sensibles, **cuando no exista otra opcion teraputica.**
POSOLOGIA: 8 mg/kg/día, cada 24 hs. Dosis máxima: 400 mg/dia. Ver tabla de ajuste de dosis en I.R.
EFECTOS ADVERSOS: Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 400 mg; Suspensión: 20 mg/ml. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
OBSERVACIONES: Puede tomarse con o sin alimentos.
INTERACCIONES: El probenecid disminuye la excreción renal. Puede aumentar las concentraciones de carbamazepina en suero.
ATC: J Antiinfecciosos en General para uso sistemico. J01D Otros antibacterianos betalactámicos . J01D D Cefalosporinas de 3ª generación

CEFTAZIDIMA
ACCION TERAPEUTICA: Cefalosporina de tercera generacion, amplio espectro, cefalosporina antipseudomona.

INDICACIÓN: Tratamiento de infecciones de tract respiratorio bajo, piel y partes blandas, óseas, articulares, intraabdominales, genitourinaria y sistema nervioso central por bacterias susceptibles gram negativas incluyendo Pseudomonas.

POSOLOGIA: Niños: (IV o IM) 100-150 mg/kg/día cada 8 hs, dosis máxima: 6 g. **Fibrosis quística: 150-200 mg/kg/día cada 6-8 hs,** dosis máxima: 9 g. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS: Intolerancia local, hipersensibilidad, trastornos gastrointestinales.

PRESENTACIÓN: F.A.: 1000 mg

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: Reconstituir el vial con agua destilada a una concentración de 100mg/ml. Estabilidad: 8 hs a T° ambiente, 24 hs refrigeradas.
Concentración de la dilución: IVD: Diluir con dextrosa al 5% o solución fisiológica a una Concentración Recomendada: 40mg/ml, Máxima concentración: 100mg/ml. Infundir de 3-5 minutos. IVI: Concentración Recomendada: 20mg/ml. Concentración Máxima: 40mg/ml. Infundir de 15 a 30 min.
IM: Reconstituir el vial con 3,5 ml de Lidocaína al 1%, obteniéndose una concentración de 280mg/ml. Es estable 6 hs a T° ambiente.

OBSERVACIONES:El uso prolongado de ceftazidima puede provocar el sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles (Entercocci, Candida spp). Precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad gastrointestinal, especialmente colitis. Las soluciones pueden adquirir un color amarillento, no afecta su potencia. El F/A reconstituido puede contener burbujas de dióxido de carbono, que deben eliminarse por completo antes de la administración

INTERACCIONES: Probenecid disminuye la excreción renal. Con aminoglucósidos incrementan el potencial de nefrotoxicidad.

ATC: J Antiinfecciosos en General para uso sistemico. J01D Otros antibacterianos betalactámicos . J01D D Cefalosporinas de 3ª generación

CEFTRIAXONA

ACCION TERAPEUTICA: Cefalosporina de tercera generación.

INDICACIÓN: Tratamiento de sepsis, meningitis, infecciones del tracto respiratorio bajo, piel y tejidos blandos, óseas, genitourinario(ITS *Neisseria gonorroeae*), diarrea enteroinvasivas.

POSOLOGIA: Sepsis, meningitis, endocarditis y neutropenia febril oncohematologico: 100 mg/kg/día, cada 24 hs. Dosis máxima: 2 g (S.N.C.: 4 g en 2 dosis). Neumonia e infeccion tracto urinario: 80 mg/k/dia cada 24 hs. Infecciones tracto respiratorio alto, piel y tejidos blandos, oseas y diarreas: 50 mg/kg/día, cada 24 hs. (Dosis maxima 2 grs./dia). Profilaxis para ITS: Niños y adolescentes: I.M.: 125 mg/dosis, única dosis. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS: Diarrea, leucopenia, trombocitopenia transitoria, anemia hemolítica, urticaria, rash, dolor en el sitio de inyección, barro biliar, fiebre, cefalea, mareos, vértigo

PRESENTACIÓN: F.A.: 1000 mg

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: EV: Reconstituir el vial con agua destilada a una concentración de 100mg/ml. Estabilidad: 6 hs a T° ambiente y 24 hs refrigeradas.
Concentración de la dilución: Diluir con dextrosa al 5% o solución fisiológica a una Concentración Recomendada: 40mg/ml, Máxima concentración: 100mg/ml. Infundir de 3-5 minutos. EV: Concentración Recomendada: 20mg/ml. Concentración Máxima: 40mg/ml. Infundir en 30 min.
IM: Reconstituir el vial con 3,5 ml de Lidocaína al 1%, obteniéndose una concentración de 280mg/ml. Inyectar en un musculo grande de forma lenta.

OBSERVACIONES: Eliminación renal y biliar. Ajuste de dosis con clearance de creatinina < 10 ml/min.No administrar ceftriaxona simultáneamente (y dentro de las 48 h de intervalo) con soluciones intravenosas que contienen calcio. Dolor en el sitio de inyección

INTERACCIONES: Probenecid en dosis altas disminuye la vida media de eliminación de la ceftriaxona. Los aminoglucósidos pueden agravar el peligro de nefrotoxicidad.

ATC: J Antiinfecciosos en General para uso sistemico. J01D Otros antibacterianos betalactámicos . J01D D Cefalosporinas de 3ª generación

CEFUROXIMA

ACCION TERAPEUTICA. Cefalosporina de segunda generación. Endovenoso (EV)

INDICACIÓN: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio alto y bajo, otitis media, tracto urinario, piel y tejidos blandos y osteoarticulares.
POSOLOGIA: 100-150 mg/k/dia cada 8 hs. (Dosis maxima 6 grs./dia). *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Neutropenia, anemia hemolítica, cefalea, colitis pseudomembranosa, flebitis en sitio de inyección, rash, prurito anal.
PRESENTACIÓN: F.A.: 750 mg
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: EV: Reconstituir el vial en 6 ml de agua destilada, quedando una concentración de 116mg/ml. El resultado de la reconstitución se incrementa por el valor del desplazamiento del fármaco. Estabilidad: 5 hs a T° ambiente y 48 hs refrigeradas. ***Concentración de la dilución***: EV: Diluir con dextrosa al 5% o solución fisiológica a una Concentración Recomendada: 30mg/ml, Máxima concentración: 50mg/ml. Infundir de 3-5 minutos. En pacientes con restricción, concentración: 100mg/ml. EV: Concentración Recomendada: 10-15mg/ml. Concentración Máxima: 30mg/ml. Infundir en 30-60 min. IM: en 3ml de agua destilada, con una concentración de: 216mg/ml. VO: Mayor absorción cuando se administra con las comidas, aumenta la biodisponibilidad y disminuye la intolerancia gastrointestinal. Ingerir los comprimidos enteros.
OBSERVACIONES: No se recomienda como antibiótico de elección en S.N.C. por fallo de tratamiento. Ajustar dosis en insuficiencia renal. El cambio de color del vial reconstituido no implica inestabilidad.
ATC: J Antiinfecciosos en General para uso sistemico. J01D Otros antibacterianos betalactámicos . J01D C Cefalosporinas de 2ª generación

CEFUROXIMA AXETIL
ACCION TERAPEUTICA: Cefalosporina de segunda generación. Via oral (VO)
INDICACIÓN: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio alto y bajo, otitis media, tracto urinario, piel y tejidos blandos y osteoarticulares.
POSOLOGIA: 30-40 mg/k/dia **Via oral** cada 12 hs. Dosis maxima 2 grs./dia. En infecciones osteoarticulares hasta 100 mg/k/dia cada 8 hs. Dosis maxima 3 grs.
EFECTOS ADVERSOS: Diarrea, náuseas, vómitos, hipersensibilidad.
PRESENTACIÓN: Suspensión: 50 mg/ml
OBSERVACIONES: Mayor absorción cuando se administra con las comidas. Los comprimidos recubiertos y la suspensión no son bioequivalentes.
ATC: J Antiinfecciosos en General para uso sistemico. J01D Otros antibacterianos betalactámicos . J01D C Cefalosporinas de 2ª generación

CENTELLA ASIATICA, NEOMICINA, OLIGOMEROS PROCIANIDOLICOS CLEVOSAN
ACCION TERAPEUTICA: Cicatrizante. Antibiótico local
INDICACIÓN: Escaras. Ulceras de decúbito. Ulceras varicosas. Fístulas. Quemaduras.Heridas traumáticas y operatorias. Episiotomías.
POSOLOGIA: Dosis habitual: Aplicar una capa gruesa de la pomada en el sitio de la afección dos veces por día.
EFECTOS ADVERSOS: Pueden presentarse reacciones de sensibilización cutánea (prurito, ardor, erupción, eczematiforme).
PRESENTACIÓN: Pomada 60 gramos.
OBSERVACIONES:Evitar la aplicación de Clevosan (pomada) en lesiones con tendencia a macerar.
ATC: D – Terapia Dermatologica D03AX – Otros cicatrizantes

CICLOPENTOLATO
INDICACIÓN: Métodos diagnósticos en que se necesitan midriasis y ciclopejia. Agente anticolinérgico oftalmico.Midriatico. Impide que el cuerpo ciliar y el esfínter del iris reaccionen a la estimulación colinergica, lo cual origina midriasis y ciclopejia
POSOLOGIA: Niños: 1 gota de solución de 0.5 o 1 % en el ojo para aplicar una segunda gota igual en 5 min, si es necesario, 40 a 50 min antes del procedimiento oftalmológico

EFECTOS ADVERSOS: Visión borrosa, irritación ocular, fotofobia, aumento de la presión intraocular. Taquicardia, vasodilatación, ataxia, confusión, convulsiones, síndrome psicótico.

PRESENTACIÓN: Gotas: 1 %

OBSERVACIONES: No intercambiar por ningún otro colirio.

ATC: S01 Oftalmológicos S01F Midriáticos y ciclopléjicos S01FA Anticolinérgicos.

CIRPOFLOXACINA

INDICACIÓN: Fluoroquinolona. Bactericida . Conjuntivitis.

POSOLOGIA: Solución: aplicar presión digital al saco lagrimal durante la instalación y en un lapso de 1 a 2 min después de practicada

EFECTOS ADVERSOS: Quemazón o picazón, sensación de arena en los ojos, irritacion, enrojecimiento.

PRESENTACIÓN: Solución oftálmica: 3 mg/ml.

OBSERVACIONES: Conservar a temperatura ambiente, preferentemente menor a 30°C.

ATC: S01 Oftalmológicos S01AX Otros antiinfecciosos

CIPROFLOXACINA

ACCION TERAPEUTICA: Antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas, inhibe la síntesis del DNA bacteriano. Bactericida

INDICACIÓN: Tratamiento de segunda o tercera linea en infecciones de tracto respiratorio, tracto urinario, piel y tejidos blandos y osteoarticulares causados por bacterias sensibles. Tratamiento de la exacerbación pulmonar aguda por *P. aeruginosa* en pacientes con fibrosis quística. Tratamineto de segunda linea en *Mycobacterium tuberculosis.*

POSOLOGIA: Oral: 20-30 mg/kg/día cada 12 hs. (Dosis máxima: 1,5 g/día). Endovesoso: 20-30 mg/kg/día cada 12 h (Dosis máxima: 800 mg/día). Fibrosis quistica: Vía oral: 40 mg/kg/día, cada 12 horas (Dosis máxima de 1500 mg/día). Vía endovenoso: 30 mg/kg/día, cada 8-12 hs. (Dosis máxima: 1200 mg/día). *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS: Artralgias, náuseas, vómitos, cefaleas, mareos, rash, cristaluria. Rupturas tendinosas (más frecuentemente en tendón de Aquiles) a partir de las 48 hs de tratamiento.

PRESENTACIÓN: Comprimidos:500 mg .F.A.: 200 mg . Gotas oftalmológicas: 0,3%

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: EV: no requiere reconstitución. Sachet de 200mg/100ml (2mg/ml).
Concentración de la dilución: EV: la concentración, responde a la presentación (2mg/ml); en dosis bajas se puede diluir con dextrosa al 5% o solución fisiológica a una concentración recomendada de 1mg/ml. Infundir en 60 minutos. Proteger de la luz el sachet o jeringa, no requiere protección el perfus, baja fotosensibilidad.
VO: Administrar 2hs después de las comidas, preferentemente en ayunas. Ingerir los comprimidos enteros sin masticar y con un vaso de agua, adicionar varios vasos de agua a lo largo del día. No ingerir con antiácidos, lácteos, ni jugos fortificados con calcios. Los comprimidos deben digerirse entero sin masticar y con líquidos. Estabilidad: 14 días.

OBSERVACIONES: Se aconseja su uso en pediatría sólo en situaciones especiales. Administrar lejos de las comidas. Los antiácidos (que contengan calcio, magnesio o aluminio) y el sucralfato disminuyen la absorción de la ciprofloxacina si se lo administra concomitantemente. Aumenta riesgo de nefrotoxicidad con ciclosporina. Una vez abierto, si el sachet es rígido desechar, por inestabilidad microbiana; si es Flex conservar 24hs.

INTERACCIONES: Disminuye los niveles teofilina, cafeína, ciclosporina .Cimetidina aumenta los niveles de ciprofloxacina. Insulina e hipoglucemiantes orales aumenta o disminuye la glucemia. Los antiácidos a base de sales de magnesio, aluminio o calcio y sucralfato disminuye la absorción de ciprofloxacina.,Foscarnet aumenta el riesgo de convulsión. Aumenta o disminuye los niveles de fenitoína. Antiinflamatorios no esteroideos aumenta la estimulación del SNC. Probenecid disminuye el clearence de ciprofloxacina. Con warfarina produce aumento de protrombina.

ATC: J01M - Quinolonas antibacterianas

CIPOFLOXACINA + DEXAMETASONA

INDICACIÓN: Infecciones oculares causadas por microorganismos susceptibles, cuando es necesaria la acción antiinflamatoria de la dexametasona. Blefaritis, blefaroconjuntivitis y conjuntivitis causadas por gérmenes sensibles. La Ciprofloxacina es un antibiótico que pertenece al grupo de las quinolonas, con efecto bactericida contra un amplio espectro de bacterias Gram Positivas y Gram Negativas- La Dexametasona es un glucocorticoide sintético que inhibe la respuesta inflamatoria inducida por agentes de naturaleza mecánica, química o inmunológica, aliviando los síntomas de picazón, ardor, enrojecimiento y edema.
POSOLOGIA: Instilar 1 o 2 gotas cada 4 horas por un período aproximado de 7 días. Durante las primeras 24 a 48 horas, se puede aumentar la dosificación a 1 o 2 gotas cada 2 horas, según criterio médico
EFECTOS ADVERSOS: Ardor o molestia local. Congestión conjuntival levemente transitoria.
PRESENTACIÓN: Suspensión oftálmica estéril x 5 ml.
OBSERVACIONES: Conservar entre 15 °C y 30°C al abrigo de la Luz. Una vez abierto el envase utilizar dentro de los 28 días
ATC: S – Organos de los sentidos. S01 – Preparados Oftalmologicos

CITRATO DE POTASIO
ACCION TERAPEUTICA: Minerales y Oligoelementos
INDICACIÓN: Indicado en la acidosis tubular renal para alcalinización de la orina. Para disolución de los cálculos de ácido úrico y cistina del tracto urinario. Tratamiento de la acidosis matabólica crónica secundaria a insuficiencia renal crónica.
POSOLOGIA: Neonatos lactantes y niños: 2 - 3 mEq/kg/día en 3 ó 4 dosis; Adultos: 30 mEq (1 sobre) con cada comida y al acostarse. Por cada mEq de potasio se genera un mEq de bicarbonato.
EFECTOS ADVERSOS: Relacionados al aumento del potasio sérico: desgarro, confusión mental, alcalosis metabólica, diarrea.
PRESENTACIÓN: Sobres: 3000 mg de citrato de potasio = 30 mEq de potasio (UROKIT)
OBSERVACIONES: Administrar con abundante líquido (pacientes pediátricos 85 ml; adultos 170 ml de agua). Si es posble administrar agua adicional. Monitorear el potasio sérico en pacientes con disfunción renal.
ATC: G04 – Preparados Urologicos. G04BC - Disolventes de cálculos urinarios

CLARITROMICINA
ACCION TERAPEUTICA: Macrolido. Inhibe la sintesis de proteinas actua sobre ribosoma 50s
INDICACIÓN: Tratamiento de infecciones de tracto respiratorio alto y bajo en pacientes con alergia a pencilina, Neumonia aguda atipica (*Mycoplasma spp.y Chlamydia spp.*). Profilaxis y tratamiento de infecciones por *Bordetella pertusis*.
POSOLOGIA: Niños: 15 mg/Kg/día cada 12 hs, adolescentes y adultos (V.O.): 500 mg cada 12 hs. (Dosis máxima: 1 g/día.) *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Diarrea, náuseas, gusto anormal, dispepsia, dolor abdominal, cefaleas, hipersensibilidad.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 250 mg; Suspensión: 25 mg/ml; F.A.: 500 mg
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: EV: Reconstituir el vial en 10 ml de agua destilada, quedando una concentración de 50mg/ml. Estabilidad: 24 hs a T° ambiente y 48 hs refrigeradas. ***Concentración de la dilución EV*** Diluir con dextrosa al 5% o solución fisiológica a una Concentración final de 2mg/ml. Infundir en 60 minutos. VO: administrar con alimentos. La suspensión tiene una caducidad de 14 días una vez diluidas. No refrigerar
OBSERVACIONES: Interacciones: carbamazepina, cisapride, rifabutina. No refrigerar la suspensión reconstituida. No usar otro solvente de reconstitución, puede precipitar.
INTERACCIONES: Aumenta los niveles sericos de: cimetidina, ritonavir, corticoides, ciclosporina, digoxina, digitoxina, ergotamina, midazolam, triazolam, tracolimus, ac. Valproico, carbamazepina, teofilina. La rifampicina, rifabutina, efavirenz, AZT disminuyen los niveles de claritromicina. Cisapride aumenta la incidencia de arritmia y prolonga el intervalo QT en el ECG
ATC: J01F - Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas. J01FA - Macrólidos

CLINDAMICINA
ACCION TERAPEUTICA: Lincosamida. Inhibe la sintesis de proteinas actua sobre ribosoma 50s. Bacteriostatica.

INDICACIÓN: Tratamiento de infecciones por bacterias susceptibles (anaerobias, estafilococos, estreptococos, neumococos) en piel, tejido celular sucutáneo, abdomen y tracto respiratorio bajo.
POSOLOGIA: Via oral 30 mg/kg/día cada 6-8 hs, dosis máxima: V.O: 1,8 g/día. Via endovenosa : 30-40 mg/k/dia cada 6-8 hs. Dosis maxima recomendada 2.7 grs/dia. En casos graves hasta 4,8 g/día.
EFECTOS ADVERSOS: Diarrea, colitis pseudomembranosa, vómitos, reacciones de hipersensibilidad, eosinofilia, leucopenia, agranulocitosis, hepatotoxicidad.
PRESENTACIÓN: Cápsulas: 300 mg Ampollas de 4 ml: 150 mg/ml **Solucion Preparado Magistral 100 mg/mL**
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución EV*** diluir con solución fisiológica o dextrosa al 5% a una concentración recomendada de 6mg/ml. Máxima concentración: 12mg/ml. Infundir de 30-60 minutos. IM: no se recomienda la administración de más de 600mg por esta vía. VO: administrar con un vaso de agua para prevenir irritación esofágica
OBSERVACIONES: El vial una vez abierto desechar por inestabilidad microbiológica.
INTERACCIONES: Kaolina disminuye la absorción de la clindamicina. Los bloqueantes musculares, baclofeno y diazepam aumenta la frecuencia y la duración de la parálisis respiratoria. Eritromicina produce antagonismo
ATC: J01F - Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas. J01FF – Lincosamidas.

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO
INDICACIÓN: Acción antiséptica bucal. Mucositis.
POSOLOGIA: 1 buche cada 4 hs, luego de las comidas.
EFECTOS ADVERSOS: Dermatitis por contacto, erupciones, fotosensibilidad, coloración amarillenta de los dientes con el uso prolongado.
PRESENTACIÓN: Envases x 200 Ml
OBSERVACIONES: Utilizar alejado por lo menos 30 minutos del lavado de los dientes con pasta dental para evitar la reducción del efecto antiplaca de la clorhexidina. Realizar los buches previo a los buches anestésicos. No ingerir. No mezclar con la nistatina porque forma un compuesto inactivo.
ATC: D08 – Antisepticos y Desinfectantes

CLORPROMAZINA
ACCION TERAPEUTICA: Antiemético. Antipsicotico (derivado fenotiazina). Bloquea los receptores dopaminergicos mesolimbicos postsinapticos en el encefalo; presenta un efecto de bloqueo intenso adrenergico alfa y deprime la liberación de hormonas hipotalámicas e hipofisarias
INDICACIÓN: Trastornos psicóticos, eficaz en la esquizofrenia y en la fase maniaca de la enfermedad maniacodepresiva. Tratamiento de nauseas y vómitos severos. Tratamiento de problemas severos de comportamiento en niños (hiperexcitabilidad). Tratamiento coadyuvante del tétanos y en la porfiria aguda intermitente
POSOLOGIA: Neonatos: Sindrome de supresión en neonatos: IM-VO: Fase inicial: 0.5-0.7 mg/kg/dosis cada 6 horas; cambio a la forma oral después de 4 dias aproximadamente, disminuir poco a poco las dosis en un lapso de 2 a 3 semanas. Lactantes de 6 meses o mas y niños: Esquizofrenia/Psicosis: VO: 0.5 a 1 mg/kg/dosis cada 4 a 6 h. EM-IV: 0.5 a 1 mg/kg/dosis cada 6 a 8 h. DOSIS MAX: < 5 años: 40 mg/día. 5 a 12 años: 75 mg/día. Nauseas y vómitos: 0.5 a 1 mg/ kg/dosis cada 4 a 6 horas.IM-EV: 0.5 a 1 mg/ kg/ dosis cada 6 a 8 horas. Adultos: Esquizofrenia/Psicosis: VO: 30 a 800 mg/ día en 1 a 4 fracciones.(Dosis usual: 200 mg/día). IM-EV: 25 mg inicialmente para repetirlos en un lapso de 1 a 4 horas y aumentar de a poco hasta un máximo de 400 mg/dosis cada 4 a 6 horas. (Dosis usual: 300 a 800 mg/día). Nauseas y vómitos: VO: 10 a 25 mg cada 4 a 6 horas. IM-EV: 25 a 50 mg cada 4 a 6 horas.
EFECTOS ADVERSOS: Visión borrosa, Hipotensión, constipación, mareos, somnolencia, sequedad de boca, congestión nasal. Discinesia tardía, micción difícil, rash cutáneo, trastornos del ciclo menstrual, hipersensibilidad a la luz solar, galactorrea, nauseas, vómitos.
PRESENTACIÓN: Amp de 2 ml: 25 mg/ml
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: EV: Concentración de presentación: 25mg/ml. Ampollas de un solo uso. Concentraciones de la dilución EV: diluir en solución fisiológica (por mayor estabilidad) a una concentración de 1mg/ml. Infundir en 30 minutos, no es necesario proteger de la luz durante su administración. IM: 5mg/ml. Dosis máxima diaria 40mg.

OBSERVACIONES: Hipersensibilidad a la droga. Pacientes con glaucoma de ángulo agudo, supresión de medula ósea, ni enfermedades graves de hígado o corazón
INTERACCIONES: Tiene efectos aditivos con los de otros depresores del SNC; la adrenalina puede ocasionar hipotensión en pacientes que reciben clorpromazina.Los diuréticos tiazídicos pueden agravar la hipotensión ortostática que causan las fenotiazinas. Aumenta las concentraciones séricas de acido valproico, fenilhidantoina y haloperidol. Combinado con propanolol, aumenta la concentración de las 2 drogas. Disminuye los efectos de anticoagulantes orales. Los antiácidos de magnesio o aluminio disminuyen la absorción de la clorpromazina
ATC: N05 - Psicolepticos N05A – Antipsicóticos (Neurolépticos). N05AA - Antipsicóticos: Fenotiazinas

CLORURO SÓDICO (solución fisiológica)
INDICACIÓN: Deshidratación hipotónica e isotónica. Alcalosis hipoclorémica. Hipovolemia. Vehículo para administración de medicamentos y electrolitos.
POSOLOGIA: La dosificación de esta solución debe determinarse según requerimientos del medicamento al cual se pretende vehiculizar
EFECTOS ADVERSOS: Una administración inadecuada o excesiva puede dar lugar a la formación de edemas.
PRESENTACIÓN: Solución isotónica de cloruro de sodio al 0,9%. 500, 250 y 100 ml.
OBSERVACIONES:
ATC: B05B. Soluciones IV

CLORURO DE POTASIO
ACCION TERAPEUTICA: Minerales y Oligoelementos
INDICACIÓN: Hipopotasemia.
POSOLOGIA:Requerimientos de potasio: V.O./ E.V.: < 1 año: 2-6 mEq/kg/día; > 1 año: 1-3 mEq/kg/día; adultos: 40-80 mEq/día. Hipokalemia sintomática: E.V.: neonatos, lactantes, niños: 0,5-1 mEq/kg/dosis. Hipokalemia asintomática: V.O.: niños: 3 mEq/kg/día (más pérdidas concurrentes), adultos: 40-100 mEq en dosis divididas (se recomienda no superar 20 mEq/dosis).
EFECTOS ADVERSOS: E.V.: flebitis, parestesias, arritmias, bloqueo, paro cardíaco.
PRESENTACIÓN: Ampollas: 3 mEq/ml (3mEq/ml=3mMol/ml)
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: EV: diluir siempre en solución fisiológica. Concentraciones por vía periférica recomendada es 40 mEq/l, máximo 60mEq/l; por vía central se puede utilizar concentración de 80 mEq/l hasta 200 mEq/l. Velocidad de la infusión es 0,25 mEq/kg/hora, sin superar el 0,5 mEq/kg/hora.
OBSERVACIONES: Precaución en insuficiencia renal y suprarrenal. E.V: no administrar sin diluir (vía periférica: cc. de potasio menor a 60 mEq/litro por el riesgo de flebitis; vía central: 150-200 mEq/litro). Realizar monitoreo cardíaco durante la infusión. 1 g de ClK = 13,5 mEq de K. Controlar y corregir hipomagnesemia.
INTERACCIONES: Sustitutos de la sal, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los diuréticos que ahorran potasio pueden aumentar el potasio sérico. Aumenta riesgo de hiperkalemia con antiinflamatorios no esteroides, ciclosporina, digoxina, heparina, diuréticos ahorradores de potasio
ATC: B05BB - Soluciones que afectan el balance electrolítico

CLORURADA HIPERTONICA 20 % SOLUCION
INDICACIÓN: Corrección del déficit de volumen extracelular (gastroenteritis, cetoacidosis diabética, íleo y ascitis). Hiponatremia, alcalosis hipoclorémica, hipercalcemia.
POSOLOGIA: Las dosis según criterio médico serán adaptadas a la necesidad clínica del paciente en función de la edad, peso, condición clínica, del balance de fluidos, de electrolitos y del equilibrio ácido-base. Adultos y niños: la dosis depende de la edad, peso corporal, estado del paciente. Deben monitorearse las concentraciones séricas de sodio. No exceder de 1 mEq de sodio sérico/L/h (24 mEq/L/día). Requerimientos: 2 mEq/kg/día. Tratamiento hiponatremia: primero tratamiento etiológico. Hiponatremia aguda, sintomática con Na <130: (Na teórico - Na real) x 0,6 x peso (kg) = mEq Na a administrar como ClNa al 3% en 1- 4hs.
EFECTOS ADVERSOS: Edema, náuseas, vómitos.
PRESENTACIÓN: Amp.10 ml (1 ml=3,4 meq sodio equiv a 75,9 mg ó 3,4 mMol de sodio

ADMINISTRACION Y ESTABLIDAD: En casos de alteración hidroelectrolíticas: hiponatremia e hipernatremia tener en cuenta las preparaciones Estándar. Su administración y tiempo de infusión será según prescripción médica.

Solución	Na mmol/l	Preparación
Cloruro de Na al 9% en agua (Solución Fisiológica)	154	Sin preparación
Cloruro de Na al 3%	513	15ml de CL Na 20% en 85ml de agua destilada.
Cloruro de Na al 0,45%	77	11ml de Cl Na 20% en 500ml de agua o dex
Cloruro de Na al 0,25%	40	6ml de CL Na 20% en 500ml de agua o dex

OBSERVACIONES: El uso de las soluciones de cloruro de sodio en medicina, se basa en su influencia osmótica, que se determina por la concentración salina en la solución. La solución hipertónica de cloruro de sodio posee una concentración aproximada de 20 %, debido al peligro de aumento de la presión venosa; esta solución debe ser empleada con precaución y en pequeñas cantidades, para reemplazar las pérdidas de los iones sodio y cloro. Se debe emplear solamente diluída en soluciones intravenosas de gran volumen.

ATC: B05B - Soluciones endovenosas. B05BA - Soluciones para Nutrición Parenteral

COLAGENASA + CLORANFENICOL IRUXOL

ACCION TERAPEUTICA : Terapia Dermatologica

INDICACIÓN: Debridante enzimático en heridas. Debe utilizarse cuando el tejido debe ser digerido y removido.

POSOLOGIA: Aplicar en la herida 1 ó 2 veces por día. El tratamiento debe suspenderse si no se observa mejoría luego de 14 días. La aplicación debe evaluarla cirugía plástica.

EFECTOS ADVERSOS: Ardor, dolor, prurito (poco frecuente).

PRESENTACIÓN: Ungüento(cada 100 g contiene): Colagenasa 60U.I.; Cloranfenicol 1 g

OBSERVACIONES: Uso exclusivo del especialista, el Cloranfenicol de su fórmula es potencialmente productor de anemia aplásica. No debe aplicarse en los bordes de la herida y piel sana. Debe aplicarse con la herida humedecida con solución fisiológica si ésta estuviera seca.

ATC: D03 – Preparados para el tratamiento de Heridas y Ulceras (Cicatrizantes y Enzimas)

COLISTINA

ACCION TERAPEUTICA : Polimixina; altera la membrana celular de la bacteria. Bactericida

INDICACIÓN: Antimicrobiano de uso Restringido. Organismos multirresistentes.

POSOLOGIA: E.V.: 2,5 colistina base/kg/dosis cada 8-12 hs. Infecciones graves, pacientes críticos y fibrosis quística: 7 mg de colistina base/kg/día cada 8 hs. **En situaciones especiales** : Dosis de carga: 5 mg/k/dosis (unica dosis) luego continuar 5 mg/k/dia cada 8- 12 hs Dosis máxima: 100 mg/dosis. Equivalencia: 1 mg de colistimetato sódico = 12.500 UI de colistimetato sódico = 0,4 mg de colistina base. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS:Debilidad muscular, parestesia facial, disturbios visuales, nefrotóxico. Puede producir broncoespasmo cuando se nebuliza (tratar con ß-agonistas).

PRESENTACIÓN F.A.: 100 mg de colistina base

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: EV Reconstituir el FA de 100mg con el solvente de 2ml, quedando una concentración de 50mg/ml. El vial reconstituido es estable 24hs a T° ambiente y refrigerado 7 dias a temperatura 2 °C a 8°C.
Concentración de la dilución: EV diluir en Solución fisiológica o dextrosa al 5% a una concentración final de 2mg/ml. Infundir en 30 minutos.
IVC: Administrar la mitad de la dosis total diaria durante 3-5minutos. La segunda mitad de la dosis diluida en dext 5% o Solución fisiológica durante 22 o 23hs, comenzando 1-2hs después de la dosis inicial.
IM: en pacientes con función renal normal la dosis es de 2,5-5mg/kg/día, dividida en 2 a 4 administraciones

OBSERVACIONES: Aumenta el riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad con aminoglucósidos, ciclosporina, anfotericina y cisplatino. En las formas de administración EV O IM ajustar dosis en pacientes con insuficiencia renal.

INTERACCIONES: Agentes de bloqueo neuromuscular, aminoglucósidos, anestésicos generales, polimixina B y citrato de sodio potencian el efecto de bloqueo neuromuscular. La cefalotina, aminoglucósidos, anfotericina B, vancomicina y polimixina B potencian los efectos nefrotóxicos.

ATC: J01XB - Otros antibacterianos: Polimixinas

CONCENTRADO DE COMPLEJO PROTROMBINICO
ACCION TERAPEUTICA : Antihemorragicos
INDICACIÓN: Tratamiento y profilaxis de las hemorragias en la deficiencia de los factores II, VII, IX y X.
POSOLOGIA: Según indicación del especialista.
EFECTOS ADVERSOS: Potencial transmisión de agentes infecciosos.
PRESENTACIÓN: F.A.(factores II, VII, IX y X): 600 U.I., 500 U.I.
OBSERVACIONES: Útil en hepatopatías severas y R.N. de madre que ingería dicumarínicos. Dosis y duración del tratamiento deben ser reguladas según los controles de Hemostasia.
ATC: B02BD - Factores de coagulación sanguínea

DESMOPRESINA
ACCION TERAPEUTICA : Agente hemostatico, agente para tratamiento de la hemofilia, análogo sintético de vasopresina. Incrementa la reabsorción de agua en los riñones por aumento de la permeabilidad celular de los túbulos colectores; es posible que cause contracción del músculo liso y vasoconstricción; incremento del factor VIII y activador del plasminógeno plasmáticos, dependiente de la dosis.
INDICACIÓN: Diabetes insípida (antidiurético), hemofilia, enfermedad de Von Willebrand. Enuresis nocturna.
POSOLOGIA: Diabetes insípida: E.V - S.C.: 2-4 µg/día cada 12 hs; intranasal: 0,05-0,1 ml/dosis 2 veces por día; V. O. <12 años: iniciar con 0,05 mg/dosis cada 12 hs hasta respuesta (rango 0,1-0,8 mg/día) >12 años y adultos: 0,05 mg/dosis cada 12 hs hasta respuesta (rango: 0,1-1,2 mg/día cada 8-12 hs). Hemofilia, enfermedad de von Willebrand: E.V.: > de 3 meses y adultos: 0,3 µg/kg, 30 min antes del procedimiento. Enureis nocturna: intranasal: > 6 años: inicial 20 µg, rango: 10-40 µg, al acostarse; V.O.: > 12 años: 0,2-0,4 mg al acostarse. Mayor absorción en la región anterior de la fosa nasal.
EFECTOS ADVERSOS: Rubor facial, hipertensión arterial, taquicardia, cefalea, edema cerebral, hiponatremia, intoxicación hídrica, nauseas, vómitos, prurito, congestión nasal.
PRESENTACIÓN: Solución nasal (con una cánula calibrada de 0,2 ml): 0,1 mg/ml Spray nasal: 0,1 mg/ml Ampollas: 4 µg/ml Comprimidos: 0,2 mg
OBSERVACIONES: Debe ser indicado por especialistas. Se absorbe en la región nasal anterior. La dosis se adecua a la respuesta clínica individual. Conservar las ampollas y la solución nasal en heladera a 2-6°C. La desmopresina es potenciada por antidepresivos tricíclicos, carbamacepina, clorpromazina, indometacina. E.V.: diluir a una concentración máxima de 0,5 µg/ml en solución fisiológica e infundir 15-30 minutos.
INTERACCIONES: Es potenciada por antidepresivos triciclicos, carbamacepina, clorpromazina, AINES, analgésicos opioides
ATC: H01B - Hormonas del lóbulo posterior de la Hipófisis. H01BA - Vasopresina y análogos.

DEXAMETASONA
INDICACIÓN: Corticoesteroide suprarrenal; antiasmático; antiemético; antiinflamatorio. Antiinflamatorio oftálmico. Suprime la migración de leucocitos polimorfonucleares y revierte la permeabilidad capilar aumentada; suprime la respuesta inmunitaria normal. Tratamiento de la inflamación crónica, enfermedades alérgicas, hematológicas, neoplásicas y autoinmunitarias; puede utilizarse en la terapeutica del edema cerebro y choque séptico y como agente de diagnóstico; fármaco antiemético coadyuvante en el tratamiento de la emesis inducida por quimioterapia; terapeutica del edema de vías respiratorias antes de la extubación; se utiliza en recien nacidos con displasia broncopulmonar para facilitar la supresión paulatina del ventilador.
POSOLOGIA: Antiinflamatoria: 0.25-0.6 mg/kg. Edema cerebral: Dosis de carga: 1.5 mg/ml. Mantenimiento: 0.5-1 mg/kg/día cada 4 a 6 h. Adultos: Dosis de carga: 10 mg seguido por 4 mg cada 6 h. Distress respiratorio en neonatos prematuros: 0.5 mg/kg/dosis cada 12 h por 2 dosis. Antiemético (Previo a quimioterapia): EV: 10-20 mg/m2/día cada 8 h.Extubación o edema de vías aereas:VO-IM-EV:0.5-1 mg/kg/día cada 6 h, 24 h antes de la extubación. Meningitis bacteriana: EV: O.15 mg/kg cada 6 h por 4 dias. Gotas oftálmicas: cada 2-3 h.
EFECTOS ADVERSOS: Menor retención de agua y electrolitos que otros corticoides. Aumento de apetito, insomnio, hemorragia digestiva.

PRESENTACIÓN: Amp: 8 mg/2ml.Comp: 4 mg. Solución oftálmica estéril: 0.1%.

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: La ampolla de 2 ml presenta una concentración de 4 mg/ml.
Concentración de la dilución: IVD: Administrar dosis menor a 10mg con una concentración de 1-4mg/ml. Infundir 5 a 10 minutos. IVI: para dosis mayores a 10mg, diluir en S.F o S.G 5 % a una concentración recomendada de: 0,1 a 1mg/ml y pasar en 30 a 60 minutos. Es estable diluida 24 hs a temperatura ambiente. Este medicamento es de un solo uso, cualquier porción no utilizada debe desecharse.
IM: Si
VO: se puede ingerir con alimentos. Si se administra una vez al día (mañana). Se puede triturar, administrar inmediatamente.

OBSERVACIONES: No debe ser utilizada como terapia de reemplazo fisiológico.

INTERACCIONES: Barbitúricos, fenitoína, rifampicina, ritonavir, saquinavir, salicilatos, toxoides; el alcohol y la cafeína pueden incrementar los efectos GI adversos; vacunas de virus vivos (aumento del riesgo de infección viral). Antagoniza los antihipertensivos y diuréticos. Precaución en pacientes asmáticos por presentar sulfitos

ATC: H02. Corticosteroides para Uso Sistemico. H02A. Corticosteroides para Uso Sistemico,Monofarmacos

DIAZEPAM

INDICACIÓN: Anticonvulsivante benzodiazepínico. Relajante muscular. Ansiolítico.

POSOLOGIA: Status epiliéptico ataque E.V.: > 30 días y niños: 0,1-0,3 mg/kg/dosis cada 5-10 min. Dosis máxima: < 5 años: 5 mg, > 5 años: 10 mg; Adultos: 5-10 mg, puede repetirse cada 10-15 min hasta un máximo de 30 mg. Infusión E.V.: 0,1-0,2 mg/kg/hora. Convulsiones (tratamiento inmediato): 2 a 5 años: 0,5 mg/kg; 6 a 11 años: 0,3 mg/kg; > 12 años y adultos: 0,2 mg/kg. Sedación, relajación muscular o ansiedad: E.V.: 0,04-0,3 mg/kg/dosis cada 2-4 hs hasta un máximo de 0,6 mg/kg en el transcurso de 8 hs; adultos: 2-10 mg/dosis cada 6-8 hs. Pacientes en A.R.M.(E.V.): 0,2-0,4 mg/kg cada 6 hs.

EFECTOS ADVERSOS: Somnolencia, ataxia, disartria, irritabilidad. E.V.: depresión respiratoria, tromboflebitis. Efecto paradojal.

PRESENTACIÓN: Ampollas de 2 ml: 5 mg/ml

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD:Administración: E.V.: push: sin diluir y no exceder 5 mg/min, infusión continua: 0,2 mg/ml en solución fisiológica

OBSERVACIONES: Administración E.V push sin diluir y no exceder 5 mg/ml, infusión continua 0.2 mg/ml en solución fisiológica , VO administrar con los alimentos

INTERACCIONES:
Incremento de la depresión del SNC si se administra concomitantemente con neurolépticos, hipnóticos, otros ansiolíticos, antidepresivos, cisapride, cimetidina, alcohol y narcóticos.
Aumento de la toxicidad con: omeprazol, ketoconazol, valproato, fluvoxamina, etinilestradiol y menastrol.
Disminuyen el efecto del diazepam el fenobarbital, la carbamacepina, la fenitoína y la rifampicina.

ATC: N05BA01 Sistema Nervioso - Ansiolitico - TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA / MIORRELAJANTES

DICLOFENAC

INDICACIÓN: Analgésico no narcótico, antiinflamatorio no esteroide. Inhibe la síntesis de prostaglandinas por disminución de la actividad de la enzima ciclooxigenasa, que da por resultado decremento de la formación de precursores de prostaglandinas.

POSOLOGIA: Vía oral: Niños: 2 a 3 mg/kg/día divididos 2 a 4 veces día. Adultos: 100 a 200 mg/día tanto la forma sódica o potásica. Dosis máxima:225 mg/día. Solución inyectable: Intramuscular:75 mg/día. Intravenoso: 75 mg en 30 minutos a 2 horas. Dosis máxima: 150 mg /día

EFECTOS ADVERSOS: Molestias gastrointestinales, incluyendo náuseas, vómitos, ardor de estómago, indigestión, calambres, estreñimiento, diarrea, meteorismo.
- Dolor de cabeza, especialmente al principio del tratamiento.
- Alteraciones de las transaminasas (enzimas hepáticos)

PRESENTACIÓN: Solución inyectable, intramuscular/ intravenosa 75 mg/3 ml. Comprimidos recubiertos de diclofenac potásico de 75 mg (Tenemos de 50 mg comprimido por fabricacion de Farmacia Municipal)

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: presentación comercial 25mg/ml.
Concentración de la dilución IVI: diluir en 100ml de SF. Infundir de 30 minutos a 2hs. IVC: diluir en 250-500ml de SF. Infundir en 24hs.
VO: el comprimido se puede triturar pero se pierde el efecto protector de la mucosa gástrica. Se puede administrar con alimentos. Las ampollas se pueden administrar por la sonda.

OBSERVACIONES: Existen presentaciones comerciales de uso IV/IM; y otras de uso exclusivo IM.

INTERACCIONES:Puede aumentar las concentraciones séricas de digoxina, metotrexate y litio. Incrementa la nefrotoxicidad de la ciclosporina, disminuye los efectos de los diuréticos tiazídicos y la furosemida; y los efectos antihipertensivos de los IECA y los antagonistas de la angiotensina II; el diclofenac administrado junto con diuréticos ahorradores de potasio puede incrementar el potasio sérico. El diclofenac es desplazado de los sitios de unión cuando se administra conjuntamente con aspirina, disminuyendo los niveles plasmáticos . La insulina o los fármacos hipoglucemiantes orales concomitantes suelen incrementar o disminuir la glucosa sérica.

ATC:M01 Productos antiinflamatorios y antirreumáticos. M01AB Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas

DIFENHIDRAMINA

INDICACIÓN: Broncoespasmo. Asma. EPOC. Bronquitis. Profilaxis broncoespasmo inducido por ejercicio. Compite con la histamina por los sitios receptores H1 en células efectoras de tubo gastrointestinal, vasos sanguíneos y aparato respiratorio. Intoxicación con drogas que producen efectos extrapiramidales.

POSOLOGIA: ORAL: 25 a 100 mg/4-6 hs. NIÑOS menores a 12 años: 5 mg/Kg dividido en 4 dosis. – IM/IV: 10 a 50 mg/día. – PEDIATRÍA: 0,04 mg/Kg/6 hs (jarabe). Dmax 300 mg/día.

EFECTOS ADVERSOS: Somnolencia, anemia hemolítica.

PRESENTACIÓN: Amp: 10 mg/ml, Jarabe: 2,5 mg/ml.

OBSERVACIONES: Se debe repetir la dosis hasta la desaparición de los síntomas extrapiramidales.

INTERACCIONES: Sedación aditiva cuando se adminstra con fármacos que deprimen el SNC; puede deteriorar la absorcion del acido aminosalicilico.

ATC: R06A. Antihistaminicos para Uso Sistemico

DIGOXINA

INDICACIÓN: Insuficiencia cardíaca crónica. Aleteo auricular. Las acciones principales producidas en dosis terapéuticas por la digoxina son: aumento de la fuerza y velocidad de la contracción miocárdica (efecto inotrópico positivo) que resulta de la inhibición del movimiento de los iones Na+ y K+ a través de las membranas celulares miocárdicas por la formación de complejos con la adenosina trifosfatasa. Como resultado, se intensifica la entrada de calcio y aumenta la liberacion de iones calcio libre en las células miocárdicas que de manera consecuente potencian la actividad de las fibras musculares contráctiles del corazón

POSOLOGIA: Niños de 1 mes a 2 años: 0.025-0.05 mg/kg/día. > 2 años: 0.03-0.04 mg/kg/dia. Adolescentes: 0.01-0.015 mg/kg/día. DOSIS MAX: VO: 1 mg aumentar la dosis un 20 %. La dosis se administra 50 % al inicio, 25 % a las 6-8 h, 25 % restante a las 12 -16 h del inicio. En pacientes previamente digitalizados usar la mitad de la dosis. Mantenimiento: VO: Niños de 1 mes-2 años: 0.01-0.015 mg/kg/día (3/4 gota/kg/día).> 2 años: 0.01 mg/kg/día (1/2 gota/kg/día). Adolescente: 0.005 mg/kg/dia.DOSIS MAX: 0.25 mg/día.

EFECTOS ADVERSOS: Vómitos, mareos, diarrea, visión borrosa, aumento de la diuresis, sudores fríos, convulsiones, bloqueo A-V, arritmias.

PRESENTACIÓN: Comprimido 0,25 mg Gotas marca LAFEDAR: 21 gammas/gota Ampollas de 1 ml: 0,25 mg/ml

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: presentación de la ampolla 25mg/ml.
Concentración de la dilución IVD: diluir en SF o DX 5% a una concentración recomendada: 50mcg/ml. Máxima concentración: 100 mcg/ml. infundir en menos de 5 minutos.

OBSERVACIONES: No emplearse junto con preparados de calcio por vía IV. Pancuronio, succinilcolina, efedrina, adrenalina y otros agentes adrenérgicos, potencian la acción de los digitálicos. Evitar la administración oral simultánea con resinas de intercambio iónico o con antidiarreicos del tipo de los adsorbentes intestinales. Diuréticos tiazídicos,corticosteroides y amfotericina B pueden contribuir a la toxicidad digitálica. Puede contrarrestar el efecto anticoagulante de la heparina (ajustar de la dosificación).

INTERACCIONES: Con diuréticos depletores de potasio aumenta el riesgo de intoxicación digitálica. Los niveles de digoxina pueden aumentar por: amiodarona, flecainida, propafenona, espironolactona, eritromicina, verapamilo. Con corticoides aumenta riesgo de hipokalemia. Rango terapéutico: 0.8 a 2 ng/ml. Niveles > 2 ng/ml están asociados a toxicidad.

ATC: C. Sistema Cardiovascular. C01. Terapia Cardiaca. C01AA. Glucosidos Digitalicos

DIPIRONA

INDICACIÓN: Analgésico, antipirético. Dolor agudo debido a trauma o cirugía. Dolor cólico. Dolor por cáncer u otro dolor agudo severo o crónico en casos refractarios a otros analgésicos. Hiperpirexia resistente a otras drogas. Actúa tanto a nivel central como periférico. A nivel periférico por un lado inhibe la síntesis de prostaglandinas por inhibición de la enzima ciclooxigenasa, por otro lado impide la facilitación de la activación de los nociceptores por sustancias hiperalgésicas. A nivel central inhibe la biosíntesis de prostaglandinas ya que penetra fácilmente al tejido cerebral.

POSOLOGIA: 10 mg/kg/dosis cada 6 hs. Adultos: 0,5 - 1 g/dosis cada 6 hs.Dosis máxima: 4 g/día

EFECTOS ADVERSOS: Agranulocitosis, anemia aplástica, reacciones cutáneas severas, hipotensión, broncoespasmo, náuseas, vómitos, mareos, cefalea, diaforesis, anafilaxia.

PRESENTACIÓN: Ampollas: 1 g Comprimidos: 500 mg Suspensión: 50 mg/ml Gotas: 500 mg/ml (1 ml = 30 gotas, 17 mg/gota)

OBSERVACIONES:Por V.O. como droga de 3ra línea después de paracetamol e ibuprofeno. Precauciones: < de 6 meses, asociada con heparina hay riesgo de sangrado, pacientes con hepatopatías. Contraindicaciones: porfiria, leucopenia, alergia a pirazolonas, síndrome hemorrágico, .

INTERACCIONES: La dipirona en tratamiento simultáneo con ciclosporinas puede producir un descenso en el nivel de ciclosporina por lo que deben efectuarse controles regulares. Potencia los efectos de los anticoagulantes orales. La administración simultánea con clorpromazina puede causar crisis de hipotermia intensa. Puede aumentar los niveles plasmáticos de metotrexate y las concentraciones plasmáticas de litio.

ATC: N Sistema Nervioso. NO2 Analgesicos. NO2B Otros Analgesicos y Antipireticos

DIVALPROATO SÓDICO ACIDO VALPROICO

INDICACIÓN: Epilepsias generalizadas o parciales (A):

- Generalizadas primarias: crisis tónico-clónicas, atónicas, ausencias y crisis mioclónicas.
- Crisis parciales simples y complejas.
- Crisis parciales simples secundariamente generalizadas.
- Formas mixtas y epilepsias generalizadas secundarias (West y Lennox-Gastaut).

Tratamiento preventivo de cefalea primaria (E: off label).

POSOLOGIA: Dosis óptima debe determinarse según la monitorización clínica y en algunos casos hay que considerar la determinación de las concentraciones plasmáticas. VO: 10-15 mg/kg/día administrado en 2 o 3 tomas con incrementos semanales de 5-10 mg/kg/día hasta control. Para el mantenimiento de la dosis se recomienda 30-60 mg/kg/día. Los niños en tratamiento con más anticonvulsivantes pueden necesitar dosis mayores a 100 mg/kg/día en 3-4 tomas.

EFECTOS ADVERSOS: Molestias gastrointestinales (dolor, nauseas y diarrea). Incremento de peso. Síndrome de ovario poliquístico. Hepatitis. Pancreatitis. Alopecia. Trombocitopenia. Temblor. Irritabilidad. Hiperamoniemia Sobredosificación: confusión, sedación/coma, miastenia e hipo o arreflexia. Monitorizar función cardiorrespiratoria. No se conoce antídoto específico.

PRESENTACIÓN: Jarabe- Comprimido Divalproato de sodio 125 mg - 250 mg - 500 mg

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD:
Comprimidos: Preservar de la humedad y conservar a T° ambiente; pueden reblandecerse adquiriendo una consistencia pastosa, lo cual no supone perdida de actividad terapéutica.
Solución Oral: con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal. SNG: Solución comercial, concentración: 200mg/ml. Conservar a T° ambiente y protegido de la luz.

OBSERVACIONES: Solución oral: tomar en medio vaso de agua y con comidas, nunca con bebidas carbonatadas.

INTERACCIONES: Con antidepresivos triciclos, haloperidol, IMAO, y fenotiazinas puede potenciar la depresion del SNC y disminuir el umbral convulsivo. La administración con medicamentos hepatotóxicos pueden aumentar el riesgo de hepatotoxicidad. Con inhibidores de la agregación plaquetaria puede aumentar el riesgo de hemorragia. Aumenta los niveles séricos de la etosuccimida. Con barbitúricos y primidona puede aumentar las concentraciones séricas de estos debido al desplazamiento de las uniones a proteínas con el consiguiente riesgo de toxicidad neurológica y depresión del SNC

ATC: N03AG - Antiepilépticos: Acidos grasos

DOMPERIDONA

INDICACIÓN: Antiemético, antinauseoso, proquinético. Prevención de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia. Bloqueante dopaminérgico periférico. Antiemético: bloquea los receptores dopaminérgicos en la zona quimioreceptora; aumenta la velocidad de vaciado gástrico, evita el reflujo de partículas sólidas o liquidas del estómago hacia el esófago. Modificador de funciones gastrointestinales: Refuerza y regulariza la motilidad esofagogastroduodenal. Refuerza la amplitud de las ondas peristálticas primarias del esófago normalizando sus contracciones y aumentando el tono del esfínter inferior, inhibe la relajación del fundus gástrico y estimula la actividad motora antral, favoreciendo la evacuación del estómago.

POSOLOGIA:< 12 años: 0,2-0,4 mg/kg/dosis, > de 12 años: 10 - 20 mg/dosis, se puede repetir hasta 4 veces por día.

EFECTOS ADVERSOS: Produce menos efectos colaterales extrapiramidales que la metoclopramida. Hiperprolactinemia. Prolongación del QT.

PRESENTACIÓN: Gotas: 10 mg/ml (0,5 mg/gota) Ampollas pediátricas: 4 mg/ampolla

OBSERVACIONES: Hipersensibilidad a la droga. Antecedentes de disquinesias tardías iatrogénicas. Prolactinoma.Hemorragia gastrointestinal, obstrucción mecánica, perforación digestiva.

INTERACCIONES: Los antiácidos, bicarbonato de sodio, antisecretores interfieren en la absorción.

ATC: A Aparato digestivo y Vias Urinarias. A03F. Propulsivas

ENALAPRIL

INDICACIÓN: Para todos los grados de hipertensión esencial y en la hipertensión vasculorrenal (solo o asociado con antihipertensivo o diuretico). Tto y prevencion de Insuf. cardiaca sintomática. Inhibidor competitivo de la ACE; impide la conversión de angiotensina I en angiotensina II, un vasoconstrictor potente; esto resulta en concentraciones mas bajas de angiotensiona II, lo que causa un incremento de la actividad de renina en plasma y una reduccion de la secreción de aldosterona.

POSOLOGIA: VO: Niños: Inicial:0.08 mg/kg/día cada 24 h. DOSIS MAX: <12 años: 0.6 mg/kg/día. > 12 años: 40 mg/día. Adolescentes y adultos: 2.5-5 mg/dia. Dosis usual para hipertensión: 10-40 mg/día. EV: Niños: 5-10mcg/kg/ día cada 8 -24 h. Adolescentes y adultos:0.625-1.25mg/dosis cada 6 h.

EFECTOS ADVERSOS: Reacciones cutáneas, trastornos del gusto, vértigo, cefalea, neutropenia, hipotensión ortostática, tos. Teratogénico.

PRESENTACIÓN: Comp: 2.5-5-10 mg. Amp de 2 ml: 1.25 mg/ml

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: presentación de la ampolla de 2ml, contiene una concentración de 1,25 mg/ml. Concentración de la dilución: IVD: sin diluir (1,25mg/ml) en 5-15min; IVI: diluir en solución fisiológica a una concentración recomendada: 0,025mg/ml. Tiempo de infusión: mayor 60 minutos.
VO: presentación en comprimidos se puede triturar, administrar inmediatamente.

OBSERVACIONES: Controlar potasemia. Precaución en pacientes deplecionados de sodio. Es dializable. En pediatría se recomienda el uso de la infusión intermitente.

INTERACCIONES: Se potencia su efecto al administrarse junto con otros antihipertensivos. Con propanolol reduce las concentraciones sericas de enalapril. No se recomienda su utilización junto con suplementos de potasio,o diuréticos ahorradores de potasio ya que pueden producir aumento del potasio sérico.

ATC: C09. Agentes que actuan sobre el Sistema Renina - Angiotensina. C09A. Inhibidores de la ECA

ENOXAPARINA

INDICACIÓN: Profilaxis de enfermedad venosa tromboembólica, tromboembolismo venoso en pacientes postrados en cama debido a enfermedades agudas tales como insuficiencia cardíaca, falla respiratoria, infecciones graves o enfermedades reumáticas. Tratamiento de trombosis venosa profunda, con o sin embolismo pulmonar, angina inestable e infarto miocárdico no-Q. Prevención de la formación de trombos en la circulación extracorpórea durante la hemodiálisis.

POSOLOGIA: Según indicación del especialista. Dosis profiláctica: < 2 meses: 0,75 mg/kg/dosis cada 12 hs; > 2 meses: 0,5 mg/kg/dosis cada 12 hs. Dosis terapéutica: < 2 meses: 1,5 mg/kg/dosis cada 12 hs; > 2 meses: 1 mg/kg/dosis cada 12 hs

EFECTOS ADVERSOS: Trombocitopenia (raro), anemia hipocrómica, necrosis cutánea en el punto de inyección, hemorragia, fiebre, diarrea, confusión, disnea, edema.

PRESENTACIÓN: Jeringa pre llenada de 20, 40 y 60 mg.

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: En todas las presentaciones 0,1ml=10mg. Conservar a T° ambiente (no refrigerar) desechar cualquier porción no utilizada del producto.
IV: IVD: indicado solo en casos de infarto miocárdico con elevación del complejo ST. Para asegurar la precisión de pequeños volúmenes, diluir la jeringa prellenadas con SF a una concentración 3mg/ml, extraer la dosis indicada, lavar la vía antes y después de su administración con SF. El tratamiento es indicado como bolo IV único, inmediatamente seguir con administración SC. No administrar por vía IM.
SC: administrar al paciente acostado entre la pared abdominal anterolateral o posterolateral izquierda y derecha. No expeler la burbuja de aire (para evitar la pérdida de droga), introducir la aguja en forma vertical en un pliegue cutáneo sostenido entre el pulgar y el índice (no soltar hasta tanto no se haya completado la inyección). No frotar el lugar de la inyección después de la administración.

OBSERVACIONES: No administre el fármaco por vía intramuscular. Durante el embarazo y lactancia debe evaluarse el riesgo-beneficio. Antes de la terapia con enoxaparina sódica se recomienda suspender la administración de agentes que afecten la hemostasis. Se recomienda ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal severa. Usar con precaución en niños, una sobredosis puede provocar hemorragia. ***En casos de sobredosis/tratamiento: 1mg de Sulfato de Protamina neutraliza 1mg de heparina***

INTERACCIONES: Los anticoagulantes, fármacos trombolíticos, y los inhibidores plaquetarios pueden incrementar el riesgo de hemorragia.

ATC: B01AB. Grupo de la Heparina

ERITROMICINA

ACCION TERAPEUTICA : Macrolido. Bloquea la síntesis de proteínas actuando sobre los ribosomas 50 S.

INDICACIÓN: Tratamiento de infecciones de piel y del tracto respiratorio alto y bajo bacterias susceptibles (**No es de primera linea**. Opcion terapeutica en pacientes con alergia a B-lactamicos) . Tos convulsa *(Bordetella pertussis)*: tratamiento y quimioprofilaxis de contactos. De elección azitromicina o claritromicina por mejor tolerancia.

POSOLOGIA: Lactantes y niños: VO (como etilsuccinato): 30 a 50 mg/kg/día cada 6 a 8 hs. Dosis maxima: 2 g/día. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS: Disturbios gastrointestinales, sordera reversible por altas dosis, reacciones alérgicas, hepatitis colestásica, arritmias ventriculares.

PRESENTACIÓN: VO: Polvo para suspensión oral: 200 mg/5 ml. Gotas oftálmicas: 0.05 g/5 ml. Ungüento oftálmico (unidosis): 0.5

OBSERVACIONES: Usarse con precaución en la insuficiencia hepática. Anafilaxia previa a macrólidos.

INTERACCIONES: Disminuye la depuración, con el consecuente aumento de los niveles de las siguientes drogas: carbamazepina, ritonavir, digoxina, corticoides, ciclosporina, derivados de ergotamina, midazolam, fenitoína, acido valproico, tacrolimus. Con terfinadina y cisapride mayor incidencia de arritmias, prolonga el intervalo QT en el ECG

ATC: J01F. Macrolidos y otros Compuestos

ERITROMICINA LACTOBIONATO

INDICACIÓN: El ungüento oftálmico se emplea para prevenir la oftalmia gonocócica del recién nacido. . Ungüento oftálmico: limpiar frotando con suavidad cada párpado con algodón estéril; instilar un listón de ungüento de 0.5 a 1 cm. en cada saco conjuntival inferior; dar masaje en los párpados suavemente para diseminar en ungüento, después de 1 min. puede eliminarse el exceso de ungüento con algodón estéril. Gotas oftálmicas extemporáneas: la solución reconstituida debe ser conservada entre 2 a 25 °C y al abrigo de la luz. Desechar la solución reconstituida luego de 10 días de preparada.
POSOLOGIA: Cada 2-3 hs
EFECTOS ADVERSOS: El ungûento oftálmico puede producir enrojecimiento, picazón o ardor en los ojos.
PRESENTACIÓN: Gotas: 1 % Pomada oftálmica (cápsulas unidosis): 0,5 %
OBSERVACIONES: No intercambiar por otro antibiótico. La duración de las gotas reconstituidas es de 10 días.
ATC: S – Organos de los sentidos. S01 – Preparados Oftalmologicos

ERITROPOYETINA
ACCION TERAPEUTICA: Estimulante de la eritropoyesis
INDICACIÓN: Tratamiento de anemia ligada a insuficiencia renal crónica, en pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal, tratamiento en pacientes cancerosos tratados con platino, en pacientes que estén en programa de trasplante autológico
POSOLOGIA: 25 UI/kg 3 veces por semana, para ajustar la dosis en aumento o disminución de 25UI/kg y en lapsos de 4 semanas. Duración y dosis depende del especialista.
EFECTOS ADVERSOS: Rash cutáneo, síntomas gripales como cefaleas, dolores articulares, fiebre, vértigo y decaimiento. Pueden ocurrir al comienzo del tratamiento.
PRESENTACIÓN: 2000 UI/ ml., 4000UI/2 ml.
OBSERVACIONES: Suplementar con hierro previo al inicio del tratamiento.
INTERACCIONES: Con ciclosporina
ATC: B03 – Preparados Antianemicos. B03X – Otros preparados antianémicos

ESMOLOL
INDICACIÓN: Bloqueante. Hipertensión arterial post reparación de coartación, crisis de disnea y cianosis, taquiarritmia auricular ectópica. Bloquea en forma competitiva la respuesta a la estimulación adrenérgica beta, sin efecto o muy poco en receptores ß 2, excepto a dosis muy elevadas. Acción ultracorta.
POSOLOGIA: Ataque: 0,5-0,6 mg/kg en 2-4 minutos, seguido de infusión a 0,1-0,2 mg/kg/minuto
EFECTOS ADVERSOS: Hipotensión, mareos, decaimiento, cefaleas.
PRESENTACIÓN: F.A. de 10 ml: 10 mg/ml Amp. de 10 ml: 250 mg/ml
OBSERVACIONES: Vida 1/2 de eliminación: 9 minutos. El esmolol puede aumentar la concentración sérica de digoxina y teofilina. La morfina puede aumentar la concentración sérica del esmolol. La ampolla de 250 mg/ml no se puede administrar en forma directa, debe ser diluida a una concentración final de 10 mg/ml en Sol. F. o Dx 5%.
INTERACCIONES: Puede aumentar las concentraciones séricas de digoxina o teofilina, la morfina suele incrementar las concentraciones sanguíneas de esmolol, las xantinas pueden disminuir su efecto.
ATC: C07AB Agentes beta- bloqueantes selectivos.

ESPIRONOLACTONA
INDICACIÓN: Estados edematosos. Coadyuvante del tratamiento de la hipertensión. Diagnóstico y tratamiento en el corto y el largo plazo del hiperaldosteronismo primario. Prevención y tratamiento de la hipopotasemia.
POSOLOGIA: Inicial: 1 mg/kg/día cada 12-24 hs, dosis máxima: 3,3 mg/kg/día (hasta 100 mg/día). Adultos: Edema, Hipocalcemia: 25 mg - 200 mg cada 12 - 24 hs; Hipertensión: 25 mg - 50 mg/día
EFECTOS ADVERSOS: Hiperkalemia, hiponatremia, cefalea, anorexia, náuseas, diarrea, vómitos, ginecomastia en varones, disturbios menstruales en mujeres.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 25-50-100 mg; **Suspensión (preparado magistral): 5 mg/ml**
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD : VO: con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal y aumenta la biodisponibilidad. Si se administra en dosis única, dar por la mañana. Si se dan más de una dosis al día, administrar la última antes de las 18-20hs para no interferir en el descanso nocturno.

OBSERVACIONES: Contraindicado en hiperkalemia, hiponatremia, severa falla renal, anuria. Con antiinflamatorios no esteroides, ciclosporina, sales de potasio: alto riesgo de hiperkalemia. Puede ocurrir potenciación de los efectos de las drogas antihipertensivas y de otros diuréti
INTERACCIONES: Con antiinflamatorios no esteroides, ciclosporina, sales de potasio: alto riesgo de hiperkalemia. Puede ocurrir potenciación de los efectos de las drogas antihipertensivas y de otros diuréticos
ATC: C03D. Agentes Ahorradores de Potasio. C03DA. Antagonistas de la Aldosterona

ETILEFRINA
INDICACIÓN: Hipotensión aguda. Hipotensión crónica. Insuficiencia Circulatoria en diversas situaciones clínicas.
POSOLOGIA: Infusión intravenosa: si se va a administrar en forma intravenosa, se recomienda usar de preferencia una infusión. La dosis debe ser preparada para alcanzar la presión arterial y frecuencia cardíaca requerida y se debe calcular para cada paciente individualmente. Se recomienda que los pacientes que están recibiendo una infusión intravenosa sean tratados en una unidad de cuidados intensivos con monitoreo regular de ECG, presión arterial y presión venosa central. Las tasas de infusión recomendadas son: adultos y niños mayores de 6 años: 0,4 mg/min (0,2-0,6 mg/min). Niños entre 2 y 6 años: 0,2 mg/min (0,1-0,4 mg/min). Niños menores de 2 años: 0,1 mg/min (0,05-0,2 mg/min). Inyección intramuscular y subcutánea: adultos: 1,0 ml. Niños entre 6 y 14 años: 0,7-1,0 ml. Niños entre 2 y 6 años: 0,4-0,7 ml. Niños menores de 2 años: 0,2-0,4 ml. La dosis se debe repetir según se requiera a intervalos de 1 a 3 horas. Dosis máxima diaria: en general, la siguiente dosis máxima diaria no debe ser excedida: adultos y niños mayores de 6 años: 50 mg. Niños entre 2 y 6 años: 40 mg. Niños menores de 2 años: 30 mg.
EFECTOS ADVERSOS: Palpitaciones, taquicardia, ansiedad y sudoración, insomnio, náuseas, temblor y sensación de presión cefálica.
PRESENTACIÓN: Ampolla 10 mg/ml.
OBSERVACIONES: La etilefrina se potencia con calcio, antidepresivos tricíclicos. Precaucion en pacientes añosos . No administrar en primer trimestre de embarazo (2do y 3ero evaluar riesgo/beneficio) ni durante la lactancia. Contraindicado en hipertiroidismo, HTA, glaucoma, hipertrofia prostática con retención urinaria.
ATC: C01C. Estimulantes Cardiacos Excluidos Glucosidos Cardiacos. C01CA. Agente Adrenergico y Dopaminergico

FENITOINA
INDICACIÓN: Anticonvulsivante
POSOLOGIA: Dosis de carga E.V.: 15-20 mg/kg, dosis máxima: 1500 mg. Mantenimiento E.V. - V.O.: 5-8 mg/kg/día cada 12 hs. Adultos: 300 mg/día cada 8-12 hs
EFECTOS ADVERSOS: Hipertricosis, hiperplasia gingival, ataxia, nistagmo, náuseas, vómitos, alteraciones hematológicas, alteración del metabolismo del calcio. En administración rápida: arritmias.
PRESENTACIÓN: Difenilhidantoína sódica: Cápsulas: 100 mg; Suspensión: 25 mg/ml; Ampollas de 2 ml: 50 mg/ml; Difenilhidantoína cálcica: Comprimidos: 100 mg
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución:*** IVD: directa muy lentamente 1 a 3 mg/kg/min (poco recomendado en pediatría). IVI: Diluir en solución fisiológica a una concentración recomendada: 1-5mg/ml; máxima concentración: 10mg/ml. Infundir en 60 minutos. Es estable 2 hs a temperatura ambiente diluido. VO: Con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal y aumenta la biodisponibilidad.
OBSERVACIONES: Como todos los anticonvulsivantes incluidos en esta guía se recomienda su dosaje sérico debido al estrecho margen terapéutico de los mismos. Por V.O. dar alejado de lácteos. Separar 2 hs su administración de los antiácidos y de la nutrición enteral. Durante su infusión se recomienda el control de las constantes vitales. Se aconseja administrar S.F antes y después de la infusión para evitar la irritación IV local debido a la alcalinidad de la solución.
INTERACCIONES: Disminuye la concentración sérica o efectividad de: lamotrigina, ritonavir, saquinavir, acido valproico, warfarina, anticonceptivos orales, corticoides, vincristina, metotrexato, ciclosporina, dopamina, o relajantes del músculo esquelético no despolarizante. Puede afectar la unión de la fenitoína a proteínas del acido valproico o salicilatos.
ATC: NO3A Antiepilépticos

FENOBARBITAL
INDICACIÓN: Anticonvulsivante, hipnótico, sedante (barbitúrico). Tratamiento de convulsiones tónico-clónicas (gran mal) generalizadas y parciales; convulsiones neonatales; convulsiones febriles en niños; sedación; prevenir y tratar hiperbilirrubinemia neonatal y disminuir la bilirrubina en colestasis crónica
POSOLOGIA: Ataque (E.V.; I.M.): 20 mg/kg/dosis, dosis máxima: 1 g. Mantenimiento (V.O.; E.V.): 3-5 mg/kg/día cada 12-24 hs. Adultos: 100 mg cada 12 hs, dosis máxima: 600 mg.
EFECTOS ADVERSOS: Somnolencia, irritabilidad e hiperactividad, ataxia, erupción cutánea, depresión cardio-respiratoria.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 15-100 mg; Ampollas de 2 ml: 50 mg/ml
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución:*** IVD: administrar lento. IVI: diluir con SF a una concentración recomendada de 10mg/ml. Concentración máxima: 25mg/ml. Infundir 15-30 minutos. VO: se puede administrar con o sin alimentos. Si se da en dosis única, hacerlo por la noche. SNG: Se puede triturar, administrar inmediatamente
OBSERVACIONES: Administrar sin diluir o diluir con igual volumen de Sol. F. Máxima velocidad de infusión: niños: 30 mg/min, adultos o > de 60 kg: 60 mg/min
INTERACCIONES : Tanto en insuficiencia hepática como renal se recomienda monitoreo frecuente de niveles séricos, en algunos casos puede ser necesario dosis más altas y más frecuentes. Inductor enzimático, reduce concentración plasmática de: carBAMazepina, clonazePAM, lamoTRIgina, valproato. Los efectos anticonvulsivantes son antagonizados por antidepresivos y antipsicóticos.
ATC: NO3A Antiepilépticos

FENTANILO
INDICACIÓN: Mecanismo de acción similar a la morfina. Coadyuvante de la anestesia general.
POSOLOGIA: 1 - 12 años: 1 - 2 µg/kg/dosis, > 12 años y adultos: 0,5 - 1 µg/kg/dosis Intubación endotraqueal: 5-10 µg/kg Pacientes en A.R.M.: infusión continua: 1-2 µg/kg/hora.
EFECTOS ADVERSOS: Apnea, bradicardia, tórax rígido o leñoso. La reacción adversa a fentanilo más grave es la depresión respiratoria.
PRESENTACIÓN: Ampollas: 0, 05 mg/ml
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: Ampollas: Proteger de la luz. Debe utilizarse inmediatamente tras la apertura de la ampolla. Conservar a temperatura ambiente.
OBSERVACIONES: USO EXCLUSIVO DEL ESPECIALISTA. Si pasa en goteo puro se debe proteger de la luz. Push: administrar en 3-5 minutos. La sobredosis puede ser tratada con naloxona. Equivalencia analgésica: 1 µg de fentanilo = 0,1 mg de morfina
INTERACCIONES: Debe evitarse el uso simultáneo de derivados del ácido barbitúrico, ya que el efecto depresor respiratorio del fentanilo podría aumentar. No se recomienda el uso simultáneo con nalbufina podrían inducir síntomas de abstinencia en pacientes dependientes de los opiáceos. El uso simultáneo de otros depresores del SNC podría producir efectos depresores aditivos y podrían darse casos de hipoventilación, hipotensión y también sedación profunda o coma.
ATC: N01 ANESTESICOS GENERALES AH01 ANESTESICOS OPIOIDES

FOSFOMICINA
ACCION TERAPEUTICA: Antibiótico bactericida. Bloquea la síntesis de los precursores del peptidoglucano. Es activa in vitro frente a numerosas bacterias grampositivas y gramnegativas.
INDICACIÓN: Antibiotico de uso restringido. Uso de rescate cuando no hay otras opciones terapeuticas.
POSOLOGIA: Via oral: Menores de 1 año: 150-300 mg cada 8 hs. o 33-66 mg/kg cada 8 hs. Niños mayores de 1 año: 250-500 mg cada 8 horas. Via endovenosa: <10 kg: 200-300 mg/kg/día, cada 8 hs. 10-40 kg: 200-400 mg/kg/día, cada 6-8 hs. >40 kg: 12-24 g/día, cada 6-8 hs. Dosis máxima: 8 g/dosis, 24 g/día. *Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Comunes: diarrea (9%-10%), náuseas (4%-5%), cefalea (4%-10%), faringitis (2,5%), rinitis (4,5%). Serios: anemia aplásica, colestasis, necrosis hepática, megacolon tóxico, angioedema.
PRESENTACIÓN: Frasco Ampolla 1 g
OBSERVACIONES: Cada gramo de Fosfomicina contiene 14,5 mEq de sodio.

ATC: J01XX Antibacteriano.

FLUCONAZOL
ACCION TERAPEUTICA: Antifúngico. Pertenece al grupo de los triazoles. Su mecanismo de acción reduce la concentración de ergosterol, esencial para la integridad de la membrana citoplásmica fúngica. Fungistático.
INDICACIÓN: Tratamiento de la candidiasis de las mucosas (orofaríngea y esofágica), candidiasis invasiva, meningitis criptocóccica .
POSOLOGIA: La dosis diaria de fluconazol es la misma para administración oral e IV. **Niños < 12 años:** Candidiasis esofágica y orofaríngea: 6 mg/kg/día el primer dia , seguido de 3 mg/k/dia dosis máxima: 200 mg/día; Candidiasis sistémica y meningitis criptocóccica: 6-12 mg/kg/día, cada 24 hs, dosis máxima 400 mg/dia; **Niños de 12 a 17 años:** Candidiasis esofágica y orofaríngea: 200 a 400 mg/día ; Candidiasis sistémica dosis de carga de 800 mg/dia, luego 400 mg/dia. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, dolor abdominal, diarrea, alopecia reversible, nefrotoxicidad, hipokalemia, rash (monitorear), prurito, anorexia, hepatotoxicidad (raro), eosinofilia, leucopenia, trombocitopenia, neutropenia.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 100 -200 mg; F.A. de 100 ml: 2 mg/ml
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: no requiere reconstitución, presentación en sachet de 200mg/100ml. Concentración de 2mg/ml. Concentración de la dilución: administrar por vía IVI: no requiere dilución, listo para administrar con una concentración de 2mg/ml. Infundir en 60 minutos, se recomienda en dosis mayores a 6mg infundir en 2hs. La solución tiene estabilidad 24hs a T° ambiente en Sachet Flex, con puerto de inyección. De lo contrario, usar y descartar
OBSERVACIONES: Al cambiar una vía de administración a otra, no es necesario modificar la dosis diaria.
INTERACCIONES: Produce aumento de los niveles de amitriptilina, cisapride, hidantoínas, midazolam, anticoagulantes orales, rifampicina, rifabutina, tacrolimus, teofilina, zidovudina.
ATC: J02AC Terapeutica Antiinfecciosa. Antimicoticos

FLUMAZENIL
INDICACIÓN: Sobredosificación en ciertos procedimientos o intoxicación por benzodiacepinas (BDZ). Antagoniza el efecto de las benzodiacepinas en el complejo de receptor ácido gammaminobutírico/benzodiacepinas (es especifico de benzodiacepinas)
POSOLOGIA: -IV: Dosis inicial: 0,2 mg en 15 segundos. Si no se revierte el efecto de la BDZ, esperar 1 minuto y repetir la dosis con este esquema hasta un máximo de1 mg. Si el paciente no responde luego de administrar 1 mg de flumazenil, esperar 20 minutos y repetir esquema. Dmax: 3 mg/h.
EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, ansiedad, palpitaciones. En pacientes tratados con benzodiacepinas puede provocar síndrome de abstinencia que se controla con diazepam.
PRESENTACIÓN: Ampolla 0,1 mg/mL Ampolla x 5 Ml
OBSERVACIONES: Puede provocar convulsiones. También dolor en el sitio de inyección (se sugiere administrar en vena mayor). Puede producir vértigo, sudor, visión borrosa, cefalea. Sólo debe ser utilizada por anestesistas o terapistas. Se puede usar como prueba diagnóstica cuando se sospecha coma por benzodiazepina.
INTERACCIONES: Usar con cautela en sobredosis de fármacos combinados, puede ocurrir efectos tóxicos de otros medicamentos (en especial con antidepresivos tricíclicos) cuando se revierten los efectos de las benzodiacepinas
ATC: V03AB. Antidotos

FLUORESCEÍNA SÓDICA
INDICACIÓN: Medio de diagnóstico.
POSOLOGIA: Segun indicacion médica
EFECTOS ADVERSOS: Conjuntivitis alérgica, edema periorbital.Puede apareser visión borrosa transitoria. Informar a los pacientes que no deben conducir o manejar maquinaria hasta que la visión sea nitida.
PRESENTACIÓN: Frasco de 5 ml: 10 %
OBSERVACIONES: No se debe aplicar la solución de fluoresceína mientras el paciente tenga colocadas lentes de contacto, ya que las mismas pueden colorearse
ATC: S – Organos de los sentidos. S01 – Preparados Oftalmologicos

FUROSEMIDA
INDICACIÓN: Edema asociado con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal y subsiguientes a quemaduras. Coadyuvante en el tratamiento del edema agudo de pulmón. Sostén de diuresis forzada en envenenamientos. Hipertensión ligera a moderada, generalmente asociada con antihipertensivos. Inhibe la resorción de sodio y cloruro en el asa ascendente de Henle y en el túbulo renal distal. Interfiere con el sistema de cotransporte de unión de cloruro y origina así un incremento de la excreción de agua, potasio, sodio, cloruro, magnesio y calcio.
POSOLOGIA: Lactantes y niños: EV: 1 mg/kg/dosis cada 6-12hs. Infusión continua: 0,05 mg/kg/hora. VO: Inicial: 0.5-2mg/kg/dosis cada 12-24 hs. DOSIS MAX: 6 mg/kg/día. Adultos: VO-EV: 20-80 mg/día cada 6 a 12 hs. DOSIS MAX: 600 mg/día
EFECTOS ADVERSOS: Ototoxicidad, rash, cefalea, hipotensión, dolores musculares. En neonatos prematuros: hipokalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hiperuricemia, nefrocalcinosis, hipocalcemia.
PRESENTACIÓN: Comp.: 40 mg. Amp (2 ml): 10 mg/ml. **Formulacion Magistra**l Gotas: 20 mg/ml (1mg/gota).
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución***: IVD: en bolo sin diluir a una velocidad inferior de 4mg/min; IVI: Diluir con SF a una concentración recomendada de 1 a 2mg/ml. Máxima concentración: 10mg/ml. Infundir de 10-15 minutos. IVC: diluir la dosis indicada en 25ml de solución fisiológica. La solución es estable 24hs, proteger de la luz. Velocidad máxima de administración es 4mg/min.
OBSERVACIONES: Administrar con alimentos. Los AINEs pueden reducir los efectos antihipertensivos y diuréticos de la droga. Aumenta el riesgo de hipocalemia con tiazidas y corticosteroides. Aumenta riesgo de ototoxicidad con aminoglucósidos. Contraindicado en encefalopatía hepática y en I.R. anúrica. Embarazo: Evaluar riesgo/beneficio. Lactancia:Pasa a leche materna y puede inhibir la lactancia.
INTERACCIONES: : Los AINEs pueden reducir los efectos antihipertensivos y diuréticos de la droga. Aumenta el riesgo de hipokalemia con tiazidas y corticosteroides. Aumenta el riesgo de ototoxicidad con aminoglucósidos. La administración lenta previene la ototoxicidad.
ATC:C03C. Diureticos de Techo . C03CA. Sulfonamidas

GANCICLOVIR
ACCION TERAPEUTICA: Antiviral. Nucleósido similar al aciclovir, acción antiviral a través de la inhibición de la síntesis de ADN viral y que presenta actividad frente a citomegalovirus (CMV) y herpes simplex (1 y 2)
INDICACION: Tratamiento de infecciones por Citomegalovirus (CMV)
POSOLOGIA: Inducción: 10 mg/kg/dia cada 12 hs; mantenimiento: 5 mg/kg/dia cada 24 hs. No hay una dosis máxima definida, en caso de obesidad (IMC ≥ 30 kg/m²) se recomienda utilizar el peso corporal ajustado (factor de 0,4) para el cálculo de dosis para evitar toxicidad . (Ver pauta de administracion segun tipo de infeccion). *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Leucopenia, trombocitopenia, anemia, náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales.
PRESENTACION: F.A. 500 mg.
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD:IV: Reconstituir el vial con agua destilada a una concentración de 50mg/ml. Estabilidad: 12hs a temperatura ambiente. ***Concentración de la dilución***: Diluir en desxtrosa al 5% o solución fisiológica a una Concentración Recomendada: 5mg/ml. Máxima concentración: 10mg/ml. Infundir en 1 horas.
OBSERVACIONES: La solución de ganciclovir posee el pH (9-11), por lo que puede producir flebitis y/o dolor en el punto de infusión. Interacciona con: zidovudina, imipenem, inmunosupresores, anfotericina. Infundir en 1 hora o más. Por sus propiedades carcinogénicas debe ser preparada y manipulado bajo campana y flujo laminar. Evitar ingestión inhalación o contacto directo con piel y mucosas. No refrigerar el vial reconstituido. Antes de su administración IV debe estar a T° ambiente.
INTERACCIONES: Zidovudina (pancitopenia), imipenem / cilastatina (convulsiones), fármacos inmunosupresores aumentan la supresión de la medula ósea; anfotericina B y ciclosporina aumentan la nefrotoxicidad. Aumenta la AUC de didanosina (incrementa el riesgo de neuropatía periférica, pancreatitis).
ATC: J05AB Antivirales

GENTAMICINA

ACCION TERAPEUTICA: Antibiótico aminoglucósido. Bactericida. Inhibe la síntesis de proteínas uniéndose al ribosoma
INDICACION: Espectro antimicrobiano principalmente frente a bacterias gramnegativas (*Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Proteus, Serratia*) y tiene actividad frente a ciertas bacterias grampositivas *(S. aureus, S. epidermidis, L. monocytogenes)*. En combinación con antibióticos betalactámicos es eficaz en infecciones producidas por *E. fecalis y Streptococcus sp.* Uso clinico en las siguiente infecciones: Sepsis, meningitis, endocarditis, infecciones osteoarticulares, de piel y partes blandas, urinarias y abdominales por germenes sensibles.
POSOLOGIA: 5-7,5 mg/kg/día cada 8-12-24 hs, dosis máxima: 300 mg. Fibrosis quística: 10 mg/kg/día cada 8-12 hs., dosis máxima: 400 mg. Endocarditis: 3 mg/kg/día cada 8 hs. *Ver tabla de ajuste de dosis en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Daño vestibular, nefrotoxicidad reversible, potencia el bloqueo neuromuscular por anestésicos.
PRESENTACION: Solución inyectable, como sulfato: 80 mg / 2 ml.
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución:*** IVD: Administración lenta en 15 minutos (poco recomendada). IVI: diluir con solución fisiológica o dex 5% a una concentración recomendada: 3mg/ml. Máxima concentración: 10mg/ml. Infundir de 30-60 minutos. IM: siempre a la máxima concentración 40mg/ml.
OBSERVACIONES: Si se administra con penicilina o céfalosporina, administrar una hora antes o después de la administración de gentamicina. La IVD no se recomienda por la toxicidad asociada a la presencia de picos en las concentraciones sericas.
INTERACCIONES: Aumenta la nefrotoxicidad de la anfotericina B, cisplatino, ciclosporina, antiinflamatorios no esteroideos, contrastes radiográficos, vancomicina. Aumenta la ototoxicidad de la furosemida y cisplatino. Potencia la parálisis muscular y apnea de bloqueantes y relajantes musculares.
ATC:J01GB. Aminoglucosidos

GLUCAGON
INDICACION: Tratamiento y estudio de la hipoglucemia.
POSOLOGIA: < 1 mes: 20 µg/kg; 1 mes a 2 años: 500 µg; > 2 años: < 20 kg: 500 µg, > 20 kg: 1 mg
EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, diarrea, hipokalemia.
PRESENTACION: F.A.: 1 mg
OBSERVACIONES: S.C. I.M. E.V. No usar con anticolinérgicos. Precaución en pacientes con insulinoma o glucagonoma.
INTERACCIONES: acción antagónica con insulina, aumenta efecto anticoagulante de warfarina, efecto disminuido por indometacina, aumento del pulso y presión sanguínea con betabloqueantes.
ATC: H04AA Hormonas glucogenolíticas.

GLUCOSADA HIPERTONICA
INDICACIÓN: Deshidratación hipertónica, alteraciones metabolismo hidrocarbonado, nutrición parenteral cuando la toma oral de alimentos está limitada.
EFECTOS ADVERSOS: Sindrome hiperosimolar, resultante de una administración excesivamente rápida de soluciones hipertónicas de glucosa, pudiendo causar: confusión mental y/o perdida de la conciencia.
PRESENTACIÓN: Ampolla 10 ml. Glucosa monohidrato 25% (250 mg/ml) - Glucosa monohidrato 50% (500 mg/ml)
OBSERVACIONES: No utilice la ampolla a menos que la solución sea clara. Si no se utiliza la totalidad de la ampolla, descarte el remanente.
ATC: B05BB - Soluciones que afectan el balance electrolítico

HALOPERIDOL
INDICACIÓN: Antipsicótico, derivado de la fenotiazina. Bloqueo competitivo de los receptores postsinápticos de dopamina en el sistema dopaminérgico mesolímbico; deprime la corteza cerebral y el hipotálamo; muestra actividad bloqueadora adrenérgica alfa y anticolinérgica potente

POSOLOGIA: Niños: 3 a 12 años (15 a 40 kg): Oral: Inicial: 0,25 a 0,5 mg/día administrados en 2 a 3 dosis divididas; incrementar 0,25 a 0,5 mg cada 5 a 7 días. DOSIS MAX: 0,15 mg/kg/día. Dosis de mantenimiento: Agitación o hipercinesia: 0,01 a 0,03 mg/kg/día una vez al día. Trastorno de Tourette: 0,05 a 0,075 mg/kg/día dividido en 2 ó 3 dosis. Trastornos psicóticos: 0,05 a 0,15 mg/kg/día divididos en 2 a 3 dosis. 6 a 12 años: IM: (como lactato): 1 a 3 mg/dosis cada 4 a 8 hs hasta un máximo de 0,15 mg/kg/día. Adultos: VO: 0,5 a 5 mg 2 a 3 veces/día; DOSIS MAX: 30 mg/día. IM: (como lactato): 2 a 5 mg cada 4 a 8 hs. Como decanoato: 10 a 15 veces la dosis oral estabilizada del paciente individual, administrada a intervalos de 3 a 4 semana.

EFECTOS ADVERSOS: Reacciones extrapiramidales e hipotalámicas severas, distonía. Tiene menos efectos muscarínicos e hipotensores y más efectos extrapiramidales que la clorpromazina.

PRESENTACIÓN: Amp (como lactato): 5 mg/ml. Gotas (como lactato): 2 mg/ml.

OBSERVACIONES: Alta potencia y amplia experiencia. Menos sedante que clorpromazina y frecuentes síntomas extrapiramidales. Pocos efectos anticolinérgicos y cardiovasculares, por lo que es de elección en patología cardíaca. Muy útil vía IM en agitación psicomotriz si existe cardiopatía o no se conoce. La vía IV está reservada para grandes urgencias. Ajuste de dosis en IH.

INTERACCIONES: Los depresores del SNC suelen aumentar los efectos adversos; la adrenalina puede causar hipotensión; la fluoxetina inhibe el metabolismo y aumenta el efecto del haloperidol; la clorpromazina puede aumentar las concentraciones de haloperidol; carbamazepina y fenobarbital suelen aumentar el metabolismo y disminuir la eficacia del haloperidol; el uso de haloperidol con fármacos anticolinérgicos puede aumentar la presión intraocular; con litio puede causar síndrome agudo tipo encefalopatía.

ATC: N05AD Derivados de la Butirofenona

HEPARINA

INDICACIÓN: Potencia la acción de la antitrombina III y, por consiguiente desactiva la trombina (los factores de coagulación activados IX, X, XI, XII, y la plasmina) y previene la conversión de fibrinógeno en fibrina; la heparina también estimula la liberación de lipasa de lipoproteínas. Terapia anticoagulante en la profilaxis y el tratamiento de trombosis venosas, embolias pulmonares. Prevención postoperatoria de trombosis venosas profundas. Fibrilación arterial con embolismo. Prevención de la formación de coágulos en cirugía cardiovascular. Como anticoagulante en las transfusiones sanguíneas en la circulación extracorpórea en la diálisis y en el muestreo de sangre para el laboratorio.

POSOLOGIA: Inicial: 5.000 UI por vía intravenosa seguidas de 10.000 o 20.000 UI de solución concentrada por vía subcutánea. Mantenimiento: 8.000 a 10.000 UI de solución concentrada cada 8 horas o 15.000 a 20.000 UI cada 12 hs.
Inyección Intravenosa Intermitente: Inicial: 10.000 UI diluidas o no en 50 o 100 ml de solución salina isotónica. Mantenimiento: 5.000 a 10.000 UI diluidas o no en 50 o 100 ml de solución salina isotónica cada 4 a 6 hs.
Infusión Intravenosa: Inicial: 5.000 UI por vía intravenosa, y mantener infundiendo 20.000 a 40.000 UI diluidas en 1.000 ml de solución salina isotónica cada 24 hs.
Lavado para conservar la permeabilidad de catéteres centrales de una o doble luz (en lactantes < 10 kg): 10 U.I. /ml, lactantes mayores, niños y adultos: 100 U.I./ml.

EFECTOS ADVERSOS: Hemorragias, trombocitopenia.

PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 25000 UI/5 ml. (5000 U.I./ml.)

OBSERVACIONES: La vía intramuscular no se recomienda. Contraindicada en: insuficiencia hepática y renal grave, endocarditis lenta, gastritis hemorrágica, úlcera gastroduodenal. El uso de digitálicos, tetraciclinas, nicotina y antihistamínicos puede contrarrestar parcialmente su acción anticoagulante.

INTERACCIONES: Drogas que afectan la función plaquetaria (aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, dipiridamol) pueden potenciar el riesgo de hemorragia; digoxina, antihistamínicos y nitroglicerina pueden disminuir el efecto anticoagulante de la heparina

ATC: B01AB.Grupo de la Heparina

HIDROCORTISONA

INDICACIÓN: Enfermedades alérgicas, enfermedades reumáticas, tratamiento del shock, insuficiencia adrenocortical aguda o primaria. Edema. Enfermedades gastrointestinales, oftalmológicas, respiratorias, neoplásicas.

POSOLOGIA: IM-IV: 100 a 500 mg/día. Tópica: Aplicar una película delgada a piel seca, limpia y frotar con suavidad. Antiinflamatorio o efecto inmunosupresor: EV-IM: 1-5 mg/kg/día o 30 a 150 mg/m2/día cada 12-24 hs. VO: 2,5 mg/kg/día o 75 a 300 mg/m2/día cada 6-8 hs. Insuficiencia adrenal aguda: EV-IM: Lactantes y menores de < 12 años: 25-150 mg/día cada 6-8 hs. > 12 años: 150-250 mg/día cada 6-8 hs. Crisis asmática moderada y grave: EV: 5 mg/kg/día cada 6 hs. Terapia de reemplazo fisiológico e hiperplasia adrenal congénita: VO: 0,6-0,8 mg/kg/día o 15- 20 mg/m2/día cada 8 hs. IM: 0,3-0,4 mg/kg/día, cada 24 hs. Pre-anfotericina: 1 mg/kg. Antiestrés: estrés leve: VO: 50 mg/m2/día, estrés grave: EV-IM: 60 mg/m2/dosis. Tópico: 2 veces por día, no más de 1 semana; disminuir gradualmente
EFECTOS ADVERSOS: Hipertensión, hiperglucemia, úlcera péptica, miopatía, detención del crecimiento, osteoporosis, cataratas subcapsular posterior, síndrome cushingoide, alcalosis hipocalémica, edema, susceptibilidad aumentada a las infecciones, osteonecrosis.
PRESENTACIÓN: F.A. (Como succinato, sódico): 100-500 mg. Comp.: 10 mg. Crema (como acetato): 1 %.
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: VO: si se administra una vez al día, darlo por la mañana. SNG: Se puede triturar, administrar inmediatamente.
OBSERVACIONES: Pueden aparecer reacciones adversas locales y sistémicas. Reacciones alérgica. Puede producir hipertensión, calambres, mialgias, náuseas, debilidad muscular, ardor abdominal, visión borrosa. Retención de sodio. Pérdida de potasio.
INTERACCIONES: Barbitúricos, fenitoína, rifampicina, salicilatos, diuréticos, warfarina, cafeína y el alcohol pueden incrementar el riesgo de úlcera gastrointestinal; vacunas de virus vivos: aumentan el riesgo de infección viral; disminuye la respuesta inmune de las vacunas.
ATC: H02. Corticoides para Uso Sistemico. H02A. Corticosteroides para Uso Sistemico, Monofarmacos

HIERRO SACARATO
INDICACIÓN: Sal de hierro; mineral parenteral. : Restituye el hierro que se encuentra en hemoglobina, mioglobina y enzimas especificas; permite el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Deficiencia severa de hierro. Alteración de la absorción de hierro. Intolerancia gastrointestinal
POSOLOGIA: 2-3 mg/kg/dosis, días alternos, tantos días como gramos de hemoglobina se quieran aumentar. Dosis máxima: niños hasta 5 kg: 1.25 ml. 5-10 kg: 2.5 ml. > 10 kg: 5 ml.
EFECTOS ADVERSOS: Reacción anafiláctica, cefalea, fiebre, linfoadenopatías, artralgia, urticaria.
PRESENTACIÓN: Ampolla (5 ml): hierro sacarato: 100 mg (osmolaridad: alrededor de 1250 mOsm/l)
OBSERVACIONES: Reacción anafiláctica, cefalea, fiebre, linfoadenopatías, artralgia, urticaria. Es una solución fuertemente alcalina y no puede administrarse vía subcutánea o vía intramuscular. Evitar extravasación. La administración demasiado rápida puede causar hipotensión (se recomienda diluir en 50-100ml de SF para una administración intravenosa lenta). No se recomienda la administracion en bolo.
INTERACCIONES:
ATC: B03 Preparados Antianemicos B03A Preparados con Hierro

HIERRO SULFATO
INDICACIÓN: Sal de hierro; mineral oral. El hierro se libera del plasma y finalmente repone los depósitos de hierro agotados en la medula ósea en donde se incorpora en la hemoglobina. Prevención y tratamiento de anemia ferropénica
POSOLOGIA: Todas las dosis están expresadas como hierro elemental: Requerimientos: 0-1 año: 6 a 10 mg/día. 1-10 años: 10 mg/día. Mayores de 10 años: 12-15 mg/día. Tratamiento de la anemia: 3 mg/kg/día. Profiláctica: RN término: 1 mg/kg/día. RN pretérmino: 2 mg/kg/día
EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, anorexia, constipación, diarrea, dolor epigástrico.
PRESENTACIÓN: Gotas: 125 mg/ml (1 gotero=0.6 ml=15 mg de hierro elemental). Comprimidos: 200 mg (equivalente a 60 mg de hierro elemental)
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: VO: Preferentemente en ayunas, no dar con leches ni derivados. No dar con antiácidos ni tetraciclinas.
OBSERVACIONES: Administrar con agua o jugo entre las comidas para absorción máxima; puede proporcionarse con alimento si ocurre molestia gastrointestinal; no administrar con leche o productos lácteos.

INTERACCIONES: La administración concurrente de antiácidos y cimetidina suele disminuir la absorción de hierro. El hierro puede disminuir la absorción de penicilina, levotiroxina, metildopa, y levodopa cuando se administra al mismo tiempo. Puede disminuir la absorción de quinolonas debido a la formación de complejo de ion férrico-quinolona. La vitamina C aumenta la absorción.

ATC: B03 Preparados Antianemicos . B03A Preparados con Hierro

IBUPROFENO

INDICACIÓN: Analgésico no narcótico, antipirético, antiinflamatorio no esteroide. Cuadros febriles, dolores leves a moderados, cuadros inflamatorios postraumáticos, tratamiento de enfermedades inflamatorias y trastornos reumatoides
incluyendo artritis reumatoidea juvenil, dismenorrea, dolor migrañoso, gota

POSOLOGIA: Lactantes y niños: Analgesia: 4 a 10 mg/kg/dosis cada 6 a 8 horas. Antipirética: 6 meses a 12 años: temperatura < 39º C 5mg/kg/dosis temperatura >o = 39º C 10mg/kg/dosis cada 6 a 8 horas. DOSIS MAX: 40mg/kg/día. Artritis reumatoidea juvenil: 6 meses a 12 años: 30 a 50 mg/kg/día divididos en cuatro intervalos, iniciar con la dosis más baja del intervalo posológico y ajustar. DOSIS MAX: 2,4 g/día. Adolescentes y adultos: Enfermedad inflamatoria: 400 a 800 mg/dosis cada 6 a 8 hs. DOSIS MAX: 3,2 g/día. Dolor / Fiebre / dismenorrea: 200 a 400 mg/día cada 6 a 8 horas. DOSIS MAX: 1,2g/día

EFECTOS ADVERSOS: Cefaleas, somnolencia, taquicardia, palpitaciones, vértigo, constipación, náuseas, vómitos, disturbios visuales, tinnitus.

PRESENTACIÓN: Comprimidos recubiertos 400 mg, suspensión oral al 2%. Ampollas 400 Mgrs

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución***: IVI: diluir con SF o DEX 5% a una concentración recomendada: 2mg/ml. Máxima concentración: 4mg/ml. Infundir 30-60 minutos
VO: administrar con alimentos

OBSERVACIONES: Oral, proporcionar con alimentos o leche para disminuir la molestia gastrointestinal. Existen presentaciones comerciales con lidocaína de uso exclusivo I M. La extravasación puede provocar necrosis en los tejidos.

INTERACCIONES: Sustratos de las coenzimas CYP2C8 y CYP2C9 del citocromo P450. Puede aumentar las concentraciones séricas de litio, digoxina, metotrexate (si fuera necesario el uso concomitante con éste se recomienda discontinuar por espacio de 12 a 24 hs. antes y por lo menos 12 horas después de la administración de metotrexate a altas dosis. Suele disminuir los efectos antihipertensores de los inhibidores de la ACE o antagonistas de la angiotensina II (vigilar la presión arterial); puede disminuir los efectos de otros fármacos antihipertensores, furosemida, tiazidas, y ahorradores de potasio. Aumenta el riesgo de nefrotoxicicidad de las ciclosporinas por disminución de las prostaglandinas renales. El uso concomitante con otros AINES aumenta los efectos adversos propios de éstos. Evitar la combinación con enoxaparina, ACO y heparina por aumento del sangrado por disminución de la función plaquetaria y de la coagulación

ATC: M. Sistema Músculo Esquelético. M01 – Antiinflamatorios y Antirreumáticos

IMIPENEM + CILASTATIN

ACCION TERAPEUTICA: **Uso reservado.** Antibiótico carbapenémico de amplio espectro. Bactericida. Inhibe la síntesis de proteínas uniéndose a las PBP de las bacterias.

INDICACIÓN: Tratamiento de infecciones respiratorias bajas, urinarias, intraabdominales, ginecológicas, óseas y articulares, sepsis, endocarditis, de piel y partes blandas por bacterias multirresistentes gram negativas

POSOLOGIA: Niños: 60 - 100 mg/kg/día cada 6-8 hs, dosis máxima: 4 g. Adultos: 500 mg cada 6 hs, Pseudomonas: 1000 mg cada 6 hs. Fibrosis quística: 90 mg/kg/día cada 6 hs, dosis máxima: 4 g/día. *Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS: Flebitis, reacciones alérgicas, náuseas, vómitos, diarrea, colitis pseudomembranosa, convulsiones. Raro: leucopenia, hepato y nefrotoxicidad.

PRESENTACIÓN: Inyectable para reconstituir: IM-EV: Imipenem 500 mg y cilastatina 500 mg

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: reconstituir el FA con 10 ml de solución fisiológica, agitar hasta que la solución sea transparente; nos da una concentración de 50mg/ml. Es estable 10 hs a T° ambiente y 48hs refrigerado.
Concentraciones de la dilución: IVD: poco recomendada. IVI: diluir con solución fisiológica a una concentración de 5mg/ml. En pacientes con restricción hídrica se puede diluir a una concentración de 7mg/ml. Infundir de 20-30 minutos en dosis menor o igual a 500mg; y de 40-60 minutos en dosis mayor a 500mg
IM: Reconstituir el vial con lidocaína al 1%, inyectar en masas musculares grandes como el glúteo o la región lateral del muslo.

OBSERVACIONES: No reconstituir en diluyentes que contengan lactato ya que es incompatible. No mezclar físicamente con otros antibióticos. En circunstancias excepcionales y por razones clínicas se puede utilizar dextrosa al 5%. Las soluciones diluidas se deben utilizar inmediatamente. El intervalo de tiempo entre el comienzo de la reconstitución y el final de la perfusión EV, no debe exceder las dos horas

INTERACCIONES: Antibióticos beta - lactámicos, probenecid, ganciclovir (aumento del riesgo de convulsiones)

ATC: J01DH. Carbapenemicos

INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NORMALES PARA ADM. INTRAVASCULAR

INDICACIÓN: Tratamiento de inmunodeficiencias primarias y secundarias. PTI, hipogammaglobulinemia asociada a LLC de células beta. Enfermedad de Kawasaki. Profilaxis de injerto contra huésped tras TMO. Infección pediátrica por VIH. Síndrome de Guillain-Barré

POSOLOGIA: Las dosis varían de acuerdo a la patología a tratar. EV: Administrar durante los primeros 30 min a 0.5 ml/kg/hora e ir incrementando si es bien tolerado en forma gradual a un máximo de 8 ml/kg/h. Premedicar 30 min antes de la administración con 1 mg/kg de difenhidramina e hidrocortisona 1 mg/kg. Una vez perforado el tapón este medicamento debe administrarse inmediatamente y cualquier remanente debe descartarse debido al riesgo de contaminación bacteriana. NO APLICAR IM o SC.

EFECTOS ADVERSOS: La perfusión intravenosa de Ig puede ocasionar reacciones adversas en un 5-15 % de casos, fundamentalmente fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, tanto durante como después de la perfusión, a veces 1-2 días después. Menos frecuentes son la aparición de taquicardia, hipotensión, meningitis aséptica, fenómenos tromboembólicos, insuficiencia renal o incluso una reacción anafiláctica.

PRESENTACIÓN: Frasco Ampolla 0,5 g de IgG en 10 ml; 2,5 g de IgG en 50 ml; 5 g de IgG en 100 ml; 10 g de IgG en 200 ml.

OBSERVACIONES: Comenzar la infusión lentamente y aumentar gradualmente

INTERACCIONES: Vacunas de virus vivos (sarampión, paperas, rubéola)

ATC: J06BA Inmunoglobulinas Humanas Normales

INMUNOGLOBULINA ANTI RH-O D HUMANA

INDICACIÓN: Actúa suprimiendo la respuesta inmunológica de los pacientes Rho (D) negativos a los glóbulos rojos Rho (D) positivos. Previene la sensibilización con el antígeno D (Rho) eritrocitario en personas Rh - negativas. Error transfusional (Rh + a Rh -). Púrpura trombocitopénica en pacientes Rh +.

POSOLOGIA: Púrpura trombocitopénica (EV): Inicial: 75 µg/kg/ciclo por 4 ciclos, luego debe individualizarse. 30 µg neutralizan 1 cc de glóbulos rojos (10 concentrados de plaquetas contienen 5 cc de glóbulos rojos). Equivalencia: 1 µg= 5 UI.

EFECTOS ADVERSOS: Reacciones locales en el sitio de inyección, anemia, eventualmente fiebre

PRESENTACIÓN: Jeringa prellena 250-300-330 µg.

OBSERVACIONES: Hipersensibilidad a inmunoglobulinas humanas (particularmente en casos raros de deficiencia de IgA), o a alguno de los componentes de la fórmula. En individuos Rh positivos.

INTERACCIONES: La inmunización activa con vacunas de virus vivos atenuados (sarampión, parotiditis o rubéola) deberán posponerse hasta 3 meses después de la administración de la inmunoglobulina anti-D, ya que la eficacia de la vacuna podría dañarse.

ATC: J06BB Inmunoglobulinas Especificas

INMUNOGLOBULINA ANTITETANICA

INDICACIÓN: Profilaxis en pacientes con heridas de alto riesgo sin vacunación previa, administrada simultáneamente y en brazo opuesto al toxoide tetánico. Tratamiento del tétanos.
POSOLOGIA: – Prevención del tétanos La IGTH se administra en caso de herida de riesgo, p.ej. heridas con fracturas, heridas profundas penetrantes, heridas por mordedura, heridas con cuerpos extraños, heridas sucias de tierra, heridas infectadas, lesiones tisulares importantes (heridas contusas, quemaduras). Niños y adultos: 250 UI dosis única; 500 UI en caso de herida de más de 24 horas La IGTH debe administrarse lo más rápidamente posible después de sufrir la herida, al mismo tiempo que la vacuna antitetánica, en otra jeringa y otro lugar anatómico. – Tratamiento del tétanos Recién nacidos, niños y adultos: 500 UI dosis única, a inyectar en dos lugares distintos
EFECTOS ADVERSOS: Leve elevación de la temperatura. Muy raramente edema angioneurótico, síndrome nefrótico.
PRESENTACIÓN: Solución para inyección en ampolla o jeringa precargada de 250 UI (250 UI/ml, 1 ml) o 500 UI (250 UI/ml, 2 ml), para inyección IM. NO ADMINISTRAR EN IV.
OBSERVACIONES: – En caso de herida leve limpia, se administra únicamente la vacuna antitetánica. – La vía SC se puede utilizar pero únicamente si la vía IM está contraindicada. – Conservación: entre 2 °C y 8 °C. No congelar -
ATC: J06BB Inmunoglobulinas Especificas

INSULINA HUMANA C
INDICACIÓN: Hipoglucemiante . Reduce los niveles de glucemia, aumenta el transporte de glucosa en las células, así como la formación de glucógeno en los músculos e hígado, mejora la utilización del piruvato, inhibe la glucogenólisis, aumenta la lipogénesis.
POSOLOGIA: El requerimiento diario es de 0,5 a 1 UI/kg. Pero la dosis se ajusta de acuerdo a la dieta, la actividad física y el estilo de vida.
EFECTOS ADVERSOS: Puede desarrollarse hipoglucemia cuando la dosis de insulina excede la necesidad del paciente. En pacientes con retinopatía proliferativa, puede causar ceguera. Puede haber reacciones de hipersensibilidad locales en el lugar de aplicación.
PRESENTACIÓN: Envase 1 F/A x 10 ml. 100UI/ml. ; lapicera y cartuchos de 3ml: 100UI/ml.
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: Los viales, las plumas y cartuchos sin utilizar deben conservarse refrigerada. Las plumas que contengan el cartucho, después del primer uso no refrigerar, conservar a T° ambiente y proteger de la luz. Es estable 28dias. ***Concentración de la dilución:*** IVD: administrar de forma rápida y lavar con SF. a dosis bajas se puede diluir a una concentración de 0,2UI/ml. IVC: Preparación del sistema: diluir 0.5ml (50 UI) de insulina en 50ml de SF. Agitar la solución para asegurar una mezcla homogénea, y purgar todo el sistema, permitir la adsorción de la insulina a sus paredes durante 20 minutos; pasado este tiempo desechar el contenido y lavar todo el sistema con SF asegurando la cantidad de insulina liberada. Preparación de la dilución: diluir 0,5ml de insulina (50UI) en 50 ml de SF, obteniéndose una concentración de 1UI/ml. Infundir según indicación médica. El preparado es estable 4hs en sachet. Se debe cambiar infusión y sistema IV utilizado cada 24 hs.
OBSERVACIONES: Contraindicado en Hipersensibilidad a la droga u otro de sus excipientes. No utilizarse en casos de hipoglucemia manifiesta o inminente. No utilizar DX 5% para su preparación.
INTERACCIONES: Se potencia cuando se administra con inhibidores de la ECA, ácido acetilsalicílico, otros salicilatos. Anfetaminas, esteroides anabólicos, hormonas masculinas, ciclofosfamida, fibratos, fluoxetina, IMAO, hipoglucemiantes
ATC: A10 Farmacos usados en Diabetes A10AB Insulinas y Analogos de accion rapida

INSULINA HUMANA NPH
INDICACIÓN: Pacientes con diabetes mellitus que requieren insulina para el tratamiento de la homeostasis de la glucosa. Regula el metabolismo de la glucosa, hace que el hígado almacene la glucosa en forma de glucógeno e inhibe la glucogenólisis y promueve la conversión del exceso de glucosa en grasa
POSOLOGIA: Dosis recomendada es de 0,5 a 0,8 UI/Kg. En dosis únicas o divididas según el paciente.
EFECTOS ADVERSOS: Alergia al medicamento, lipodistrofia o lipohipertrofia en el lugar de inyección, edema, hipoglucemia, resistencia a la insulina, enrojecimiento, inflamación, prurito en el sitio de inyección.

PRESENTACIÓN: Envase 1 F/A x 10 ml. 100UI/ml
OBSERVACIONES: : Hipersensibilidad al sulfato de protamina
INTERACCIONES: Producen hiperglucemia, anticonceptivos orales, corticoides, o tratamiento de sustitución tiroidea. También con medicamentos hipoglucemiantes, hipoglucemiantes orales, salicilatos, antibióticos como sulfamidas, e inhibidores de la MAO.
ATC: A10 Farmacos usados en Diabetes A10AB Insulinas y Analogos de accion rapida

IPRATROPIO
INDICACIÓN: Broncoespasmo. Asma. EPOC. Bronquitis. Profilaxis broncoespasmo inducido por ejercicio. Bloquea la acción de la acetilcolina en sitios para simpáticos en músculo liso bronquial y causa broncodilatación; inhibe las secreciones de glándulas serosas y seromucosas que recubren la mucosa nasal.
POSOLOGIA: - Aerosol: ADULTOS y NIÑOS > 5 años: 20-40 mcg cada 6-8 hs. Dmax. 240 mcg/día. – Solución p/nebulizar: 250 mcg/día.
EFECTOS ADVERSOS: Sequedad de boca, tos, exacerbación de síntomas, irritación local, retención urinaria, constipación.
PRESENTACIÓN: Gotas 0,03 % x 20 mL. Aerosol x 250 disparos.
OBSERVACIONES: Es común que produzca sequedad de boca. Rara vez, taquicardia, estreñimiento, alteración en la visión, retención urinaria, cefalea, nerviosismo. Utilizar bajo estricto control médico en pacientes con glaucoma e hipertrofia prostática. Es relativamente seguro en embarazadas. Teratogenicidad Categoría B.
INTERACCIONES: Efectos aditivos con anticolinérgicos o fármacos con propiedades anticolinérgicas
ATC: R03BB. Anticolinergicos

ISOPROTERENOL
INDICACIÓN:Efecto beta adrenérgico, crono e inotrópico positivo. Vasodilatador arterial del músculo esquelético. Aumenta el consumo de O^2.
POSOLOGIA: 0,05-1 µg/kg/minuto en infusión continua
EFECTOS ADVERSOS: Hipotensión, arritmias cardíacas, cefaleas, temblores, intranquilidad, debilidad, tos, disnea.
PRESENTACIÓN: Ampollas por 5 ml: 0,2 mg/ml
OBSERVACIONES: Se puede administrar sin diluir. Para infusión continua diluir en dextrosa 5% o solución fisiológica en una concentración máxima de 20 µg/ml. No administrar simultáneamente con adrenalina. Aumenta el clearance de teofilina y lidocaína. Taquifilaxis en uso prolongado.
INTERACCIONES: Asociado con adrenalina intravenosa puede causar infarto o empeorar una arritmia. Es antagonizado por los fármacos simpaticolíticos
ATC: C01CA02.Glucósidos cardíacos. R03AB02.Adrenérgicos, inhalatorios.

KETAMINA
INDICACIÓN:Anestesia disociativa. Analgesia.
POSOLOGIA: Inducción de anestesia: E.V.: 1-2 mg/kg en bolo; I.M.: 5 mg/kg; Infusión continua: 1-2 mg/kg/hora. Analgesia de piel, músculo y hueso: 0,5-1 mg/kg. Intubación endotraqueal: 2-3 mg/kg
EFECTOS ADVERSOS: Hipertensión endocraneana, sialorrea, alucinaciones auditivas y visuales. Uso crónico (drogadependencia): taquicardia, hipertensión, hipotensión, dilatación gástrica.
PRESENTACIÓN: F.A. de 10 ml: 50 mg/ml
OBSERVACIONES: Asociar con atropina y benzodiacepinas. Con nalbufina: disminuye su efecto analgésico, alucinaciones. Con hormonas tiroideas: taquicardia e hipertensión. Contraindicaciones: hipertensión intracraneana, lesión ocular traumática e hipertensión pulmonar. Concentración de administración en pacientes con restricción hídrica: 2 mg/ml en Dx 5% o Sol. F.
INTERACCIONES: Tramadol
ATC: N01AX Anestésicos generales.

KETOROLAC TROMETAMINA

INDICACIÓN: Analgésico no narcótico, antiinflamatorio no esteroide, antipirético.-Inhibe la síntesis de prostaglandina por disminución de la actividad de la enzima ciclooxigenasa. Analgésico en tratamiento a corto plazo (menor o igual a 5 días) del dolor agudo moderado a intenso, incluyendo dolor postoperatorio, visceral relacionado con cáncer,por traumatismos, cólico renal agudo.

POSOLOGIA: EV: 0,5 a 0,9 mg/kg por 48 a 72 hs. VO: 10 mg cada 4 a 6 hs. Dosis máxima: 40 mg/día durante 5 a 14 días. IM: Dosis inicial 30 a 60 mg, dosis subsiguientes 10 a 30 mg cada 4 a 6 hs. Dosis máxima: 120mg/día

EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, dispepsias, epigastralgias, constipación, diarrea, edema, hipertensión, rash, prurito, púrpura, somnolencia, mareos, cefalea, sudoración. Hemorragia gastrointestinal, trombocitopenia, convulsiones, insuficiencia renal aguda.

PRESENTACIÓN: Capsulas 10 y 20 mg. Inyectable (IM / IV) 10 y 30 mg

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: VO: con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal.

OBSERVACIONES: Teratogenicidad Categoría C (D durante el tercer trimestre)

INTERACCIONES: Cuando se administra conjuntamente con litio o digoxina, el ketorolac puede elevar las concentraciones plasmáticas de los mismos. El uso concomitante con diuréticos ahorradores de potasio puede asociarse con un incremento de los niveles séricos de potasio. El ketorolac puede disminuir los efectos antihipertensivos de los IECA y antagonistas de la angiotensina II. El uso de ketorolac con ACO y heparina incrementa el riesgo de hemorragias. El uso conjunto con metotrexate o litio incrementa la concentración sanguínea y toxicidad de estos.

ATC: M. Sistema Músculo Esquelético. M01 – Antiinflamatorios y Antirreumáticos

LABETALOL CLORHIDRATO

INDICACIÓN: Vasodilatador. Disminuye la presión sanguínea por bloqueo de receptores alfa-adrenérgicos arteriales periféricos y bloqueo oncurrente de receptores ß-adrenérgicos, protege el corazón de una respuesta simpática refleja (como alteraciones del ritmo o del gasto cardíaco). No ejerce acción sobre el riñón, por lo que puede administrarse en pacientes hipertensos con enfermedad renal. Indicado en hipertensión, de leve a grave, hipertensión en embarazo, angina de pecho con hipertensión coexistente.

POSOLOGIA: Hipertensión (E: off-label): niños y adolescentes
Oral. Dosis inicial: 1-3 mg/kg/día dividido en 2-4 dosis (Dosis máxima: 100 mg/12 h). Aumentar c/2 días hasta 6 mg/kg/ 6-12 h dosis diaria máxima 10-12 mg/kg/día, hasta 1200 mg/día.
I.V. (bolus e infusión intermitente). 0.2-1 mg/kg/dosis (dosis máxima: 40 mg) en 1-10 min; Se puede repetir en 10-15 min sin superar la dosis total de impregnación de 200 mg; debería reservarse su uso para la hipertensión severa.
Emergencia hipertensiva (E: off-label): lactantes, niños y adolescentes
Infusión IV continua: 0.25-3 mg/kg/hora; iniciar en la dosis más baja del rango e ir aumentando lentamente. Se recomienda no bajar la tensión más de un 25-30%.
Insuficiencia renal: labetalol es particularmente adecuado para ser utilizado en pacientes hipertensos con disfunción renal.
Insuficiencia hepática: puede ser necesario una reducción de dosis.

EFECTOS ADVERSOS: Broncoespasmo, hepatotoxicidad, hiperkalemia, arritmia ventricular.

PRESENTACIÓN: Comprimidos 200 Mgrs. Ampolla 100 Mgrs/ 20 Ml

OBSERVACIONES: □ Alergia al medicamento y en general a los betabloqueantes.
□ Asma u otras enfermedades broncoespásticas.
□ Bloqueo cardiaco de segundo y tercer grado, bradicardia intensa o shock cardiogénico.
□ La forma inyectable está contraindicada tras infarto de miocardio cuando existe vasoconstricción periférica que sugiere bajo gasto cardíaco.

ATC: C07AC. Alfa y Betabloqueantes

LACTULOSA

INDICACIÓN: Constipación crónica habitual. Encefalopatía hepática. La degradación bacteriana de la lactulosa, que da por resultado un pH ácido, inhibe la difusión de NH3 hacia la sangre al dar lugar a la conversión de NH3 en NH4+; asimismo, aumenta la difusión de NH3 de la sangre al intestino, en donde ocurre la conversión en NH4 +; produce un efecto osmótico en el colon, y la distensión consiguiente promueve la peristalsis y eliminación de NH4+ del cuerpo.

POSOLOGIA: Constipación: 15 a 30 ml (10-20 g) cada 12 o 24 hs. Encefalopatía hepática: 30 a 45 ml (20-30,15 g) cada 8 hs, fijar para conseguir un máximo de 2 a 3 deposiciones semisólidas por día. Niños: 40 a 90 ml/ día divididos de 3 a 4 veces.

EFECTOS ADVERSOS: Distensión abdominal, calambres, flatulencia, diarrea, náuseas, vómitos.

PRESENTACIÓN: Jarabe: 65 g/100 ml.

OBSERVACIONES: Debe ser usado con precaución en pacientes diabéticos y pacientes intolerantes a la lactosa . Administrar con jugo, leche o agua.

INTERACCIONES: Los antibióticos orales pueden interferir en la degradación deseada de la lactulosa. Los antiácidos no absorbibles suelen eliminar la disminución del pH del tubo gastrointestinal deseada inducida por la lactulosa

ATC: A06A. Drogas para la Constipacion. A06AD. Laxantes Osmoticos

L-CARNITINA

INDICACIÓN: Molécula con estructura de amonio cuaternario, sintetizada fundamentalmente en hígado y riñón a partir de los aminoácidos lisina y metionina. Actúa como transportador específico de ácidos grasos de cadena larga al interior mitocondrial. donde se realiza la betaoxidación, siendo ésta la principal fuente de energía para el músculo cardíaco y esquelético. La deficiencia de L-carnitina conduce a una disminución sustancial de la producción de energía.

POSOLOGIA:Lactantes, niños y adolescentes

•Vía oral: 50-100 mg/Kg/día dividido en 2-3 tomas, máximo 3 g/día. Las dosis deben individualizarse en función de la respuesta del paciente (en ocasiones se han administrado dosis mayores).

EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, olor en el cuerpo.

PRESENTACIÓN: Solucion Bebible. 1 Grs/10 Ml

OBSERVACIONES: •Tratamiento y profilaxis del déficit primario y secundario de L-carnitina (A)

•Trastornos de la betaoxidacion de los acidos grasos : Acidemias Orgánicas (pe: acidemia prepriónica, metilmalónica, isovalérica) y deficiencia de glutaril-CoA-deshidrogenasa. (E: off-label)

•Miopatías por carencia de L-Carnitina. (E: off-label)

•Citopatías mitocondriales. (E: off-label)

•Tratamiento y profilaxis del déficit de carnitina en pacientes adultos en hemodiálisis en enfermedad renal terminal (E: off-label)

•Tratamiento de la intoxicación aguda y crónica por ácido valproico. (E: off-label)□

INTERACCIONES: Interactúa con acido valproico y benzoato sodico.

ATC: A16AA01. Aminoacidos y Derivados

LANSOPRAZOL

INDICACIÓN: Inhibidor de la secreción gástrica de ácido (inhibidor de la bomba de protones). Tratamiento a corto plazo para cicatrización y alivio sintomático de úlcera duodenal activa, esofagitis erosiva, conservación de esofagitis erosiva cicatrizada, tratamiento de padecimientos hipersecretorios patológicos, tratamiento coadyuvante en la terapéutica de gastritis relacionada con Helicobacter pylori, prevención y tratamiento de úlceras gástricas relacionadas con AINES.

POSOLOGIA: Niños: <10 kg: 7,5 mg una vez al día; 10 a 20 kg: 15 mg/día; ≥ 20 kg: 30 mg/día. Niños mayores de 12 años y adultos: úlcera gástrica: cicatrización 30 mg/día, prevención 15 mg/día. Gastritis antral relacionada con Helicobacter Pylori: 30 mg 2 veces por día por 2 semanas

EFECTOS ADVERSOS: dolor de cabeza, mareo,diarrea, estreñimiento, dolor de estómago, náuseas y vómitos, flatulencia, sequedad o dolor de boca o garganta, pólipos benignos en el estómago.
Erupción cutánea, picor,cambios en los valores de las pruebas de función hepática,cansancio

PRESENTACIÓN: Gránulos para suspensión oral: 30 mg

OBSERVACIONES: Administrar lejos del alimento, ya que este disminuye su biodisponibilidad un 50 %. Para administración por sonda nasogastrica pueden abrirse las cápsulas y mezclarse los gránulos con jugo.

INTERACCIONES: Debido a la inhibición profunda y prolongada de la secreción gástrica de ácido, existe la posibilidad de interferencia en la absorción de fármacos en los que es importante el pH ácido, como ketoconazol, sales de hierro y digoxina; el sucralfato retrasa y disminuye la absorción del lansoprazol; éste último aumenta la depuración de teofilina.

ATC: A02 Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos. A02B Agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico. A02BC Inhibidores de la bomba de protones

LEVETIRACETAM
INDICACIÓN: Anticonvulsivante.
POSOLOGIA: 4 a 16 años: inicial: 10 - 20 mg/kg/día cada 12 hs, incrementar 10 - 20 mg/kg/día cada 2 semanas hasta un máximo de 60 mg/kg/día cada 12 hs. Adultos: inicial: 500 mg cada 12 hs, incrementar 1000 mg/día cada 2 semanas hasta un máximo de 3000 mg/día. Ajustar la dosis en insuficiencia renal y hemodiálisis.
EFECTO ADVERSO : Astenia, depresión, nerviosismo, somnolencia, infección, ataxia, mareos, vértigo, convulsiones.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 500 - 1000 mg F.A. por 5 ml: 100 mg/ml
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución:*** IVI: Diluir en SF o Dx 5% dosis de 250mg: 2,5 mg/ml; 500mg: 5mg/ml; 1000mg: 10mg/ml; 1500mg: 15mg/ml. Infundir en 15 minutos. VO: comprimidos de 500-1000mg. Puede administrarse con o sin alimentos. Puede diluirse en agua. SNG: suspensión de 100mg/ml. Una vez abierto conservar a T° ambiente por dos meses.
OBSERVACIONES: Administración E.V.: Diluir la dosis en 100 ml de solución fisiológica o dextrosa 5 % y administrar en 15 min (neonatos: 5 mg/ml). Suspender la droga gradualmente para minimizar el aumento de frecuencia de convulsiones.
ATC: N03AG - Antiepilépticos: Acidos grasos . N03AX - Otros antiepilépticos

LEVOFLOXACINA
ACCION TERAPEUTICA: Fluoroquinolona de segunda generacion que inhibe la ADN girasa bacteriana.
INDICACIÓN: Infección causada por microorganismo multirresistente para los cuales no hay alternativa segura. Opcion terapeutica cuando no hay disponible otro agente efectivo por via oral. Puede indicarse en las siguientes infecciones: Infecciones de via area superior e inferior, via urinaria, piel y partes blandas
POSOLOGIA: **6 meses a 5 años**: 10 mg/kg/dosis cada 12 hs, (dosis máxima: 500 mg/día); **mayores de 5 años**: 10 mg/kg/dosis cada 24 hs, (dosis máxima: 750 mg/día). *Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Diarrea, náuseas, vaginitis, rash, insomnio, toxicidad hepática. Hiperglucemia, hipoglucemia. Rupturas tendinosas (más frecuentemente en tendón de Aquiles) a partir de las 48 hs de tratamiento.
PRESENTACIÓN: Comprimidos 500 Mgrs y 750 Mgrs . IV 500 y 750 / 100 Ml
OBSERVACIONES: Ajustar dosis en caso de insuficiencia renal. No utilizar en embarazo, lactancia, niños y pacientes con antecedentes de epilepsia. Puede provocar ruptura de tendón de aquiles si se utiliza simultáneamente con corticoides.
ATC: J01M. Fluorquinolonas. **SOLO VIA DE EXCEPCION**

LEVOMEPROMAZINA
INDICACIÓN:Analgésico, antidepresivo, ansiolítico. Hipnótico. Antiemético.
POSOLOGIA: Niños: 0,25 a 1 mg/kg/día cada 8 -12 hs. Adultos: V.O.: 25 a 50 mg/día cada 6-8 hs, antipsicótico: 50-200 mg/día. I.M. dolor agudo: 10-20 mg/dosis cada 4-6 hs;
EFECTOS ADVERSOS: Mareos, sequedad bucal, palidez, somnolencia, cefaleas, sensación de cansancio y debilidad, constipación, agitación, insomnio, parkinsonismo, hipotensión ortostática severa, pancitopenia, agranulocitosis, fotosensibilidad.
PRESENTACIÓN: Ampollas de 1 ml: 25 mg/ml
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IM: ampolla de 25mg/ml. Cuando se tengan que administrar varias dosis, rotar sitio de inyección.
OBSERVACIONES: No administrar a pacientes que reciban antihipertensivos. Evitar la administración de medicamentos que contengan alcohol. Realizar periódicamente exámenes oftalmológicos, sanguíneos y dermatológicos. Suspender en caso de hipertermia. Administrar con precaución a pacientes con antecedentes epilépticos y en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

INTERACCIONES: Anticolinérgicos y antihistamínicos H1 potencian su efecto. Drogas mielodepresoras provocan potenciación de la leucopenia y trombocitopenia. Reduce el umbral de las crisis convulsivas con otros fármacos anticonvulsivantes
ATC: N05 - Psicolepticos. N05A – Antipsicóticos (Neurolépticos). N05AA - Antipsicóticos: Fenotiazinas

LINEZOLID
ACCION TERAPEUTICA: Oxazolidinona. Bloquea la sintesis de proteinas sobre ribosoma 50S.
INDICACIÓN: **Antibiotico de uso reservado.** Tratamineto de infecciones por germenes resistentes a Vancomicina.
POSOLOGIA: Dosis via oral o endovenosa. **Menores de 12 años:** Infecciones complicadas y por *Enterococcus faecium :* 10 mg/k/dosis cada 8 hs. Infecciones no complicadas: niños < 5 años: 10 mg/k/dosis cada 8 hs. Niños entre 5 y 12 años: 10 mg/k/dosis cada 12 hs. **Niños > 12 años**: 600 mg/dosis cada 12 hs. *Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Hipertensión, cefalea, diarrea, náuseas, trombocitopenia.
PRESENTACIÓN: Ampolla - 600 mg. Comprimido - 600 mg.
OBSERVACIONES: Controlar función renal y hepática durante el período de administración. Evaluar riesgo-beneficio en embarazo y lactancia.
INTERACCIONES: Con agentes adrenérgicos produce riesgo de hipertensión. Las drogas serotoninergicas producen riesgo de síndrome serotoninergico
ATC: Otros Antibacterianos **SOLO VIA DE EXCEPCION**

LOSARTAN DIPOTASICO
INDICACIÓN: Hipertensión. Bloqueante de los receptores de la angiotensina.
POSOLOGIA: Hipertensión: > 6 años: 0.75 mg/kg, una vez por día. Dosis máxima: 50 mg/día. Adultos: inicial: 50 mg/día, una vez por día; mantenimiento: 25 a 100 mg c/ 12 - 24 hs. En insuficiencia hepática comenzar con 25 mg una vez por día.
EFECTO ADVERSO : Hipotensión, diarrea, astenia, mareos, fatiga. Trombocitopenia, rabdomiólisis, angioedema
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 12,5 mg - 50 mg - 100 mg
OBSERVACIONES: Evitar el uso concomitante de otros inhibidores de sistema renina-angiotensina.
ATC: C09C - Antagonistas de la angiotensina II, monoterapia

LORAZEPAM
INDICACIÓN: Anticonvulsivante. Relajante muscular. Ansiolítico. Antiemético (vómitos anticipatorios).
POSOLOGIA: Ansiedad, sedación: lactantes y niños (V.O./E.V.): 0,05 mg/kg/dosis cada 4-6-8 hs (máximo 2 mg/dosis), adultos: 1-10 mg/día cada 8-12 hs. Status epilepticus (E.V./Rectal) : neonatos: 0,05 mg/kg repetir si es necesario en 10-15 min., lactantes y niños: 0,1 mg/kg (máximo 4 mg/dosis) repetir si es necesario en 10-15 min., adultos: 4 mg/dosis repetir si es necesario en 10-15 min. Antiemético: 0,05 mg/kg/dosis cada 6 hs, máximo: 4 mg/dosis.
EFECTSO ADVERSOS: Sedación excesiva, ataxia.
PRESENTACIÓN: Ampollas: 4 mg/ml
OBSERVACIONES: E.V.: Diluir previamente con igual volumen de Dx 5% o Sol.F., no exceder 2 mg/minuto
INTERACCIONES: otros depresores del S.N.C. o respiratorios pueden aumentar los efectos adversos del lorazepam. Las ampollas contienen alcohol bencílico 2%, polietilenglicol y propilenglicol (precaución en recién nacidos por toxicidad). Evitar administración intraarterial. Contraindicado en glaucoma de ángulo estrecho.
ATC: N05BA. TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA.

MEBENDAZOL
ACCION TERAPEUTICA: Antihelmíntico benzoimidazólico no absorbible que posee acción helmíntica. oxiuriasis, ascaridiasis, trichuriasis, tenias.
INDICACIÓN: Tratamineto de parasitosis: oxiuriasis, ascaridiasis, trichuriasis, tenias.

POSOLOGIA: Niños y adultos: Oxiuros: 100 mg dosis única, repetir a los 15 días. Áscaris, trichurius, tenias: 100 mg 2 veces al día durante 3 días consecutivos. Triquinosis: 5 mg/k/dia cada 12 hs durante 7 a 10 dias .
Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.

EFECTSO ADVERSOS: Dolor abdominal, reacciones cutáneas, diarrea. Raros: leucopenia, agranulocitosis.

PRESENTACIÓN: Comprimidos.: 100 MG. Susp.: 2%.

OBSERVACIONES: Dolor abdominal, diarrea. Fiebre. Neutropenia reversibles

INTERACCIONES: Carbamazepina, Acido Valproico y Fenitoína

ATC: P02. Antihelminticos P02C. Antinematodos P02CA. Derivados del Benzimidazol

METADONA

INDICACIÓN: Restringido para prevención del síndrome de abstinencia en pacientes: con más de 7 días de tratamiento con opioides E.V. o con dosis total acumulada de fentanilo mayor de 1,5 mg/kg o dosis equivalente de morfina. Para dolor neuropático que no responde a morfina.

POSOLOGIA: Prevención de síndrome de abstinencia: 1er, 2do y 3er día: 0,05-0,1 mg/kg/dosis (dosis máxima: 20 mg/dosis) cada 6 hs, dosis máxima diaria: 40 mg; ajustar la dosis hasta remisión de síntomas. Luego una dosis única matinal igual al total de la medicación administrada el día inmediato anterior. En los días posteriores iniciar el descenso a razón de un 20% diario de la dosis total inicial. Dolor neuropático: iniciar 0,1 mg/kg/dosis c/ 24 hs e ir aumentando hasta 0,1 mg/kg/dosis c/ 8 hs.

EFECTSO ADVERSOS: Aturdimiento, mareo, sedación, náuseas, vómitos, sudoración, euforia, disforia, debilidad, cefalea, insomnio, agitación, desorientación, alteraciones visuales, boca seca, anorexia, estreñimiento, espasmo del tracto biliar, rubor cutáneo, bradicardia, palpitaciones, desmayo, síncope, retención o tenesmo urinario.

PRESENTACIÓN: Comprimidos: 5-10 mg; Solución oral (preparado magistral): 1 mg/ml

OBSERVACIONES: Interacciona con difenilhidantoína, carbamacepina, rifampicina, depresores del S.N.C.

INTERACCIONES: Interacciona con difenilhidantoína, carbamacepina, rifampicina, depresores del S.N.C.

ATC: N02A OPIOIDES C52 Derivados de la difenilpropilamina.

METILPREDNISONA

INDICACIÓN: Se utiliza para terapia hormonal sustitutiva, como antiinflamatorio, como inmunosupresor y como antialérgico. Disminuye la inflamación porque suprime la migración de leucocitos polimorfonucleares y revierte el incremento de la permeabilidad capilar

POSOLOGIA: Oral: dependerá de la enfermedad y la respuesta de quien recibe el tratamiento. Dosis de ataque 10 a 20 mg/día. Mantenimiento: 4 a 8 mg/día. NIÑOS: Dosis de ataque 0,8 a 1mg/kg/día. Mantenimiento según respuesta clínica.

EFECTOS ADVERSOS: Hipertensión, hiperglucemia, úlcera péptica, miopatía, detención del crecimiento, osteoporosis, cataratas subcapsular posterior, síndrome cushingoide, alcalosis hipocalémica, edema, susceptibilidad aumentada a las infecciones, osteonecrosis.

PRESENTACIÓN: Comprimidos de 4 mg, de 8 mg y de 40 mg. Gotas 4 Mgrs/ Ml

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: VO: con alimentos disminuye la intolerancia gastrointestinal. Si se administra una vez al día, darlo por la mañana. Se puede triturar, administrar inmediatamente.

OBSERVACIONES: Pueden aparecer reacciones adversas locales y sistémicas. Reacciones alérgica. Puede producir hipertensión, calambres, mialgias, náuseas, debilidad muscular, ardor abdominal, visión borrosa. Retención de sodio. Pérdida de potasio.

INTERACCIONES: Drogas que pueden disminuir el efecto de los glucocorticoides: Barbituratos, colestiramina, hidantoínas, rifampicina, efedrina, y carbamazepina. Drogas que podrían incrementar el efecto de los glucocorticoides: anticonceptivos orales, estrógenos y ketoconazol. Los glucocorticoides pueden incrementar la toxicidad de ciclosporina y los digitálicos, disminuir la concentración de isoniacida, disminuir los niveles de salicilatos y causar hipocalcemia cuando se administran conjuntamente con diuréticos. Los relajantes musculares no curarizantes podrían producir relajación muscular más prolongada. Podría debilitarse el efecto anticoagulante de los derivados cumarínicos. Antiinflamatorios no esteroides: está aumentando el riesgo de sangrado gastrointestina

ATC: H02. Corticosteroides para uso sistemico H02A. Corticosteroides para uso sistemico Monofarmacos

MEROPENEM

ACCION TERAPEUTICA: Antibiótico de amplio espectro. Carbapenem, inhibe la sintesis de la pared bacteriana uniendose a las PBP. Los estafilococos resistentes a la meticilina (SAMR) son resistentes al meropenem. Los organismos resistentes naturales al meropenem incluyen *Stenotrophomonas maltophilia.*

INDICACIÓN: **Antibiotico de Uso reservado.** Tratmineto de infecciones graves por germenes sensibles: Neumonia, Fibrosis quistica , Infeccion de via urinaria, piel y partes blandas, intraabdominales e infecciones de SNC.

POSOLOGIA: Sepsis, infecciones del S.N.C. y fibrosis quística: 120 mg/kg/día, cada 8 hs, (Dosis máxima: 6 g/día). Infección urinaria, de piel y partes blandas y otras infecciones: 60 mg/kg/día, cada 8 hs, (Dosis máxima: 3 g/día). *Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS: Cefalea, náuseas, dolor abdominal, diarrea.

PRESENTACIÓN: FRASCO AMPOLLA 500 mg

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: reconstituir el FA de 500mg en 10ml de SF, el FA: 1g en 20ml de SF, obteniéndose una concentración de 50mg/ml. Es estable 8hs a T° ambiente y 24hs refrigerada; una vez retirada de la nevera se debe utilizar en el intervalo de 3hs.
Concentración de la dilución: IVD: administrar de 5 minutos a una concentración final de 50mg/ml. IVI: diluir con SF a una concentración recomendada de 2,5-10mg/ml. Máxima concentración: 50mg/ml. Infundir de 15-30 minutos. Puede ser infundido por 2hs, mejor actividad antimicrobiana.

OBSERVACIONES: Ajustar dosis en caso de insuficiencia renal y monitorizar función hepática en pacientes con disfunción hepática. No se recomienda su uso en embarazadas ni en período de lactancia. Las soluciones diluidas en DX 5% deben ser utilizadas en el intervalo de una hora

INTERACCIONES: El Probenecid inhibe la excreción renal de Meropenem

ATC: J01DH. Carbapenemicos

METILPREDNISOLONA

INDICACIÓN: Desórdenes endocrinos y reumáticos. Se utiliza en enfermedades dermatológicas, gastrointestinales, hematológicos, neoplásicas, respiratorias, oftálmicas y del tejido conectivo. Estados alérgicos y edematosos. Meningitis. tuberculosa. Transplante de órganos. Triquinosis.

POSOLOGIA: -IV: 30 mg/Kg. Esta dosis puede repetirse cada 6 horas por 2 días. Dmax: 1000 mg/día. NIÑOS: 0,5 mg/Kg.

EFECTOS ADVERSOS: La metilprednisolona tiene efectos secundarios severos en pacientes que toman este medicamento a largo plazo, incluyendo obesidad, osteoporosis, glaucoma y psicosis. El efecto más serio es la cesación de la producción natural de cortisol, por lo que el terminar de manera abrupta la administración de la metilprednisolona, después del uso prolongado, puede causar la aparición de una crisis de Addison, la cual puede ser mortal.

PRESENTACIÓN: Ampolla bufferizada de 500 mg.

OBSERVACIONES: Pueden aparecer reacciones adversas locales y sistémicas. Reacciones alérgica. Puede producir hipertensión, calambres, mialgias, náuseas, debilidad muscular, ardor abdominal, visión borrosa. Retención de sodio. Pérdida de potasio.

INTERACCIONES: Los barbitúricos, la fenitoína, y la rifampicina pueden aumentar la depuración de metilprednisolona; los salicilatos, los toxoides, y la metilprednisolona suelen aumentar las concentraciones séricas de ciclosporina y tacrolimus; vacunas de virus vivos (aumentan el riesgo de infección viral); las vacunas pueden tener menos efectos.

ATC: H02. Corticosteroides para uso sistemico H02A. Corticosteroides para uso sistemico Monofarmacos

METOCLOPRAMIDA

INDICACIÓN: Náuseas y vómitos, manifestaciones dispépticas debidas a un trastorno de la motricidad del tracto digestivo superior, reflujo gastro-esofágico. Antagonista potente del receptor de dopamina; bloquea los receptores de dopamina en la zona desencadenante quimioreceptora del SNC, evitando la emesis; acelera en vaciamiento gástrico; acelera el vaciamiento gástrico y el tiempo de tránsito intestinal sin estimular secreciones gástricas, biliares o pancreáticas

POSOLOGIA: IV: Niños: <6 años: 0,1 mg/kg.6-14 años: 2,5 a 5 mg.>14 años y adultos: 10 mg. Reflujo gastroesofágico: VO-IM-V: Recién nacidos, lactantes y niños: 0,4 a 0,8 mg/kg/día. Adultos: 10 a 15 mg 4 veces/día. Nauseas y vómitos postoperatorios: IV: Niños: 0.1 a 0,2 mg/kg/dosis cada 2 a 4 h. Gastroparesia diabética: Adultos: VO-IV: 10 mg antes de cada comida y al acostarse por 2 a 8 semanas.

EFECTOS ADVERSOS: Síntomas extrapiramidales (más comunes en niños y adultos jóvenes, especialmente luego de dosis altas por vía E.V.), convulsiones, síndrome maligno neuroléptico. Ocasionalmente: somnolencia, inquietud, depresión, diarrea.

PRESENTACIÓN: Ampolla 10 mg/2 ml. Gotas 2 mg/ ml. X 20 Ml (0,1 Mgrs Gota)

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: VO: ingerir 20 minutos antes de las comidas. Solución comercial, concentración de 1 a 2,6mg/ml (ver presentación comercial).

OBSERVACIONES: Reducir la dosis en insuficiencia renal, hipertensión o depresión. Los antimuscarínicos y los analgésicos opioides antagonizan su efecto. Contraindicada en epilepsia, parkinson, combinación con levodopa o agonistas dopaminérgicos. Riesgo de reacciones extrapiramidales en especial: niños y adolescentes.

INTERACCIONES: Disminuye la absorción gastrointestinal de cimetidina y digoxina; incrementa la absorción intestinal de ciclosporina; la levodopa disminuye los efectos de la metoclopramida; aumenta los episodios de hipertensión con IMAO; incrementa los efectos bloqueadores neuromusculares de la succinilcolina; los anticolinérgicos y los analgésicos narcóticos antagonizan los efectos de la metoclopramida en la motilidad gastrointestinal.

ATC: A03. Agentes contra padecimientos funcionales del estomago e intestino. A03F. Propulsivas

METRONIDAZOL

ACCION TERAPEUTICA: Inhibe la replicación, transcripción, y reparación de la cadena de ADN. Amplio espectro antimicrobiano frente a protozoos y bacterias anaerobias.

INDICACIÓN: Infecciones por anaerobios. Antiprotozoario: amebiasis intestinal y extraintestinal, giardiasis, trichomoniasis. Ginecología: Triconoma vaginalis, Gardnerella vaginalis (tratamiento local). Profilaxis para ITS (Trichomonas spp).

POSOLOGIA: Infecciones anaeróbicas (V.O.;E.V.): 30 mg/kg/día cada 8 hs, dosis máxima: V.O.: 2 g; E.V.: 4 g. Amebiasis: 35 mg/kg/día cada 8 hs durante 10 días. Profilaxis para ITS: Niños: V.O.: 15 mg/kg/día, cada 8 hs durante 7 días; adolescentes: V.O.: 2 g/dosis, única dosis. Giardias y trichomonas: 15 mg/kg/día cada 8 hs durante 5 días. Clostridium difficile: 30 mg/kg/día cada 6 hs. *Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, sabor metálico, cefaleas, anorexia, diarrea, boca seca, glositis, estomatitis, neuropatías, rash, neutropenia reversible.

PRESENTACIÓN: Comprimido - 500 mg. Sachet - 500 mg/100 ml.

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución***: administrar solo por IVD sin diluir a una concentración de 5mg/ml. Infundir de 30-60minutos. Proteger de la luz. En neonatos y lactantes pequeños se puede diluir con SF o DX 5%. . La solución tiene estabilidad 24hs a T° ambiente en Sachet Flex, con puerto de inyección. De lo contrario, usar y descartar.
VO: preferentemente en ayunas. Con alimentos si hay intolerancia gastrointestinal.

OBSERVACIONES:Administrar en forma lenta (30 minutos). Deberá evaluarse la relación riesgo-beneficio en enfermedades orgánicas activas del SNC, incluyendo epilepsia, discrasias sanguíneas, disfunción cardíaca o hepática severa. No se recomienda su uso en embarazo y período de lactancia. Sachet rígido no se recomienda su conservación una vez abierto, por inestabilidad microbiológica.

INTERACIONES: Alcohol produce reacción semejante a disulfiram. Anticoagulantes orales aumenta el efecto anticoagulante. Fenobarbital, hidantoínas aumenta el metabolismo del metronidazol y disminuye su metabolismo

ATC: J01M. Fluorquinolonas

MICONAZOL

INDICACIÓN: Profilaxis y tratamiento de candidiasis orofaríngea moderada. Es un fungistático, aunque puede ser fungicida con dependencia de la concentración. Actúa por inhibición de la biosíntesis del ergosterol o de otros esteroles, lo que lesiona la membrana de la pared celular fúngica y altera su permeabilidad; como consecuencia, puede producirse la pérdida de orgánulos intracelulares esenciales. Inhibe también la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos de los hongos, y la actividad de las oxidasas y peroxidasas, que da como resultado un aumento intracelular de concentraciones tóxicas de peróxido de hidrógeno, lo que puede contribuir a la necrosis celular.

POSOLOGIA: Vía tópica: aplicar en la piel dos veces por día.

EFECTO ADVERSO: Vía tópica: rash cutáneo, formación de ampollas, prurito o enrojecimiento en la zona de aplicación.

PRESENTACIÓN: Pomo x 20 g

OBSERVACIONES: Administrar previa higiene bucal. Mantener en la boca el mayor tiempo posible (más de 15min) y después tragar. Tras la desaparición de los síntomas, prolongar el tratamiento, al menos, 48 horas.

ATC: A01AB Antiinfeccioso y Antisepticos para el tratamiento Oral-Local

MIDAZOLAM

INDICACIÓN: Inductor de sueño, inductor anestesia general. En status epiléptico puede ser alternativa a otras benzodiacepinas.

POSOLOGIA: Sedación consciente: 0,05-0,2 mg/kg/dosis. Sedación procedimiento V.O.: 0,1-0,2 mg/kg/dosis, 30-45 minutos pre-procedimiento, dosis máxima: 15 mg. Status epilépticus, intubación endotraqueal, A.R.M.: (E.V.-I.M.-Rectal): 0,1 - 0,3 mg/kg/dosis; (Infusión continua): 0,05 - 0,3 mg/kg/hora.

EFECTO ADVERSO: Cefalea, vértigo, depresión cardiorrespiratoria, dolor en el sitio de inyección.

PRESENTACIÓN: Ampollas de 3 ml: 5 mg/ml

INTERACCIONES: Acción y toxicidad potenciada por: eritromicina, claritromicina.
Acción potenciada por: antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos/sedantes.
Concentración plasmática disminuida con: rifampicina, carbamazepina/fenitoína,

ATC: N05A Antipsicóticos CD Derivado de Benzodiazepina

MORFINA

INDICACIÓN: Dolor agudo y crónico, moderado o severo. Tratamiento sintomático de disnea. Crisis de disnea y cianosis. Opiáceo fuerte.

POSOLOGIA: E.V.; S.C.; I.M.: 0,05 mg/kg cada 4 hs; Infusión continua: 0,1 mg/kg/hora; >60 kg: Dosis inicial E.V.: 5 mg cada 4 hs. Aumentar la dosis 50% cada vez hasta alcanzar dosis efectiva.

EFECTOS ADVERSOS: depresión respiratoria, náuseas, vómitos, constipación, retención urinaria, miosis, hipotensión, contracción del esfínter de Oddi, embotamiento mental, prurito, rash.

PRESENTACIÓN: Ampollas: 10 mg/ml

OBSERVACIONES: Es recomendable asociar un AINE. Recordar que el dolor neuropático responde parcialmente a los opiáceos (asociar adyuvantes). Equivalencia analgésica: 1 mg de morfina E.V. = 2 mg de morfina V.O.; 1 mg de morfina E.V. = 10 µg de fentanilo

ATC: N02AA. Alcaloides naturales del opio.ANALGÉSICOS OPIÁCEOS

MULTIVITAMINICO (VI-SYNERAL)

INDICACIÓN: Suplementar los requerimientos diarios de vitaminas en adultos o niños mayores de 12 años que reciben nutrición parenteral. De igual manera, se emplea en otras situaciones donde se utilizan las infusiones intravenosas como cirugía, quemados, politraumatizados, estados infecciosos severos, pacientes comatosos, etc.

POSOLOGIA:1 frasco-ampolla por día.

EFECTOS ADVERSOS: Puede presentarse náusea, regurgitación con sabor a las vitaminas, diarrea, constipación y rash cutáneo

PRESENTACIÓN: Formula aproximada: Vit B1: 10mg; Vit B2: 5,47mg; Vit B5: 6mg; Vit B6: 4mg; Nicotinamida 40mg; Agua destilada csp 2ml.
Ampollas Intramuscular, Intravenosa

OBSERVACIONES: Pueden aparecer interacciones si se administra simultáneamente con diuréticos, soluciones alcalinas, tetraciclinas o sales de calcio.

ATC: A11. Vitaminas

MUPIROCINA

INDICACIÓN: Antibiótico tópico. Infecciones superficiales de la piel. Tratamiento de descolonización para S. aureus y S. pyogenes en nariz y piel.

POSOLOGIA: Crema: lactantes > 3 meses, niños y adultos: aplicar una cantidad pequeña 3 veces al día durante 10 díaS

EFECTOS ADVERSOS: Ardor, escosor,dolor en el area, sarpullido, picazon. Dolor de cabeza, nauseas leves.
PRESENTACIÓN: Crema tópica 2%.
OBSERVACIONES: Solo para uso tópico. No aplicar en el ojo.
ATC: D06 Antibioticos y Quimioterapicos Topicos. D06A Antibioticos para uso Topico

NALBUFINA
INDICACIÓN: Analgésico agonista - antagonista. Adyuvante de la anestesia.
POSOLOGIA: 0,1 - 0,3 mg/kg/dosis cada 4-6 hs Adultos: 10 mg/dosis cada 4-6 hs Coadyuvante de la anestesia: 150-500 µg/kg. Reducir la dosis en insuficiencia hepática.
EFECTOS ADVERSOS: Sedación, sudoración, somnolencia, vértigo, sequedad de boca, dolor de la cabeza; disforia; vómito, náusea.
PRESENTACIÓN: Ampollas: 10 mg/ml
INTERACCIONES: Efecto disminuido por: morfina, dextropropoxifeno, metadona. Toxicidad (depresión respiratoria) aumentada por: derivados de morfina (analgésicos y antitusivos), antidepresivos sedantes, antihistamínicos H1 sedante, barbitúricos, benzodiacepinas, ansiolíticos distintos de las benzodiacepinas, neurolépticos, clonidina y sustancias similares.
OBSERVACIONES: Por ser un agonista-antagonista se debe dejar un intervalo > de 1 hora si se administra otro opiáceo.
ATC: N02AF Derivados del morfinano

NALOXONA
INDICACIÓN: Antagonista de los opioides y derivados.
POSOLOGIA: Recién nacidos: 0,01 mg/kg (dosis máxima: 0,1 mg) cada 2-3 minutos hasta obtener respuesta; niños mayores: 0,01 mg/kg (dosis máxima: 0,2 mg), Adultos: 0,4-2 mg cada 2-3 minutos si es necesario. Infusión continua: 2,5-160 µg/kg/hora.
EFECTOS ADVERSOS: En sobredosis: náuseas y vómitos (raramente).
PRESENTACIÓN: Ampollas: 0,4 mg/ml
OBSERVACIONES: Debe ser utilizado por médicos entrenados en su uso. No produce depresión respiratoria, farmacodependencia ni síndrome de abstinencia.
ATC: V03AB15 VARIOS OTROS PRODUCTOS TERAPEUTICOS ANTIDOTO

NEOSTIGMINA
INDICACIÓN: Antídoto contra bloqueadores neuromusculares; colinérgico; agente diagnóstico en miastenia gravis. Tratamiento de miastenia gravis; prevención y tratamiento de distensión vesical y retención en el área postoperatorias; reversión de los efectos de fármacos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes después de cirugía
POSOLOGIA: 0.04-0.06 mg/kg/dosis.
EFECTOS ADVERSOS: Provoca aumento de todas las secreciones glandulares. Produce taquicardia e hipotensión.
PRESENTACIÓN: Amp (como metilsulfato): 0.5 mg/ml.
OBSERVACIONES: Hipersensibilidad a la droga, obstrucción gastrointestinal y genitourinario, peritonitis.
INTERACCIONES: Antagoniza los efectos de relajantes musculares no despolarizantes (por ej.: pancuronio, tubocurarina); la atropina y el magnesio antagonizan los efectos muscarínicos de la neostigmina; los corticoesteroides pueden disminuir los efectos de la neostigmina; prolonga los efectos de relajantes musculares despolarizantes (por ej.: succinilcolina)
ATC: NO7A Parasimpaticomimeticos

NISTATINA
ACCION TERAPEUTICA: Antifúngico con acción fungistática que pertenece al grupo de los poliénicos alterando los esteroles de la membrana del hongo.
INDICACIÓN: Candidiasis orofaríngea y candidiasis intestinal

POSOLOGIA: **Candidiasis oral**: Lactantes: 200.000 U 4 veces/día o 100.000 U en cada lado de la boca 4 veces/día. Niños y adultos: 400.000 a 600.000 U 4 veces/día. **Infecciones intestinales**: Lactantes: 100.000-300.000 UI cada 6 horas. Niños y adolescentes: 250.000-750.000 UI cada 6 horas.
Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.

EFECTOS ADVERSOS: Diarrea, náuseas, vómitos.

PRESENTACIÓN: Susp oral: 100.000 U/ml.

OBSERVACIONES: Administracion Oral: realizar buches y retener cuanto tiempo sea posible antes de deglutirse. En recién nacidos y lactantes, "pintar" con la suspensión en los recesos de la boca.

INTERACCIONES: Aumenta los niveles de: amitriptilina, cisapride, hidantoinas, anticoagulantes orales, midazolam, rifampicina, rifabutina, tacrolimus, teofilina, zidovudina.

ATC: A07A. Antiinfecciosos Intestinales. A07AA. Ntibioticos

Nitrato de Miconazol (Hipoglos Mico)

ACCION TERAPEUTICA: Antimicótico, antibacteriano (con especial acción contra las bacterias Gram positivas), cicatrizante.

INDICACIÓN: Tratamiento de la dermatitis moniliásica (o micótica) de la zona afectada

POSOLOGIA: Aplicar sobre toda la zona inflamada, lavando previamente la misma, si fuera necesario. La duración del tratamiento será la indicada por el médico. No se debe usar vendajes oclusivos

EFECTOS ADVERSOS: Irritación local.

PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 30 g.

OBSERVACIONES: Evitar el contacto con los ojos o las mucosas. Conservar a temperatura ambiente menor de 30°C.

ATC: D – Terapia Dermatologica

NITROPRUSIATO DE SODIO

INDICACIÓN: : Crisis hipertensivas y HTA maligna. Feocromocitoma. Para obtener hipotensión controlada en cirugía. Insuf. cardiaca y shock cardiogénico. Periodo de recuperación tras IAM. Aneurismas disecantes.

POSOLOGIA: Inicial: 0.5-1 mcg/kg/min. Mantenimiento: hasta 4-6 mcg/kg/min.

EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, sudoración, inquietud, cefalea, palpitaciones. Intoxicación por tiocianato.

PRESENTACIÓN: Ampolla - 50 mg

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: Reconstituir con el solvente del producto (no usar otro diluyente).
IVC: Diluir en dextrosa al 5% en una concentración recomendada de 0,2 mg/ml; máxima concentración: 1mg/ml. Es estable por 24hs y protegido de la luz.

OBSERVACIONES: La dilución dura 24 hs si se mantiene protegida de la luz.En tratamientos prolongados (más de 3 días) es conveniente la determinación de tiocianato en sangre. Evitar en embarazo y lactancia. La solución presenta una ligera coloración pardorojisa. Descartar si cambia de color

INTERACCIONES: No asociar con otros fármacos antihipertensivos, en especial diuréticos y clonidina. El uso simultáneo de dobutamina puede ocasionar un gasto cardiaco mayor. Los estrógenos o simpaticomiméticos pueden reducir los efectos hipotensores del nitroprusiato

ATC: C02D. Agentes que actuan sobre el musculo liso arteriolar

OCTREOTIDE

INDICACIÓN: Inhibición de la hormona de crecimiento y de los pépticos gastrointestinales. Es un análogo de la somatostatina, de acción prolongada e inhibe la secreción patológicamente aumentada de hormona de crecimiento y de los péptidos y serotonina producidos dentro del sistema endocrino gastroenteropancreático.

POSOLOGIA: Varices 25 µg/hora IV contínua durante 5 días. Otros 0,05 mg. SC 1 o 2 veces al día.

EFECTO ADVERSO: Reacciones dérmicas de hipersensibilidad, caída del cabello transitoria, bradicardia, cálculos biliares en uso prolongado, anorexia, nauseas, vómitos, dolor abdominal espasmódico, meteorismo, flatulencia, diarrea.

PRESENTACIÓN: Amp. 5 ml: 0,1 mg.

OBSERVACIONES: Se recomiendan exámenes cada 6-12 meses de la vesícula biliar, debido al riesgo de formación de cálculos biliares en tratamientos prolongados.

INTERACCIONES: Reduce la absorción intestinal de ciclosporinas, aumenta la disponibilidad de bromocriptina. Interfiere con los productos metabolizados por el citocromo p 450.

ATC: H01CB Inhibidores de la Hormona de Crecimiento

OMEPRAZOL

INDICACIÓN: Tratamiento sintomático del reflujo gastroesofágico en caso de resistencia o inadaptación a los tratamientos iniciales. Tratamiento de la esofagitis por reflujo, úlcera gástrica y/o duodenal, erosiones gástricas o duodenales asociadas con la administración de antiinflamatorios no esteroides (AINE), úlcera duodenal asociada con H. pylori, síndrome de Zollinger–Ellison y dispepsia ácida.

POSOLOGIA: Úlcera duodenal y gástrica (asociada o no a AINE), esofagitis por reflujo: 20 mg/día, mala respuesta: 40 mg/día.
VE: 0,7-3,3 mg/kg/día. Prevención de úlceras administrar cada 24 hs (para dosis < 80 mg); hemorragias digestivas administrar cada 8 hs según evolución y luego cada 12-24 hs; úlceras duodenales: 120 mg/día cada 8 hs; síndrome de Zollinger-Ellison: 60 mg/dosis cada 8 hs, seguido de una terapia de mantenimiento V.O. de 90 mg/dosis cada 12 hs y luego cada 24 hs.

EFECTOS ADVERSOS: Diarrea, náuseas, constipación, dolor abdominal,vómitos, cefalea, mareos,nefrittis intersticial.

PRESENTACIÓN: Frasco ampolla 40 mg. Comprimido 20 mg. Comprimido 10 mg.

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: Reconstitución: reconstituir con el solvente que trae el fabricante. Es estable por 4hs a T° ambiente.
IV: IVD: infundir lentamente sin diluir a una velocidad máxima de 4ml/min. IVI: reconstituir el FA con 10ml de Solución fisiológica (estabilidad 12hs, T° ambiente), tomar la dosis indicada y diluir con solución fisiológica a una concentración de 0,4 mg/ml; administrar en 30 min. Idem con dext 5% (estabilidad 6hs, T° ambiente). IVC: poco recomendada en pediatría.
VO: capsula: no masticar ni aplastar los gránulos, se puede abrir la capsula y administrar el contenido con yogurth o jugo de naranjas. **Formulacion Magistral** : 2 mg/ ml Estable 14 dias a temperatura ambiente. 45 dias en Heladera.

OBSERVACIONES: Debe administrarse preferentemente por las mañanas. Precaución en pacientes con trastornos de la función hepática. Puede prolongar la eliminación de medicamentos que sufren metabolización oxidativa hepática por ejemplo: diazepam, fenitoína, warfarina, claritromicina, digoxina. Alterala concentración de: ketoconazol, sales de hierro. Contraindicado con atazanavir.
VO: no aplastar ni triturar los gránulos, se puede abrir la cápsula y administrar el contenido con yogur o jugo de naranja. Tener presente la solución utilizada para su reconstitución ya que varía el tiempo de estabilidad.

INTERACCIONES: Disminuye la absorción de ketoconazol, itraconazol, sales de hierro, esteres de ampicilina. Incrementa la vida media de diazepan, fenitoina y warfarina. Puede aumentar la absorción de digoxina y didanosina; disminuye la eliminación de metotrexato

ATC: A02BC. Inhibidores de la Bomba de protones

ONDANSENTRON

INDICACIÓN: Antiemético; antagonista del receptor 5-HT3. Antagonista selectivo del receptor 5-HT3, bloquea las serotonina periféricamente en terminales nerviosas vagales y centralmente en la zona quimiorreceptora desencadenante. Prevención de náuseas y vómitos relacionados con quimioterapia o radioterapia de cáncer muy hematógenas y prevención de náuseas y vómitos postoperatorios

POSOLOGIA: IV: > 3 años: 5 mg/m2/dosis o 0,15 mg/kg/ dosis cada 8 h. VO: < 4 años:(según superficie corporal): < 0.3 m2: 1 mg cada 8 h; 0.3-0.6 m2: 2 mg cada 8 h; 0.6-1 m2: 3 mg cada 8 h; > 1 m2: 4 mg cada 8 h. 4 a 12 años: 4 mg/dosis;> 12 años: 8 mg/dosis cada 8-12 h. DOSIS MAXIMA: 8 mg/dosis.

EFECTOS ADVERSOS: Cefalea, sensación de calor en la cabeza y en el epigastrio, constipación, precordialgia, hipotensión, bradicardia. Vértigo con la administración rápida.

PRESENTACIÓN: Amp: 4-8 mg/5 ml.

OBSERVACIONES: Hipersensibilidad a la droga, otros antagonistas del receptor 5-HT3

INTERACCIONES: Interacciones con los siguientes medicamentos: Carbamazepina, fenitoína, rifampicina, inductores enzimáticos hepáticos, inhibidores enzimáticos hepáticos

ATC: A04 Antihemeticos y Antinauseosos. A04AA Antagonistas de receptores de Serotonina (5-HT3)

OSELTAMIVIR FOSFATO
ACCION TERAPEUTICA: Antiviral. Inhibe la neuraminidasa del virus de influenza.
INDICACIÓN: Tratamiento de la influenza (A o B) en adultos y mayores de 1 año dentro de los 2 primeros días de haber comenzado los síntomas. **Indicaciones segun recomendaciones epidemiologicas. Ver Alertas Epidemiologicas CECI:** https://sites.google.com/view/sitio-de-ceci-him/inicio
POSOLOGIA: Tratamiento: Menor de 8 meses: 3 mg/k/dosis cada 12 hs. De 9 a 11 meses: 3.5 mg/k/dosis cada 12 hs. De 1 a 12 años: < 15 kg: 30 mg cada 12 hs, 15 a 23 kg: 45 mg cada 12 hs, 23 a 40 kg: 60 mg cada 12 hs, >40 kg y adulos: 75 mg cada 12 hs. Duración del tratamiento 5 dias. *Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.*
EFECTOS ADVERSOS: Insomnio, vértigo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, conjuntivitis, epistaxis, desórdenes en el oído. Trastornos de conducta. Delirio, ideación suicida.
RESENTACIÓN: Cápsulas 75 mg, solución 12 mg/ml
OBSERVACIONES: Hipersensibilidad al oseltamivir, cualquier componente de la fórmula u otros inhibidores de la neuraminidasa con base en ácido sialico.
INTERACCIONES: Sus niveles y efectos pueden aumentar por Probenecid
ATC: J05 Antivirales de uso sitemico. J05A Antivirales de accion directa. J05AB Nucleosidos y Nucleotidos, excluidos inhibidores de la transcriptasa reversa. J05AH Inhibidores de la Neuraminidasa

PARACETAMOL
INDICACIÓN: Analgésico y antipirético de potencia similar a AAS, sin acción antiinflamatoria. De elección frente a AAS en alteraciones de coagulación, en úlcera péptica y estados febriles por procesos virales en niños. Útil en lactancia a dosis terapéuticas. Antídoto en caso de sobredosificación: N-acetilcisteína. ORAL-Dolor leve a moderado. PARENTERAL-Tratamiento a corto plazo del dolor moderado, especialmente después de cirugía y para el tratamiento a corto plazo de la fiebre, cuando la administración por vía IV está justificada clínicamente por una necesidad urgente de tratar el dolor o la hipertermia y/o cuando no son posibles otras vías de administración.
POSOLOGIA: Niños: 10 mg/kg/dosis cada 4 a 6 hs. DOSIS MAX: 2,6 g/día. Adultos: 325 a 650 mg/día cada 4 a 6 hs. DOSIS MAX: 4 g/día. EV. Adultos: 500mg a 1.000mg por vez, sin superar los 4g por día. Niños: 30mg/kg/día.
EFECTOS ADVERSOS: Reacciones dermatológicas, discrasias sanguíneas y lesión renal por uso crónico. En sobredosis: necrosis tubular renal y hepática, coma hipoglucémico.
PRESENTACIÓN: Comp: 500 mg. Solución: 10 % . Frasco Ampolla 1O mg/ Ml x 50 ml
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución:*** no requiere dilución. Infundir de 15-30 minutos. El sachet con puerto de inyección es estable 24hs a T° ambiente (no refrigerar) y proteger de la luz. VO: en ayunas para una rápida acción
OBSERVACIONES: Hipersensibilidad a la droga. No administrar a pacientes con úlcera péptica ni a pacientes con insuficiencia hepática o alcoholismo. Advertencia: puede causar intoxicación hepática grave en casos de sobredosis. La coloración amarillenta no implica inactividad.
INTERACCIONES: Sustrato del citocromo P450, de las isoenzimas CYP1A2, CYP2A6, C9,D6, E1.Los inductores enzimáticos (barbitúricos, carbamazepina, fenitoina, rifampicina) con grandes dosis de paracetamol; la isoniacida y alcohol (en especial en el uso crónico) pueden incrementar la hepatotoxicidad. El paracetamol puede incrementar la depuración de la lamotrigina, y la concentración y toxicidad de la zidovudina. Puede aumentar el efecto anticoagulante cuando se administra concomitantemente con estos (monitorear el tiempo de protrombina).
ATC: N02 Analgesicos N02BE Anilinas

PENICILINA G SODICA
ACCION TERAPEUTICA: Antibiótico betalactámico bactericida. Inhibe la formacion de la pared celular de las bacterias, al actuar sobre las PBP.

INDICACIÓN: Indicada como primera elección en infecciones por cocos grampositivos sensibles, tanto aerobios como anaerobios, excepto estafilococos y algunos casos de enterococos. En el caso del Neumococo, tratar según el porcentaje de resistencias locales. Tratamiento de primera linea en Sifilis.

POSOLOGIA: Lactantes y niños: IM-IV: 100.000 a 250.000 U/kg/dia en fracciones cada 4 o 6 h. Infecciones graves (Meningitis, sepsis) : 250.000 a 400.000 U/kg/dia enfracciones cada 4 a 6 h. DOSIS MAX: 24.000.000 U/día. Meningitis por *Estreptococcos grupo B* Niños: 450.000 - 500.000 U.I./kg/día cada 6 hs; Sífilis congénita: lactantes > 1 mes y niños: 50.000 U.I./kg/dosis cada 4 - 6 hs. Neurosífilis: dosis máxima 18.000.000 U.I. - 24.000.000 U.I.

EFECTOS ADVERSOS: Rash dérmico, urticaria, fiebre, dolor, eosinofilia, anemia hemolítica, leucopenia. En uremia o altas dosis: convulsiones.

PRESENTACIÓN: Frasco Ampolla - 3.000.000 UI.

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: reconstituir el FA de 1M en 4,5 de AD, concentración: 200.000UI/ml; el FA de 3M reconstituir en 9ml de AD, concentración: 300.000UI/ml. Estabilidad: 6hs a T° ambiente, aunque se recomienda preparar en el momento de la administración y desechar el resto.
Concentración de la dilución: administrar solo por vía IVI: diluir en SF a una concentración recomendada: 10.000-30.000UI/ml. Máxima concentración: 50.000UI/ml. Infundir de 60min a 2hs.
IM: poco recomendado es pediatría.

OBSERVACIONES: Las dosis masivas de sodio pueden causar hipernatremia. Si la función renal es insuficiente las dosis elevadas pueden causar irritación meníngea y convulsiones. El probenecid disminuye la excreción renal de penicilina y alarga su vida media. La infusión IV no es compatible con suero glucosado.

INTERACCIONES: Probenecid aumenta la concentración sérica de penicilina; la actividad bacteriana con aminoglucósidos es sinérgica; las tetraciclinas, cloranfenicol y eritromicina pueden antagonizar la actividad de la penicilina

ATC: J01CA. Aminopenicilinas J01CE. Penicilinas

PENICILINA BENZATIDICA

ACCION TERAPEUTICA: Antibiótico betalactámico bactericida. Inhibe la formacion de la pared celular de las bacterias, al actuar sobre las PBP.

INDICACIÓN: Tratamiento de la faringitis producida por estreptococos, profilaxis en el largo plazo de la fiebre reumática y tratamiento de las sífilis.

POSOLOGIA: Lactantes y niños: **Faringitis estreptococcica** : 50.000 U/kg en dosis única. DOSIS MAX: 1.2 millones de U/dosis. Niños < 30 kg: 600.000 U en dosis única. Niños > 30 kg. 1.200.000 U en dosis única.
Prevención secundaria de fiebre reumática: ≤ 27 Kg: I.M.: 600.000 U.I. cada 3 a 4 semanas; > 27 kg: I.M.: 1.200.000 U.I. cada 3 a 4 semanas. **Sífilis:** 50.000 U.I./kg/dosis, 1 a 3 dosis según tiempo de evolución; dosis máxima: 2.400.000 U.I.

EFECTOS ADVERSOS: Reacciones alérgicas, sobre todo cutáneas. Anemia hemolítica, leucopenia.

PRESENTACIÓN: Frasco Ampolla - 2.400.000 UI. - 1.200.000 U.I

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: Solo por vía IM: reconstituir la presentación de 1.200.000UI en 3ml de lidocaína al 1% + 2ml de AD. La presentación de 2.400.000UI en 3ml de lidocaína al 1% + 7mlde AD. En ambas diluciones nos da una concentración 240.000UI/ml. No conservar. Su administración deber ser profunda y lenta. Variar el sitio de inyección

OBSERVACIONES:Deben investigarse antecedentes alérgicos antes de iniciar el tratamiento con penicilina. Se debe administrar con precaución en pacientes con enfermedad gastrointestinal, ya que puede producir colitis pseudomembranosa, y en presencia de disfunción renal. Puede provocar granulocitopenia y anemia hemolítica. El probenecid disminuye la excreción renal de penicilina y alarga su vida media. Nunca administrar IV.

INTERACCIONES: Probenecid aumenta la concentración sérica de penicilina; la actividad bacteriana con aminoglucósidos es sinérgica; las tetraciclinas, cloranfenicol y eritromicina pueden antagonizar la actividad de la penicilina.

ATC: J01CA. Aminopenicilinas J01CE. Penicilinas

PERMETRINA

INDICACIÓN: Antiparasitario tópico, pediculicida, escabicida. Inhibe la entrada del ión sodio a través de los canales de la membrana de células nerviosas del parásito, lo que resulta en retraso de la repolarización, parálisis y muerte del microorganismo. Infecciones con Pediculis humans capitis (piojo de la cabeza) y liendres. Terapéutica de Sarcoptes Scabieil (sarna).

POSOLOGIA: Pediculosis: masajear durante 5 a 10 min. sobre el pelo, luego enjuagar. Repetir a los 8 días. Escabiosis: Esparcir por todo el cuerpo dejar actuar de 6 a 10 h y luego lavar con agua y jabón suave. El tratamiento se repite 3 veces con intervalo de 5 días entre cada aplicación. No aplicar sobre heridas o quemaduras. Solo uso externo. No aplicar cerca de los ojos o mucosas.

EFECTOS ADVERSOS: Irritante local, no se absorbe por piel. Puede aumentar el prurito.

PRESENTACIÓN: Loción 1 % (pediculicida). Pomada 5% (escabicida). Emulsión: Permetrina + Benzoato de bencilo

OBSERVACIONES: Prurito, eritema, ardor, picazón.

ATC: P03. Antiparasitario , Insecticida, Repelentes. P03. Ectoparasiticidas, Escabicidas

PIPERACILINA-TAZOBACTAM

ACCION TERAPEUTICA: Penicilina semisintética. Bactericida, combinada con un inhibidor de betalactamasa.

INDICACIÓN: Tratamiento de infecciones graves producidas por gérmenes grampositivos, gramnegativos y anaerobios sensibles. Indicacion en neumonia intrahospitalaria, infeccion de vias urinarias , intraabdominales y en Neutropenia febril en pacientes oncohematologicos.

POSOLOGIA: Niños: 300 mg/kg/día cada 6-8 hs; Fibrosis quística: 500 mg/kg/día cada 6-8 hs. . Dosis máxima: 18 g/día. La dosis estándar cada 8 horas es adecuada en infecciones no complicadas. En caso de alta sospecha de infección por *Pseudomonas* (neutropenia febril) debe priorizarse la administración cada 6 horas. *Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS: Insomnio, cefalea, confusión, convulsiones, rash, prurito, edema, diarrea, constipación, náuseas, vómitos.

PRESENTACIÓN: Frasco Ampolla - 4500 mg.

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: reconstituir el FA de 4,5g en 20ml de AD o SF, obteniéndose una concentración de 200mg/ml de piperacilina. Es estable 24hs a T° ambiente y 48hs refrigerado.
Concentración de la dilución: IVI: diluir en SF o DX 5% a una concentración recomendada de 10mg/ml. Máxima concentración: 20mg/ml. Infundir de 30-60minutos ***Datos consignados en base a la piperacilina.***

OBSERVACIONES: Ajustar dosis en caso de insuficiencia renal. Evaluar los parámetros de coagulación durante su uso. No se recomienda utilizar en embarazdas ni en niños menores de 2 años. Reacciones de Rash, diarrea y eosinofilia. Moderado incremento de enzimas hepáticas. Vértigo. Cambios en el comportamiento. Nauseas y vómitos

INTERACCIONES: Con cefoxitina produce antagonismo de P.aeruginosa

ATC: J01CR. Penicilinas combinadas con inhibidores de la Beta-Lactamasa

PIRIDOXINA VITAMINA B6

INDICACIÓN: Prevención y tratamiento de la deficiencia de vitamina B6, convulsiones piridoxina dependientes en lactantes. Neuropatía perférica B6 dependiente inducida por isoniacida, cicloserina, pirazinamida, penicilamina. Tratamiento de la intoxicación aguda por isoniacida, cicloserina.

POSOLOGIA: R.N.D: 0-6 meses: 0,1 mg; 7-12 meses: 0,3 mg; 1-3 años: 0,5 mg; 4-8 años: 0,6 mg; 9-13 años: 1 mg; > 14 años: 1,3- 1,7 mg; embarazadas: 1,9 mg; lactancia: 2 mg. Convulsiones: inicial (V.O.):100 mg, mantenimiento (V.O.) 15 - 30 mg/kg/día, máximo 500 mg/día. Deficiencia: tratamiento: V.O.: 5-25 mg/día por 3 semanas, mantenimiento: 1,5 - 2,5 mg/día en algún polivitamínico. Neuropatía periférica relacionada a drogas (isoniacida, hidralazina, penicilamina, cicloserina): (V.O.) neonatos: tratamiento: 10 - 50 mg/día, profilaxis: 5 - 10 mg/día; niños: tratamiento: 10-50 mg/día, profilaxis: 1-2 mg/kg/día; adultos: isoniacida o penicilamina: tratamiento: 100-200 mg/día por 3 semanas, profilaxis: 25-100 mg/día. Intoxicación por isoniacida: dosis de ataque: 50% de la cantidad de isoniacida calculada como absorbida, se completa la dosis en 24 hs, en los tratamientos con penicilamina 1 dosis diaria.

EFECTOS ADVERSOS: Tratamientos prolongados: neuropatía periférica, deficiencia de ácido fólico, distrés respiratorio en neonatos, rash.

PRESENTACIÓN: Comprimidos: 100 mg

OBSERVACIONES: En otras presentaciones viene asociado con otras vitaminas y minerales. Disminuye niveles séricos de fenobarbital y difenilhidantoína. Reduce el efecto de la levodopa. Piridoxina se administra como profilaxis de neuropatía periférica en caso de malnutrición, diabetes, insuficiencia renal crónica. La vía de administración y el ritmo en intoxicaciones dependen del cuadro clínico. En insuficiencia hepática crónica puede haber deficiencia de piridoxina.
INTERACCIONES: Disminuye la efectividad de la levodopa cuando se utiliza sin carbidopa; disminuye las concentraciones séricas de fenobarbital y fenitoína
ATC: A11HA Vitaminas y Cofactores

POLIESTIRENO SULFONATO DE CALCIO
INDICACIÓN: Antihiperkalemico. Retira el potasio al intercambiar iones de calcio por iones de potasio en el intestino antes de que la resina sea eliminada del organismo
POSOLOGIA: Niños: 1g/kg/dosis cada 6 hs. Adultos: VO: 15-50 g 1-4 veces/dia; Enema: 30 a 50 g en 150-200 ml de agua o dextrosa al 5% cada 6 hs.
EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, estreñimiento, hipercalcemia, hipocaliemia, hipomagnesemia. Prematuros y neonatos (rectal): hematoquecia.
PRESENTACIÓN: Envase x 1 Kilo. Sellos según dosis indicada. Contiene 80 mg de calcio/g de resina.Envases conteniendo 20 y 50 sobres con 5 gr de polvo.
OBSERVACIONES: No mezclar con jugo de naranja.
ATC: V03AE Farmacos para el tratamiento de la Hiperpotasemia e Hiperfosfatemia

POLIETILENGLICOL 3350
INDICACIÓN: Laxante osmótico, evacuante intestinal. Induce catarsis por efectos electrolíticos y osmóticas potentes. Aseo intestinal antes del examen gastrointestinal. Tratamiento de estreñimiento ocasional.
POSOLOGIA: Aseo intestinal: el paciente debe ayunar cuando menos 2 h: Niños: Oral: Nasogástrica: 25 a 40 ml/kg/l hasta que el liquido rectal que se expulsa sea claro (por lo general en 4 a 10 h). Adultos: Oral: Beber 240 ml cada 10 min. hasta consumir 4 L o hasta que el liquido rectal que sea claro. Nasogástrica: 20 a 30 ml/min. (1.2 a 1.8 L/h) hasta administrar 4 L. Estreñimiento ocasional: polvo para solución oral de 255 y 527 g: Adultos: oral: 17 g (alrededor de 1 cucharada sopera colmada) diariamente.
EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, sensación de plenitud, calambres abdominales, vómitos, irritación anal.
PRESENTACIÓN: Barex Bidón conteniendo polvo para preparar 4 l de solución. Barex Unipeg sobres 17 Grs
OBSERVACIONES: La solución reconstituida es hiperosmótica. Cada sobre debe diluirse en 240 ml de líquido (agua, jugos, gaseosas, café o té).Administrar preferentemente por la mañana.
INTERACCIONES: El incremento de la peristalsis puede disminuir la absorción de medicamentos orales administrados en el transcurso de 1 h de iniciar la solución de lavados.
ATC: PRODUCTOS QUE NO POSEEN CODIGO ATC.

POTASIO, GLUCONATO
INDICACIÓN: Hipopotasemia, reposicion oral de potasio. Tratamiento y profilaxis de hipocalemia. El potasio es el principal cation del liquido intracelular y es esencial para la conducción de impulsos nerviosos en corazón, cerebro y músculo esquelético, contracción de músculos cardiacos, esqueléticos y liso y conservación de la función renal normal, equilibrio ácido-base, metabolismo de carbohidratos y secreción gástrica.
POSOLOGIA: Cada 15ml contiene 4,68g de gluconato de potasio, equivalentes a 780mg de potasio elemental (20mEq) 15 ml 2 veces por día. Dosis mayores deben administrarse con agua, después de las comidas. Dosis máxima: 100mEq/día. VO: <1 año: 2-6 mEq/kg/día.>1 año: 1-3 mEq/kg/día
EFECTOS ADVERSOS: Náuseas, vómitos, diarrea.
PRESENTACIÓN: Gluconato de potasio 46,8 g (equivalente a 134 mEq de potasio elemental), elixir 150 ml.
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: VO/enteral: es eficaz y adecuada en pacientes asintomáticos. Evitar su administración en ayuna. Si se administra por sonda, debe lavarse después de su administración con agua. No administrar con leche.

OBSERVACIONES: Precaución en insuficiencia renal y suprarenal. Aumenta rirsgo de hiperkalemia con antiinflamatorios no esteroides, ciclosporina, digoxina,heparina, diuréticos ahorradores de potasio.Controlar y corregir hipomagnesemia.
INTERACCIONES: Diuréticos ahorradores de potasio: amiloride, espironolactona. Riesgo de hiperkalemia potencialmente letal, en particular en caso de insuficiencia renal (adición de efectos hiperkalemiantes).
ATC: A12.Suplementos Minerales. A12B. Potasio

PROMETAZINA
INDICACIÓN: Tto. sintomático de manifestaciones alérgicas: rinitis estacional o perenne. Conjuntivitis alérgica, angioedema, urticaria leve. Náuseas, vómitos graves y prolongados de etiología conocida. Prevención y tto. de mareo cinético.
POSOLOGIA: Inyectable (adultos y adolescentes desde los 15 años): 1 ampolla (2 ml). Se puede repetir 1 vez, en caso de necesidad. Vía I.M. profunda o perfusión I.V.
EFECTOS ADVERSOS: Sedación, somnolencia.
PRESENTACIÓN: Ampolla 2 mL . 25mg/ml
OBSERVACIONES: Niños < 2 años. Niños con deshidratación grave o enf. aguda (varicela, sarampión, infección del SNC, gastroenteritis) por riesgo de distonía. Ictericia.
ATC: R06AD02 Antihistamínicos para uso sistémico.

PROPARACAÍNA CLORHIDRATO
INDICACIÓN: :Anestésico local oftálmico. Actúa como anestésico local de acción rápida y corta duración al bloquear la generación y conducción de los impulsos nerviosos por reducción de la permeabilidad de la membrana neuronal al ión sodio.
POSOLOGIA: Niños y adultos: Cirugia oftálmica: instilar una gota en el ojo cada 5 a 10 minutos por 5 o 7 dosis. Tonometría, gonioscopia, remoción de suturas: instilar una a dos gotas en el ojo justo antes del procedimiento.
EFECTOS ADVERSOS: Picazón, quemazón y enrojecimiento conjuntival pasajeros. Reacción corneal caracterizada por queratitis epitelial aguda, intensa y difusa, de apariencia grisácea amarronada, desprendimiento de grandes áreas de epitelio necrótico, filamentos corneales y en ocasiones iritis y descemetitis
PRESENTACIÓN: Solución oftálmica: 0.5 %.
OBSERVACIONES: Mantener a temperatura entre 2-8 ºC. Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.
ATC: S01HA Anestesicos Locales S01HA30 Combinaciones

PROPANOLOL
INDICACIÓN: Tto. de arritmias cardiacas y crisis tirotóxicas. HTA. Angina de pecho. Profilaxis despues de un IAM.Taquiarritmias.Temblor esencial, sintomatología periférica de la ansiedad y profilaxis de la migraña. Profilaxis de hemorragia gastrointestinal superior en hipertensión portal y varices esofágicas. Bloqueador adrenérgico beta no selectivo; bloquea de manera competitiva la respuesta a estimulación adrenérgica beta 1 y 2 , lo que resulta en una disminución de la frecuencia cardiaca, la contractilidad miocárdica, la presión arterial y la demanda de oxigeno del miocardio.
POSOLOGIA: Neonatos:VO: Inicial: 0.25 mg/kg/dosis cada 6-8 h , aumentar lentamente hasta un máximo de 5 mg/kg/día. EV: Inicial: 0.01 mg/kg , puede repetirse cada 6-8 h, aumentar si es necesario hasta un maximo de 0.15 mg/kg/dosis cada 6-8 h. Niños: VO: Inicial: 1 mg/kg/día cada 6 h, aumentar gradualmente cada 3-5 dias. Mantenimiento: 1-5 mg/kg/día. DOSIS MAX: Arritmias: 16 mg/kg/día o 60 mg/día; hipertensión: 8 mg/kg/día. EV: 0.01- 0.1 mg/kg/dosis. DOSIS MAX: Lactantes: 1 mg. Niños: 3 mg. Adultos: VO: Inicial: 10-20 mg/dosis cada 6-8h
EFECTOS ADVERSOS: dificultad para respirar o tragar,sarpullido,ampollas o descamación de la piel,urticaria, picazón. Inflamación del rostro, garganta, lengua o labios.Sensación de desmayos,aumento de peso,ritmo cardiaco irregular
PRESENTACIÓN: Amp de 5 ml: 1 mg/ml. Comp: 10 mg- 40 mg-80 mg
OBSERVACIONES: Hipersensibilidad a la droga. Insuficiencia cardiaca congestiva no compensada, choque cardiogénico, bradicardia, asma, enfermedad de vías respiratorias hiperactivas, sindrome de Raynaud.

INTERACCIONES: El fenobarbital y la rifampicina puede incrementar la depuración del propanolol y disminuir la actividad. Los antiácidos que contienen aluminio pueden reducir la absorción gastrointestinal de propanolol; la flecainida, la hidralazina, la quinidina, y el verapamilo suelen aumentar los efectos cardiovasculares; la supresión súbita de clonidina en tanto se reciben bloqueadores beta puede resultar en una crisis hipertensiva exagerada
ATC: C07 – Agentes Betabloqueantes. C07A - Betabloqueantes adrenérgicos. C07AA – Agentes betabloqueantes adrenérgicos no cardioselectivos.

PROTAMINA SULFATO
INDICACIÓN: Antídoto heparina. Se combina con heparina muy ácida para formar un complejo (sal) que neutraliza la actividad anticoagulante de ambos fármacos.
POSOLOGIA: 1 ml (10 mg) de protamina neutraliza 1000 UI de heparina USP. Adecuar la dosis de acuerdo al tiempo transcurrido de la administración de heparina
EFECTOS ADVERSOS: Hipotensión, hipertensión pulmonar, bradicardia y otros efectos efectos cardiovasculares. Disnea, náuseas, vómitos, lasitud, reacciones anafilactoideas.
PRESENTACIÓN: Amp: 10 mg/ml.
OBSERVACIONES: Hipersensibilidad a la droga
INTERACCIONES: La administración simultánea de protamina con antibióticos o medios de contraste, puede originar una disminución de la concentración plasmáticas de estas últimas por formación de complejos que pueden precipitar.
ATC: V03AB – Antidotos II: Medicamentos normatizados por el Servicio de Toxicología.

RANITIDINA CLORHIDRATO
INDICACIÓN: Tratamiento de úlcera duodenal activa, úlcera gástrica activa benigna, reflujo gastroesofágico, síndrome de Zollinger-Ellison, úlcera duodenal asociada con H. pylori, hemorragia esofágica y gástrica con hipersecreción. Profilaxis de la hemorragia recurrente en pacientes con úlcera sangrante, hemorragia gastrointestinal debida a úlcera de estrés en enfermos graves y prevención del síndrome de Meldenson.
POSOLOGIA: Prematuros y lactantes a termino < 2 semanas: IV: Dosis de carga: 1,5 mg/kg/dosis. Dosis de mantenimiento: 1,5 mg/kg/día cada 12 h. Niños: IV: 2-4 mg/kg/día cada 6 a 8 h. Adultos EV: 50 mg/6-8 hs, dosis máxima: 300 mg/día.
EFECTOS ADVERSOS: Mareos, insomnio, agitación, rash cutáneo, constipación, náuseas, diarrea, vómitos, cefalea. Bradicardia en infusión rápida. Raros: Aumento de transaminasas, leucopenia, trombocitopenia, broncoespasmo.
PRESENTACIÓN: Ampolla 50mg/5ml.
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución:*** IVD: diluir en SF o DX 5% a una concentración de 2,5mg/ml. Infundir de 5-10min (dosis menores a 10mg). IVI: diluir en SF o DX 5% a una concentración recomendada de 0,5mg/ml. Máxima concentración: 2,5mg/ml. Infundir de 15-30 minutos.
OBSERVACIONES: Dosis elevadas de sucralfato (2 g) o antiácidos como el hidróxido de magnesio, aluminio o calcio administradas con ranitidina disminuyen su absorción por lo que deben administrarse con 2 horas de diferencia. Ajuste de la dosis en pacientes con alteración de la función renal. En caso de insuficiencia hepática deberá administrarse con precaución. Durante embarazo y lactancia debe evaluarse riesgo beneficio.
INTERACCIONES: Los antiácidos disminuyen la absorción de la ranitidina. La ranitidina disminuye la absorción de ketoconazol e itraconazol.
ATC: A02B. Agentes para Ulcera Peptica y Reflujo Gastroesofagico. A02BA. Antagonistas de los Receptores H2

REMIFENTANILO
INDICACIÓN: Morfinosímil. Coadyuvante de la anestesia general. Rápido comienzo de acción y metabolización rápida.
POSOLOGIA: 0,5 µg/kg en bolo en 30"" Mantenimiento: 0,1 - 0,3 µg/kg/min
EFECTOS ADVERSOS:Apnea, náuseas, bradiarritmia, hipotensión, depresión respiratoria. Mayor frecuencia de tórax leñoso.

PRESENTACIÓN: Ampollas: 5 mg
OBSERVACIONES: USO EXCLUSIVO DEL ESPECIALISTA. No administrar por vía epidural o intratecal (la glicina de la formulación puede causar neurotoxicidad).
INTERACCIONES: Aumenta efectos adversos de: anestésicos vía inhalatoria o IV, benzodiazepinas, depresores del SNC; reducir dosis de estos medicamentos. Hipotensión y bradicardia exacerbados con: ß-bloqueantes y bloqueantes de los canales del Ca.
ATC: N01AH06.Anestésicos generales.

RESINA DE COLOFONIA/ ESENCIA DE TREMENTINA ADHESOL
ACCION TERAPEUTICA: Adhesivo antiséptico
INDICACIÓN: Proteccion de heridas
PRESENTACIÓN: Frasco 30 ml
ATC: V03AK – Adhesivos tisulares

RIFAMPICINA
ACCION TERAPEUTICA: Bactericida. Inhibe la síntesis bacteriana del ARN, bloqueando la trascripción de ácido ribonucleico.
INDICACIÓN: Activa frente a bacterias grampositivas (*Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis*), y frente a algunas bacterias gramnegativas, incluyendo *Brucella sp., Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis y Legionella pneumophila.* Es un fármaco de primera línea en el tratamiento de la tuberculosis, siendo necesario su uso en combinación para evitar la aparición de resistencias. Indicacion en profilaxis a los contactos de pacientes con enfermedad invasiva por Meningococo y *Haemophilus influenzae B.*
POSOLOGIA: Misma dosis VO e IV: La dosis habitual es de 15 mg/kg/día. **Tuberculosis:** Lactantes y niños: 10 a 20 mg/kg/día cada 24 h. Adultos: 10 mg/kg/día administrados una vez al día.DOSIS MAX: 600 mg/día. **Profilaxis de *H. influenzae tipo B*** : Neonatos < 1 mes: 10 mg/kg/día cada 24 h por 4 dias. Lactantes y niños: 20 mg/kg/día cada 24 h por 4 días sin sobrepasar 600 mg/dosis. Adultos: 600 mg cada 24 h por 4 días. **Prevención meningocócica**: <1 mes: 10 mg/kg/día cada 12 h durante 2 días. Lactantes y niños: 20 mg/kg/día cada 12 h durante 2 días sin sobrepasar 600 mg/dosis. Adultos: 600 mg cada 12 h durante 2 días.
EFECTOS ADVERSOS: Disturbios gastrointestinales, ictericia, hepatitis, reacciones febriles tipo influenza, reacciones dermatológicas, neurotoxicidad. Hematológicos: neutropenia, leucopenia, trombocitopenia (poco frecuente).
PRESENTACIÓN: Caps: 300 mg. Inyectable para reconstituir: 600 mg. Jarabe: 2%
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: reconstituir el FA de 600mg en 10ml de AD, obteniéndose una concentración: 60mg/ml. Es estable 24hs a T° ambiente. Concentración de la dilución: administrar por vía IVI: diluir con SF o DX5% a una concentración recomendada: menos de 6mg/ml. Máxima concentración: 6mg/ml. Infundir de 30 minutos a 6 horas. VO: preferentemente en ayunas, si hay intolerancia gastrointestinal administrar 20 minutos antes de los alimentos.
OBSERVACIONES: Alergia o hipersensibilidad a la droga. Insuficiencia hepática. Puede conferir un color anaranjado a las secreciones corporales. El diluido precipita luego de las 4hs.
INTERACCIONES: Induce a la formación de enzimas hepáticas, lo cual reduce la concentración plasmática de los siguientes fármacos: verapamil, diltiazem, nifedipina, metadona, digoxina, ciclosporina, tacrolimo, benzodiazepinas, corticoides, anticoagulantes orales, inhibidores de proteasas, inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósidos y quinidina; halotano o isoniacida.
ATC: J – Terapia Antiinfecciosa Sistemica . J01- Antibacterianos de uso sistemica. J01XX - Otros antibacterianos

RIFAMICINA
INDICACIÓN: Antibiótico. Tratamiento o prevención de la infección por gérmenes susceptibles a la rifamicina SV.
POSOLOGIA: Se emplea localmente para lavado o para instilar en cavidades, previa aspiración del contenido purulento y eventual lavado con solución fisiológica; además puede utilizarse para embeber gasas y para infiltraciones en zonas infectadas.
EFECTSO ADVERSOS: reacciones dermatológicas

PRESENTACIÓN: Spray- Solución.
OBSERVACIONES: Reacciones adversas Manifestaciones alérgicas cutáneas, ardor, picazón, eritema, que remiten con la interrupción del medicamento y con tratamiento sintomático
ATC: S01A- Antiinfecciosos. S01AA16- Antibioticos

RISPERIDONA
INDICACIÓN: Terapéutica Antipsicótico, antiagresivo.
POSOLOGIA: 3 - 5 años: 0,1 - 0,5 mg/día; 6 - 10 años: 0,25 - 2 mg/día; > 11 años: 0,25 - 4 mg/día, cada 12 hs. Adultos: 2 - 6 mg/día, cada 12 hs.
EFECTSO ADVERSOS: Sedación, cefalea, discrasias sanguíneas (trombocitopenia), sequedad de la boca, constipación, visión borrosa, retención urinaria, palpitaciones, nerviosismo, ginecomastia. En los niños son menos comunes los efectos extrapiramidales.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: 0,5 - 1 - 2 mg; Solución oral: 1 mg/ml
OBSERVACIONES:Uso bajo estricta indicación y supervisión psiquiátrica. La solución oral se puede mezclar con agua o jugo de naranja si es usada dentro de las 4 hs
ATC: N05AX PSICOFÁRMACOS TRANQUILIZANTES MAYORES

ROCURONIO
INDICACIÓN: Inducción rápida para politraumatizados sin ayuno previo.
POSOLOGIA: 0,45 - 0,6 mg/kg/dosis
EFECTSO ADVERSOS: Apnea, Vagólisis, hipotensión transitoria,, hipertensión, taquicardia relacionada dosis-apnea, arritmias, edema en el lugar de inyección, hipo, prurito, náusea, sibilancias, debilidad muscular residual.
PRESENTACIÓN: Ampollas de 5 ml: 10 mg/ml
OBSERVACIONES: USO EXCLUSIVO DEL ESPECIALISTA. Puede administrarse sin diluir. Para infusión continua diluir con solución fisilógica o dextrosa 5% con una concentración de 0,5 a 1 mg/ml, no mezclar con soluciones alcalinas.
ATC: M03AC09.Agentes relajantes musculares de acción periférica.

SACCHAROMYCES BOULARDII
INDICACIÓN: Reemplaza la flora patógena del intestino por otra similar a la fisiológica. En ads. y niños para el tto. sintomático de las diarreas agudas inespecíficas y en la prevención y tto. sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos
POSOLOGIA: Oral. Ads. y adolescentes > 12 años: 250-500 mg/día en 2 tomas (mañana y noche). Niños > 2 años: 250 mg/día.
EFECTSO ADVERSOS: Ocasionalmente se pueden presentar olor ácido en las heces, lo cual carece de importancia
PRESENTACIÓN: Cada sobre contiene: Saccharomyces Boulardiil 250.00 mg, excipientes (Lactosa, Levulosa, Ácido Silícico, Aroma Tutti-frutti) c.s.
OBSERVACIONES: No administrar con: antifúngicos orales o sistémicos, bebidas o alimentos muy calientes (> 50ºC), helados o que contengan alcohol.
ATC: A07FA02 Tracto Alimentario y Metabolismo, Antidiarreicos, Antiinfecciosos y Antiinflamatorios Intestinales Microorganismos Antidiarreicos

SALBUTAMOL
INDICACIÓN: Broncoespasmo. Asma. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Bronquitis. Profilaxis broncoespasmo inducido por ejercicio. Agonista selectivo β2- adrenérgico. En dosis terapéuticas actúa en el nivel de los receptores β2- adrenérgicos de la musculatura bronquial y uterina, con escasa o ninguna acción en los receptores β1- adrenérgicos de la musculatura cardíaca
POSOLOGIA: Aerosol: (100 mcg = 1 disparo) 100 a 200 mcg cada 4-6 hs. – Dosis máxima (Dmax): 12 disparos/día – Solución p/nebulizar: ADULTO (1 ml = 5 mg) de 0,5-2 ml c/6 hs. NIÑOS: Dmax. 1 ml p/día.
EFECTOS ADVERSOS: Temblor, nerviosismo, taquicardia, náuseas, vómitos, hipokalemia.
PRESENTACIÓN: Gotas 0,5 % x 20 mL. Aerosol : 0.1 mg/dosis

OBSERVACIONES: Puede producir cefalea, taquicardia, temblor, nerviosismo. Niños y ancianos son más susceptibles a manifestar lo mencionado. Algunos fármacos (xantinas, corticoides y diuréticos) pueden acentuar la hipopotasemia produciendo arritmia. Su efecto es antagonizado por los beta-bloqueantes. Administrar bajo monitoreo médico en pacientes con enfermedad cardiovascular, hipotiroidismo y diabetes. Dosis elevadas pueden producir hipopotasemia.
INTERACCIONES: Los beta-bloqueantes pueden inhibir parcial o totalmente su efecto.
ATC: R03CC. Agonistas selectivos de receptores BETA-2 Adrenergico

SEVOFLURANO-SEVORANE
INDICACIÓN: Para inducción y mantenimiento de la anestesia general.
POSOLOGIA: Según la técnica anestésica empleada.
EFECTOS ADVERSOS: Puede desencadenar hipertermia maligna.
PRESENTACIÓN: Fco. sistema de carga Quick Fill de 250 ml
OBSERVACIONES:Usar con precaución en pacientes hipovolémicos.
INTERACCIONES: a- y b-simpaticomiméticos como adrenalina o noradrenalina, deberían ser administrados con precaución durante la narcosis con Sevoflurano debido al riesgo potencial de arritmia ventricular. Inhibidores no selectivos de la MAO: Riesgo de crisis durante la cirugía. Se recomienda generalmente que el tratamiento con estos agentes sea suspendido 2 semanas antes del acto quirúrgico.
ATC: N01AB08 Anestésicos generales. Hidrocarburos halogenados 2

SODIO, FOSFATO (MONO Y DISÓDICO)
INDICACIÓN: Tratamiento de la constipación ocasional. Preparación del colon para la realización de procedimientos diagnóstico o quirúrgicos.
POSOLOGIA: Laxante: 20 ml. Estudio: 45 ml diluidos en 1 vaso de agua fría ingeridos el día previo al examen, seguido de por lo menos 3 vasos de agua fría hasta la hora de acostarse. La mañana del estudio ingerir otros 45 ml diluido en 1 vaso de agua fría. Se recomienda que la administración se haya completado 3 horas antes del estudio.
EFECTOS ADVERSOS: Dolor de estómago,náusea,hinchazón
PRESENTACIÓN: Fosfato monosódico 21,6 g, fosfato disódico 8,1 g, solución oral, frasco 45 ml.
OBSERVACIONES: Contraindicado en insuficiencia renal grave o moderada. Precaución en insuficiencia renal leve. Contraindicado en niños menores de 2 años de edad. No debe ser administrado en pacientes con náuseas, vómitos, dolor abdominal u obstrucción intestinal. Usar con precaución en pacientes ancianos.
ATC: A06AD. Laxantes Osmoticos

SUCCINILCOLINA
INDICACIÓN: Sustancia química usada en anestesiología como bloqueador neuromuscular (miorrelajante). La succinilcolina es empleada en cirugía y procedimientos donde sea necesaria relajación muscular. Se utiliza como relajante muscular para la intubación endotraqueal o para intervenciones quirúrgicas leves y en el tratamiento de las convulsiones inducidas farmacológica o eléctricamente, para reducir la intensidad de las contracciones musculares.
POSOLOGIA: La dosis usual en niños por vía intramuscular es de hasta 2,5mg/kg sin sobrepasar una dosis total de 150mg; por vía intravenosa 1 a 2mg/kg. Se pueden administrar dosis repetidas si es necesario.
EFECTOS ADVERSOS: Contracción de los músculos, dolor muscular derecha después de la cirugía, y la producción de más saliva. Dolor de pecho, respiración rápida, elevada temperatura corporal, rigidez de la mandíbula
PRESENTACIÓN: Via/Ampollas 100 y 500mg.
OBSERVACIONES: Los pacientes pediátricos son especialmente sensibles a la aparición de mioglobinemia y mioglobinuria, y a los efectos cardíacos de bradicardia transitoria, hipotensión, arritmias o paro del nódulo sinusal. Puede producir aumento de las concentraciones séricas de potasio con mayor riesgo de detención cardíaca o arritmias en pacientes con traumas severos, quemaduras o trastornos neurológicos.
ATC: M - Sistema Musculo Esqueletico. M03 – Miorrelajantes

SUCRALFATO
INDICACIÓN: Úlcera gástrica o duodenal evolutiva. Prevención de úlcera duodenal reincidente. Forma selectivamente una cubierta protectora que se adhiere a la mucosa lesionada para protegerla del acido péptido, la pepsina y las sales biliares.
POSOLOGIA: 1 g (5 ml) 4 veces por día. (1 hora antes de las 3 principales comidas y antes de acostarse 2 hs después de la cena). Dosis máxima: 4 g/día. Niños: 40 a 80 mg/kg/día en fracciones cada 6 h. Estomatitis: 5 a 10 ml; hacer buches 4 veces al día
EFECTOS ADVERSOS: Constipación, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, sequedad de boca, cefalea, dolor de espalda.
PRESENTACIÓN: Sucralfato 0,2%, suspensión 200 ml.
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: VO: Administrar 20 minutos antes de las comidas para proteger la mucosa gástrica
OBSERVACIONES: Administrar al paciente con el estomago vacío 1 h antes de las comidas y a la hora de acostarse. Separar 30 min la administración de: antiácidos y ranitidina.
INTERACCIONES: Reduce la absorción de los siguientes fármacos: colistina, cimetidina, digoxina, gentamicina, levotiroxina, fenitoína, quinidina, quinolonas, ranitidina, sales de fosfato de sodio y potasio. Cuando se administrar en forma concomitante con antiácidos, cimetidina, ranitidina, disminuyen la actividad del sucralfato
ATC: A02BX. Otras Drogas para Úlcera Peptica y Reflujo Gastroesofagico

TRIMETOPRIMA+SULFAMETOXAZOL
ACCION TERAPEUTICA: Compuesto constituido por una combinación de dos antibióticos con efecto sinérgico bactericida (en relación 5:1). El sulfametoxazol (SMTX), una sulfonamida que inhibe la síntesis bacteriana de ácido dihidrofólico y trimetroprim (TMP), inhibidor de la dihidrofolato reductasa.
INDICACIÓN: Presenta un espectro antimicrobiano amplio, especialmente frente gérmenes gramnegativos aeróbicos (enterobacterias) y grampositivos (cocos) incluyendo *S. aureus meticilin-resistente*, *Corinebacterium y Listeria*. Profilaxis y tratamiento en neumonia por *Pneumocystis jiroveci* (Antes conocido como *Pneumocystis carinii)*
POSOLOGIA: En base al componente de Trimetroprima: Niños mayores de 6 semanas: 8-12 mg/kg/día de trimetoprima cada 12 hs, dosis máxima de trimetoprima: 320 mg/día. Pneumocystis carinii: 15-20 mg/kg/día cada 6 hs. Profilaxis: 5 mg/kg/día 3 veces por semana. Profilaxis infecciones urinarias: 2 mg/kg/día en una dosis diaria. Fibrosis quística: 10-12 mg/kg/día de trimetoprima cada 12 hs, dosis máxima 640 mg de trimetoprima. Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos.
EFECTOS ADVERSOS: Reacciones de hipersensibilidad (sobre todo dermatológicas), disturbios gastrointestinales (náuseas, vómitos), discrasias sanguíneas. Toxicidad renal (en pacientes con fallo renal previo). Hepatitis, colestasis.
PRESENTACIÓN: Solución inyectable: sulfametozaxol 400 mg/trimetoprima 80 mg/ 5 ml. Suspensión oral: sulfametoxazol 200 mg/trimetoprima 40 mg/5 ml. Comp: sulfametoxazol 400 mg/trimetoprima 80 mg; sulfametoxazol 800 mg/ trimetoprima 160 mg.
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: ampolla de 5ml contiene 80mg de TMP (concentración de 16mg/ml) más 400mg SMX (concentración de 80mg/ml). Usar y no conservar el resto de la ampolla. ***Concentración de la dilución***: administrar por vía IVI: diluir con DX 5% a una concentración recomendada: 0,6 mg/ml. Máxima concentración: 1mg/ml. Infundir de 30 a 60 minutos. En pacientes con restricción hídrica concentrar: 1,6mg/ml. VO: jarabe: en 5 ml contiene 40mg de trimetoprima + 200mg de sulfametoxazol. Administrar con alimentos ***Datos consignados en base a la trimetoprima***
OBSERVACIONES: Posee efectos neutropénicos. No se debe administrar en embarazadas, en período de lactancia ni en lactantes. La relación riesgo-beneficio se evaluará en pacientes con disfunción hepática o renal.
INTERACCIONES: Disminuye la depuración de warfarina; el metotrexato es desplazado de los sitios de unión a proteínas; aumenta el efecto de silfonilureas, fenitoína, digoxina y tiopental, disminuye las concentraciones de ciclosporina en suero
ATC: J01E. Sulfamidas

SULFATO MAGNESIO

INDICACIÓN: Tratamiento de la hipomagnesemia y tratamiento de las crisis convulsivas de la preclamsia-eclampsia. Tratamiento del déficit de magnesio. Hipocalcemia
POSOLOGIA: Dosis expresada como magnesio elemental. Requerimiento diario: 0-6 meses:50 mg. 6 meses-1 año: 70 mg. 1-3 años: 150 mg. 4-6 años: 200 mg. >6 años:250 mg. Hipomagnesemia sintomática: EV/IM: 0.8-1.6 mg/Kg./dosis cada 4-6 h. DOSIS MAX: 16 mg/dosis. Hipomagnesemia asintomático: EV: 0.2-0.5 mEq/Kg./día. DOSIS MAX: 8-16 mg/día. VO: 0.81.6 mEq /Kg./dosis cada 6 h. Déficit en la absorción intestinal: VO: 20-60 mEq/día. Adultos: 60100 mEq/día
EFCTOS ADVERSOS: Hiporreflexia, parálisis fláccida, hipotensión, bloqueo cardíaco, depresión S.N.C.
PRESENTACIÓN: Ampolla al 25% (26,4 mg (2 mEq) de Mg/mL) 10 ml; al 25 % (49,3 mg (4 mEq) de Mg/mL) 10 ml. **Solucion Magistral** 4 mEq/ ml (1 mEq Mg = 12 mg de Mg) (1 g Sulfato de Magnesio = 8,12 mEq de Mg = 98 mg de Mg)
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: ***Concentración de la dilución:*** IVD: (Arritmias) a una concentración de 200mg/ml. Infundir en de 10-20 minutos. IVI: diluir en SF o DX 5% a una concentración recomendada de 10mg/ml. Máxima concentración: 30mg/ml. Infundir de 30-60 minutos. En crisis asmáticas: Dosis entre 250-500 mg llevar a 20 ml; Dosis entre 501-750 mg llevar a 30 ml; Dosis entre 751-1500 mg llevar a 50 ml. Infundir de 15-30 minutos
OBSERVACIONES: En caso de intoxicación se debe contar con una solución de calcio.
INTERACCIONES: Por vía oral, disminuye la absorción de antagonistas H2, Fenitoína, Sales de hierro, Ciprofloxacina, Benzodiazepinas, Cloroquina. El magnesio sistémico puede incrementar los efectos de los bloqueadores del canal del calcio y neuromusculares. Suele compartir efectos depresores aditivos del SNC con depresores de este último; si ocurre alcalinización suficiente de la orina por sales de magnesio, se incrementa la excreción de salicilatos y aumenta la resorción tubular de Quinidina.
ATC: B05X. Aditivos para Soluciones IV

TEICOPLANINA
ACCION TERAPUTICA: Antibiótico glucopéptido. Bactericida. Inhibe la síntesis de proteínas de la pared celular
INDICACIÓN: Infecciones por coco GRAM positivos. SAMR. **Opcion teraputica restringida. Con indicacion de Infectologia .**
POSOLOGIA: En mayores de 2 meses infecciones leves, las primeras 3 dosis E.V./I.M.: 10 mg/kg/dosis cada 12 hs, luego: 10 mg/kg/día cada 24 hs; dosis máxima: 400 mg/día. En infecciones graves y neutropénicos, la dosis recomendada es de 10 mg/kg cada 12 horas, las 3 primeras dosis (0,12 y 24 h); a continuación, se administrará una sola dosis de 10 mg/kg/día, por vía IV. o IM (dosis máxima: 400 mg/día). En pacientes neutropénicos con trasplante de médula ósea se recomiendan dosis de 15-20 mg/kg/día (mantener unas concentraciones valle >10 mg/l).
EFECTOS ADVERSOS: Dolor en ditio de inyección , fiebre, náuseas, vómitos, reacción anafiláctica. Raro: trombocitopenia.
PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 200-400 mg.
OBSERVACIONES:Su vida media prolongada, permite el uso cada 24 hs. Reacciones adversas: Rash. Fiebre. Flebitis. Anafilaxia. Eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia. Dolor en el sitio de inyección.
ATC: J01X Otros antibacterianos. J01XA Glicopéptidos antibacterianos.

TERLIPRESINA
INDICACIÓN:La terlipresina es un análogo sintético de la vasopresina. Las indicaciones aprobadas en el mundo son para el tratamiento de emergencia de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas (HDAV) y síndrome hepatorrenal (SHR) tipo 1. Después de la administración intravenosa, terlipresina es transformado por la acción de enzimas en el agente de lisina-vasopresina activa. El metabolismo de la terlipresina resulta en una liberación gradual de la vasopresina, que a su vez determina la disminución del diámetro (vasoconstricción) en vasos sanguíneos que irrigan los órganos abdominales (esplácnicos), causando una mayor resistencia al flujo sanguíneo intestinal y de reducción de presión en la vena porta (vena de drenaje sangre del sistema digestivo) 345 La terlipresina disminuye la hipertensión portal e induce vasoconstricción en el territorio esplácnico, lo que lleva a la contracción de los músculos del esófago y la compresión de las varices esofágicas.

POSOLOGIA: Según el peso del paciente se usan por vía intravenosa durante un minuto: < 50kg: 1 mg. 50-70kg: 1,5mg. > 70kg: 2mg. Se deberá monitorear la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Como dosis de mantenimiento 1-2mg IV cada 4 horas hasta el control de la hemorragia por un período de 24 a 36 horas
EFECTOS ADVERSOS: Dolor de cabeza,Bradicardia (ritmo cardiaco muy lento). Aumento de la presión sanguínea (hipertensión). Constricción periférica de los vasos sanguíneos (flujo de la sangre inadecuado a los tejidos (isquemia)) resultando en palidez.Dolor de estómago transitorio. Diarrea transitoria.
PRESENTACIÓN: Caja con 1 frasco ámpula con 1 mg y 1 ampolleta de 5 ml con diluyente.
OBSERVACIONES: La terlipresina aumenta el efecto hipotensor de los betabloqueantes no selectivos en la vena porta. El tratamiento concomitante con terlipresina y medicamentos para bradicardia (p. Ej. Propofol, sufentanilo) puede disminuir la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco
ATC: H01 Hormonas hipofisarias e hipotalámicas y sus análogos. H01BA Vasopresina y análogos

TOBRAMICINA
INDICACIÓN: Antibiótico aminoglucósido bactericida, potente, de amplio espectro y rapidez de acción. Actúa principalmente sobre las células bacterianas por inhibición de la síntesis y unión de los polipéptidos en el ribosoma. Infecciones bacterianas superficiales del ojo (conjuntivitis).
POSOLOGIA: Cada 2-3 hs
EFECTOS ADVERSOS: Lagrimeo, visión borrosa temporal, picazón.
PRESENTACIÓN: Gotas: 0,3 % Pomada oftálmica: 0,3 %
OBSERVACIONES: No intercambiar por otro antibiótico. Reaccion Adversa Picor, rritación e inflamación del párpado, eritema conjuntival.
INTERACCIONES: Aumento de la toxicidad: uso concomitante de anfotericina B, cefalosporinas, penicilinas, diuréticos de asa, urea, manitol, vancomicina, cisplatino, indometacina; potencia el efecto de los agentes bloqueadores neuromusculares y de la toxina botulínica.
ATC: S – Organos de los sentidos. S01 – Preparados Oftalmologicos.

TIOPENTAL
INDICACIÓN: Inductor anestésico. Mantenimiento de sedación y/o anestesia de pacientes con hipertensión endocraneana o status convulsivo.
POSOLOGIA: Status epilépticus y tratamiento de hipertensión endocraneana Ataque: 3-5 mg/kg/dosis Mantenimiento: 1-6 mg/kg/hora Intubación endotraqueal: 3-5 mg/kg Pacientes en A.R.M.: 2-6 mg/kg Infusión continua: 1-2 mg/kg/hora.
EFECTOS ADVERSOS: Apnea, hipoventilación , tos, hipo y broncoespasmo. Depresión miocárdica directa y vasodilatación periférica. Alteración de la función hepática. La extravasación produce dolor intenso y necrosis. La inyección intraarterial produce vasoespasmo.
PRESENTACIÓN: F.A.: 1 g
ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: Reconstituir el FA de 1g en 20ml de SF, obteniéndose una concentración de 50mg/ml. Es estable 24hs a T° ambiente. ***Concentración de la dilución:*** IVD: diluir en SF o Dx5% a una concentración de 20-50mg/ml. IVI: diluir en SF o DX 5% a una concentración recomendada: 20mg/ml. Máxima concentración: 25mg/ml. IVC: diluir el vial a una concentración 2-4mg/ml. Es estable 24hs a T° ambiente.
OBSERVACIONES: Contraindicado en porfiria aguda intermitente. Precaución en pacientes con inestabilidad cardiovascular y tendencia al broncoespasmo. Infusión intermitente: 2-5 %; infusión continua: 0,2-0,4 % en solución fisiológica o Dx 5%. Contenido de sodio: 4,9 mEq/g de tiopental. Estabilidad de la solución diluida: 24 hs a temperatura ambiente.
INTERACCIONES: Inhibe efecto de: acebutolol, aminofilina, calcitriol, metoprolol, minociclina, oxprenolol, propranolol y teofilina. Efecto potenciado por: alcohol etílico, reserpina, sulfafurazol y probenecid.
ATC: N01AF03 ANESTÉSICOS GENERALES

TOBRAMICINA + DEXAMETASONA

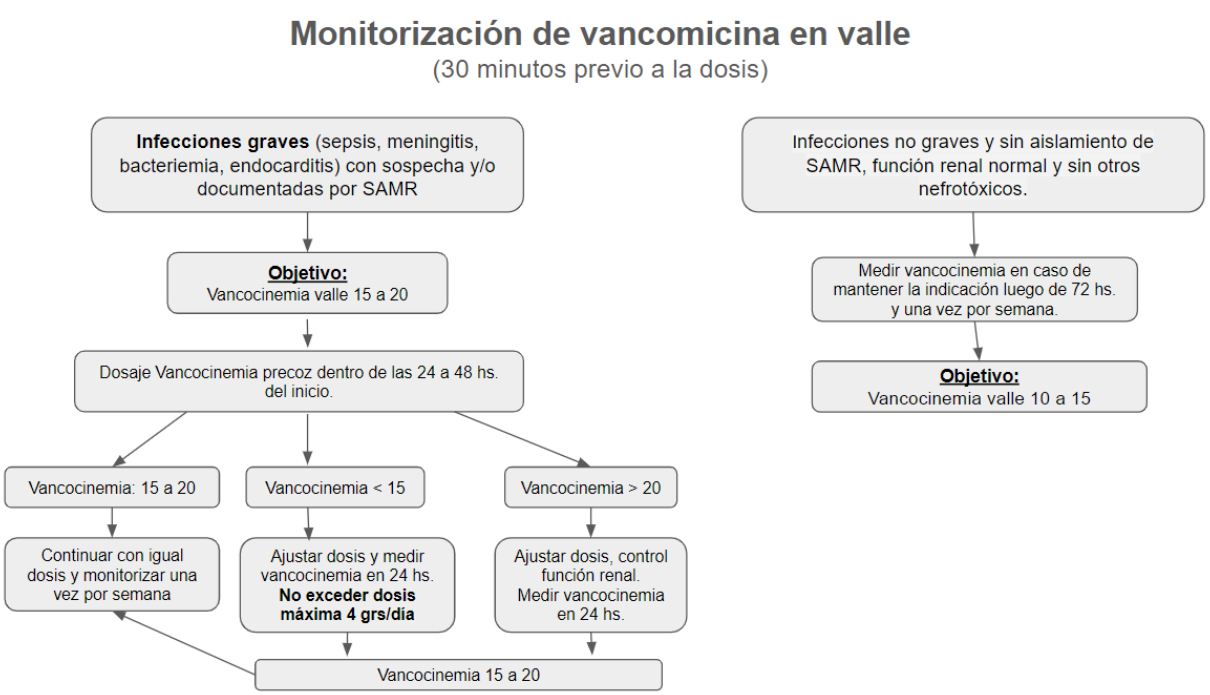
INDICACIÓN: Tratamiento de los procesos infecciosos que cursan con inflamación de la conjuntiva palpebral, bulbar, córnea, segmento anterior del ojo, en uveitis crónica anterior, daño corneal y como profiláctico en la inflamación / infección posquirúrgica. El principal uso de la terapia combinada es en condiciones inflamatorias en las cuales existe un alto riesgo de infección secundaria (trauma ocular [incluyendo cirugía] penetración de cuerpo extraño o sustancia extraña, o quemadura química por radiación o térmica).
POSOLOGIA: En infecciones leves: 1 o 2 gotas en el ojo afectado cada cuatro horas. En infecciones severas: 1 o 2 gotas cada dos horas. La frecuencia deberá disminuirse gradualmente conforme se logre la mejoría. Se deberá cuidar de no suspender el tratamiento prematuramente.
EFECTOS ADVERSOS: Reacciones de hipersensibilidad, picazón e inflamación de párpados, eritema conjuntival.
PRESENTACIÓN: Gota y ungüento oftálmico: tobramicina 0,3% + dexametasona 0,1%
OBSERVACIONES:Los corticoides han resultado teratogénicos en estudios en animales. No existen estudios bien controlados y adecuados en mujeres embarazadas. Puede ser utilizado solo si el beneficio justifica el riesgo potencial al feto. Se desconoce si la droga es excretada en la leche materna.
ATC: S – Organos de los sentidos. S01 – Preparados Oftalmologicos.

TRAMADOL
INDICACIÓN: Analgésico.
POSOLOGIA: 1-2 mg/kg/dosis cada 8 hs, dosis máxima: 3 - 6 mg/kg/día. Adultos: 50-100 mg cada 4-6 hs, dosis máxima: 400 mg/día. Al pasar a cápsulas de liberación controlada dar cada 12 hs. Ajustar la dosis en insuficiencia hepática
EFECTOS ADVERSOS: Mareos, cefaleas, confusión, somnolencia, náuseas, vómitos, estreñimiento, sequedad bucal, sudoración, fatiga.
PRESENTACIÓN: Calmador(R) gotas: 1 ml=20, gotas=50 mg, Nobligán(R) gotas: 1 ml=40 gotas=100 mg,
OBSERVACIONES: Droga en evaluación en pediatría, utilizar en niños mayores y adolescentes.
INTERACCIONES: Interacciona con carbamacepina y antidepresivos tricíclicos
ATC: N02AX ANALGÉSICOS - ANTIPIRÉTICOS - ANTIINFLAMATORIOS- ANALGÉSICOS OPIÁCEOS

TROPICAMIDA + FENILEFRINA
INDICACIÓN: Midriático pupilar.
POSOLOGIA: 1 gota cada 10 minutos 1 hora antes del examen o procedimiento quirúrgico.
EFECTOS ADVERSOS: Aumento de la presión intraocular, picazón transitoria, sequedad de la boca, visión borrosa, fotofobia, taquicardia, cefalea, estimulación parasimpática, temblor, palidez, reacción alérgica.
PRESENTACIÓN: Gotas: tropicamida 0,5 % + fenilefrina 5 %
OBSERVACIONES: Utilizar con cuidado en pacientes con glaucoma y en lactantes pequeños.
ATC: S01 Oftalmologia. Midiatricos y Ciclopleg icos

VANCOMICINA
ACCION TERAPEUTICA: Antibiotico glucopeptido que inhibe la sintesis de la pared celular.
INDICACIÓN: Tratamiento de infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos beta-lactámicos. Vancomicina es el antibiótico de elección en el tratamiento de las infecciones graves por *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (SARM), **Staphylococcus coagulasa negativos**, incluido *Staphylococcus epidermidis y Enterococcus sp*. resistentes a penicilinas. Profilaxis quirúrgica o implantación protésica con riesgo de infección por *Staphylococcus meticilín-resistente*. Ver guias de profilaxis quirurgica https://sites.google.com/view/sitio-de-ceci-him/inicio . **Ver tabla de ajuste en IR.**

POSOLOGIA: Lactantes de 1 a 3 meses de edad: 40 mg/kg/día, cada 8 h. Niños de 3 meses a 12 años: 60 mg/k/dia cada 6 hs. Niños mayores de 12 años: 40 mg/k/dia cada 8 hs. **Dosis maxima** : En infecciones graves (sepsis , meningitis , bacteriemia, endocarditis), documentadas por SAMR y en FQ hasta 4 gs/dia; en los demas casos y sin aislamineto de SAMR entre 2 y 3 gr/dia . **Monitorizacion de vancocinemia guiada por valle** (tomar dosaje de vancomicina y funcion renal actualizada 30 minutos previos a la dosis) **Indicaciones**: Monitorizacion precoz dentro de las 24/48 hs del inicio en pacientes con infecciones graves (sepsis, meningitis, bacteriemia, endocarditis) con sospecha o documentadas por SAMR. Objetivo : Vancocinemia 15 a 20 mcg/ml. En caso de ajustar la dosis , nuevo dosaje antes de la cuarta dosis siguiente. En caso de nivel adecuado en pacientes criticos y con persistencia de la indicacion control semanal de vancocinemia y funcion renal. En otras infecciones no graves y sin aislamiento de SAMR, en paciente con funcion renal normal y sin otros nefrotoxicos asociados, solo dosar en caso de mantener la indicacion por mas de 3 dias . Objetivo. Vancocinemia entre 10 y 15 mcg/ml . Sin exceder dosis maxima de 2 a 3 gr/dia. *Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.*



EFECTOS ADVERSOS: Síndrome de cuello rojo con hipotensión. Asociado a la velocidad de inyección: flebitis, reacciones febriles, rash, eosinofilia, neutropenia, ototoxicidad, nefrotoxicidad.

PRESENTACIÓN: Frasco Ampolla 500 Mgrs

ADMINISTRACION Y ESTABILIDAD: IV: reconstituir el FA de 500mg en 10ml de AD, obteniéndose una concentración de 50mg/ml. Es estables 4 días refrigerados.
Concentración de la dilución: administrar por vía IV: diluir con SF o DX 5% a una concentración recomendada: 2,5mg/ml. Máxima concentración: 5mg/ml. Infundir en 60 minutos. Mejor actividad antimicrobiana si se administra por 3hs.

OBSERVACIONES: Ajustar dosis en caso de insuficiencia renal. Contraindicado en embarazo y lactancia. Si el paciente presenta síndrome del cuello rojo, administrar en 2 horas a, 2,5mg/ml.

INTERACCIONES: Agentes anestésicos, agentes ototóxicos o nefrotóxicos concomitantes que incluyen diuréticos del asa, cisplatino, amfotericina B, bacitracina, polimixina-B, colistina

ATC: J01X. Otros Antibacterianos

VASOPRESINA

INDICACIÓN: Para hipotensión refractaria a catecolaminas con hipoplejía.

POSOLOGIA: 0,01 - 0,15 U/kg/hora

EFECTO ADVERSO : Hipertensión, bradicardia, arritmias, trombosis venosa, fiebre, vértigo, temblor, diaforesis.

PRESENTACIÓN: F.A.: 20 U/ml (0,4 mg/ml)

ADMINISTRACION Y ESTABLIDAD: EV: Es estable refrigerada.
Concentración de la dilución: diluir con SF o Dx 5% a una concentración recomendada de 0,1 UI/ml. Máxima concentración: 1UI/ml. Infundir de 0,03UI/min a 0,1UI/min (shock postcardiotomía); Infundir 0,01UI/min a 0,07 UI/min (shock séptico).

OBSERVACIONES: La vasopresina está contraindicada en personas alérgicas a la hormona
Este fármaco no debe ser utilizado en pacientes con enfermedades vasculares especialmente en el caso de enfermedades coronarias. Debido a sus efectos constrictores, dosis pequeñas de vasopresina pueden ocasionar dolor anginoso y dosis más altas pueden desencadenar un infarto de miocardio.
La vasopresina puede producir una intoxicación por agua, que se manifiesta por mareos, apatía y cefaleas que pueden degenerar en convulsiones y coma terminal.

ATC: H01A Hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis y sus análogos. H01B Hormonas del lóbulo posterior de la hipófisis. H01BA Vasopresina y análogos.

VECURONIO

INDICACIÓN: Indicado para pacientes con inestabilidad hemodinámica que reciben soporte inotrópico. Bloqueante neuromuscular de acción intermedia.

POSOLOGIA: 0,1 mg/kg en bolo, mantenimiento: 0,05 mg/kg a demanda. Reducir la dosis en insuficiencia hepática.

EFECTO ADVERSO: Apneas. Similar al pancuronio

PRESENTACIÓN: F.A.: 4 - 10 mg

OBSERVACIONES: USO EXCLUSIVO DEL ESPECIALISTA. Debe utilizarse con precaución en enfermedades neuromusculares, miopáticas y en presencia de colestasis. Contraindicado en I.R (se prolonga el bloqueo). El bloqueo neuromuscular se prolonga con: aminoglucósidos, clindamicina, sulfato de magnesio, colistina, anestésicos inhalatorios, drogas que deplecionan potasio; disminuye con azatioprina y teofilina. Infusión continua: diluir a una concentración máxima de 1 mg/ml.

ATC: M03AC03 Agentes relajantes musculares de acción periférica.

VITAMINA A

INDICACIÓN: Indicado para el cuidado de irritaciones, heridas y quemaduras en general

POSOLOGIA: Aplicar abundantemente una o dos veces por día sobre la zona a tratar o proteger; realizar un suabe masaje para favorecer su penetración.

EFECTO ADVERSO: posibilidad de eczema de contacto

PRESENTACIÓN: Emulsion x 100- 200 Ml. Crema x 200 gr

ATC: V Varios V 03 Otros Preparados Terapeuticos

VITAMINA A , C, D

INDICACIÓN: Prevención y tratamiento de hipovitaminosis A, C y D.
La deficiencia crónica de VITAMINA A produce ceguera nocturna, hiperqueratosis, sequedad de la conjuntiva ocular (xeroftalmía), así como diversas lesiones nerviosas. Una hipovitaminosis A en una embarazada puede provocar graves malformaciones en el feto.
VITAMINA C: se encuentra indicada en estados carenciales como el escorbuto, quemaduras graves, diarrea crónica, hipertiroidismo, desnutrición, tabaquismo, uso de anticonceptivos.
La deficiencia de VITAMINA D puede producir deformaciones en el esqueleto como raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. También pueden aparecer intensos espasmos musculares.

POSOLOGIA:Adultos y niños: 50-500 mg/24 horas.

EFECTOS ADVERSOS: Rash, náuseas, vómito y diarrea. En algunos casos, vitamina C favorece la litiasis renal.

PRESENTACIÓN: Contiene: Ac. Ascórbico (Vit C): 4,17 mg/gota; Vit A: 416,67 UI/gota; Colecalciferol (Vit D3): 80 UI/gota. Gotas (1ml = 20 gotas; 1gota = 0,05ml).

OBSERVACIONES: . Existen diversos preparados de Vitaminas A, C y D conteniendo cantidades similares de las mencionadas vitaminas. Tri-Vi-Flúor ® contiene ademas 1,1mg/0,6ml de Flúor. Las vitaminas A y D en forma masiva pueden originar hipervitaminosis A y D.
Además de vértigo, náuseas, vómito, debilidad, anorexia, diarrea, polidipsia, poliuria, cambios mentales, son los síntomas más frecuentes.
Grandes dosis de vitamina C pueden causar diarrea debida a irritación directa de la mucosa intestinal, dando como resultado un incremento de la peristalsis.
De existir sobredosificación se aconseja realizar lavado gástrico. Descontinuar el medicamento hace desaparecer prácticamente todos los síntomas.

ATC: A11J- Complejos Vitaminicos

VITAMINA C

INDICACIÓN: Prevención o tratamiento de la enfermedad por deficiencia (escorbuto). Trastornos en la cicatrización. Absorción del hierro. Eliminación del hierro. Tirosinemia III. Tirosinemia del recién nacido. Metahemoglobinemia idiopática. Acidificación urinaria.

POSOLOGIA: R.N.D.: < 6 meses: 30 mg, 6 meses a 1 año: 35 mg, 1 a 10 años: 40-45 mg, >11 años: 50-60 mg, fumadores: 100 mg. Escorbuto: niños: 100-300 mg/día cada 8 hs, adultos: 1 a 2 g los primeros 2 días, luego 500 mg por una semana. Quemaduras severas: 200 - 500 mg/día. Acidificación de orina: niños: 500 mg cada 6-8 hs, adultos: 4-12 g/día cada 6-8 hs. Tirosinemia III: hasta 1 g/día. Tirosinemia del recién nacido: 50-200 mg/día. Eliminación del hierro: 200 mg/día, lactantes: 100 mg/día. Metahemoglobinemia: inicial (V.O./ E.V.): 2-5 g, mantenimiento: 50% de la dosis inicial en 12-24 hs (E.V.: infusión continua, V.O.: cada 4-6 hs). Dosis máxima E. V. en niños: 6 g/dia

EFECTOS ADVERSOS: Hemólisis, esofagitis, mareos, fatiga, náuseas, vómitos, obstrucción intestinal, hiperoxaluria, insuficiencia renal. Con la ingestión prolongada: nefrolitiasis y litiasis vesicular.

PRESENTACIÓN: Ampollas de 5 ml: 200 mg/ml

OBSERVACIONES: Aumenta o disminuye la excreción de algunas drogas. En metahemoglobinemia severa se asocia al azul de metileno. La ingestión prolongada de ácido ascórbico (que supera los 3 g/día) puede producir alteraciones gastrointestinales (náuseas seguida por diarrea) , interferencia con el efecto anticoagulante de la heparina, interferencia con los test de glucosuria, predisposición prenatal del feto a síntomas de deficiencia. Aumenta la excreción del hierro inducida por desferoxamina. Administrar lejos de las comidas ya que favorece su absorción. Se debe realizar medición de CPK ya que puede producir daño renal por precipitación de mioglobina en los túbulos.

ATC: A11HA Vitaminas y Cofactores. Hidrosolubles

VITAMINA D2 ERGOCALCIFEROL

INDICACIÓN: Prevención de deficiencia de vitamina D (raquitismo, tetania, retraso del crecimiento, osteomalacia), hipofosfatemia, hipoparatiroidismo.

POSOLOGIA: Suplementación dietaria: Prematuros: 400-800 U.I., hasta 30.000 U.I.; niños y adultos: 400 U.I.. Insuficiencia renal: niños: 4.000-40.000 U.I./día, adultos: 20.000 U.I./día. Hipoparatiroidismo: niños y adultos: 50.000 - 200.000 U.I./día con suplemento de calcio. Raquitismo vitamina D dependiente: niños: 3.000 - 5.000 U. I/día, dosis máxima: 60.000 U.I.; adultos: 10.000-60.000 U.I/día. Raquitismo nutricional y osteomalacia: niños y adultos con normal absorción: 1.000-5.000 U.I por 6-12 semanas, niños con malabsorción: 10.000 - 25.000 U.I. /día, adultos con malabsorción: 10.000-300.000 U.I./dí

EFECTOS ADVERSOS: Hipervitaminosis: náuseas, diarrea, pérdida de peso, poliuria, calcificación de tejidos blandos, anorexia, cefalea

PRESENTACIÓN: Gotas: Ostelín P-100: 10.000 U.I./ml (400 U.I./gota), Vitamina D Richmond, Vitamina D Austral: 12.000 U.I/ml (500 U.I./gota) Tanvimil D: 6.000 UI./ml Raquiferol: aproximadamente 2.400 U.I./gota

OBSERVACIONES: Es esencial monitorear el calcio sérico cuando se comienza con ergocalciferol, es probable que haya que ajustar la dosis sobre todo en pacientes digitalizados. 1,25 mg de ergocalciferol proveen 50.000 U. I. de vitamina D2 activa (1 µg = 40 U.I.)

INTERACCIONES: : Puede antagonizar los efectos de los bloqueadores de conductos del calcio al incrementar la concentración del mineral en suero; puede vincularse con los efectos tóxicos de digoxina, al aumentar los niveles de calcio; hay un incremento aditivo en los valores del mineral por una menor excreción de él, a causa de los diuréticos tiazídicos; la absorción disminuye por acción de antiácidos que contienen magnesio (posible aparición de hipermagnesemia); colestiramina, colestipol, orlistat y consumo excesivo de aceite mineral reducen su absorción
ATC: A11HA Vitaminas y Cofactores. Liposolubles

VITAMINA E
INDICACIÓN: Vitamina liposoluble. Antioxidante que impide la oxidación de las vitaminas A y C; protege los ácidos grasos poliinsaturados en membranas contra el ataque por radicales libres y protege los eritrocitos contra la hemólisis por agentes oxidantes
POSOLOGIA: R.N.D: 0-1 año: 3-4 mg. 1-10 años: 6-7 mg. > de 11 años: (masculinos)10 mg. (femeninas): 8 mg. Deficiencia: Neonatos: 25-50 UI/día. Niños con síndrome de mala absorcion: 1 UI/kg/día. Adultos: 60-75 UI/día. Prevención de deficiencia E: Neonatos: 5 UI/día. Adultos: 30 UI/día. Fibrosis quística: Lactantes, niños y adolescentes: 100-400 UI/día. La dosis o la frecuencia deberá adecuarse según nivel sérico.
EFECTOS ADVERSOS: Fatiga, debilidad, cefaleas, náuseas, diarrea, aumento de riesgo de trombosis.
PRESENTACIÓN: Equivalencia: 1 UI vitamina E= 1 mg de dl-alfatocoferol.acetato. Cápsulas blandas: 200 mg
OBSERVACIONES: Hipersensibilidad a la droga.
INTERACCIONES: Los antiácidos pueden precipitar los ácidos biliares en el intestino delgado y disminuir así la absorción de vitaminas liposolubles. No usar anticoagulantes con grandes dosis de tocoferol, por posible hipoprotrombinemia. La colestiramina o el aceite mineral pueden interferir en la absorción de la vitamina E. Facilita la absorción, almacenamiento y utilización de la vitamina A.
ATC: A11J- Complejos Vitaminicos

VITAMINA K
INDICACIÓN: Antihemorrágica en cuadros tóxicos por derivados del dicumarol, warfarina, etc. Déficit de factores de coagulación: II - VII - IX - X. Manifestaciones hemorrágicas.
POSOLOGIA: R.N.D: 0-1 año: 5-10 µg, 1-10 años: 15-30 µg > 11 años: 45-80 µg. Intoxicaciones: 1 mg/kg/día cada 8 hs, máximo: 10 mg. Deficiencia de protrombina: lactantes: 2 mg, niños mayores: 5-10 mg. Deficiencia vitamina K debida a drogas: V.O. : 2,5 a 5 mg/día.
EFECTOS ADVERSOS: Cefaleas, mareos, movimientos convulsivos, náuseas, vómitos, eritema, urticaria, rash, erupciones, disgeusia, ictericia. Hemólisis en el recién nacido, cuerpos de Heinz intraeritrocitarios.
PRESENTACIÓN: Ampollas: 1 y 10 mg
OBSERVACIONES: La administración E.V. push no debe exceder de 1 mg/minuto. La absorción oral depende de la presencia de sales biliares. Contraindicada en deficiencia de G6PD. Si hay daño hepático no sobrepasar los niveles terapéuticos. Controlar su efectividad con tiempo de protrombina. Las ampollas de marca Konakión(R)se pueden administrar por V.O.(el volumen requerido debe extraerse de la ampolla con el dispensador que viene, se retira la aguja y se coloca el contenido directamente en la boca del niño)
INTERACCIONES: Antagoniza la acción de la warfarina; el aceite mineral disminuye la absorción de fitomenadiona
ATC: A11HA Vitaminas y Cofactores. Liposolubles

VORICONAZOL
ACCION TERAPEUTICA: Antifúngico triazólico de amplio espectro. Inhibidor de la síntesis de ergosterol.
INDICACIÓN: Aspergilosis invasiva pulmonar y extrapulmonar. Profilaxis aspergilosis primaria y secundaria en pacientes inmunocompromidos oncohematologicos.
POSOLOGIA: E.V.: 2 a 12 años: inicial dosis de carga 9 mg/kg/dosis cada 12 hs por 2 dosis, dosis de mantenimiento 8 mg/kg cada 12 hs, dosis máxima 350 mg c/12 hs; > 12 años y adultos: dosis de carga: 6 mg/kg/dosis cada 12 hs por 2 dosis, dosis de mantenimiento: 4 mg/kg/dosis c/12 hs. V.O.: 2 a 12 años: 9 mg/kg/dosis c/12 hs; > 12 años < 40 kg: 200 mg/dosis c/12 hs, durante 1 día luego 100 mg/dosis c/12 hs; > 40 kg: 400 mg cada 12 hs durante 1 día, luego 200 - 300 mg c/12 hs. *Ver tabla de ajuste de dosis de antimicrobianos en insuficiencia renal.*

EFECTOS ADVERSOS: Alteraciones visuales (fotofobia, visión borrosa, etc), taquicardia, hipertensión, vasodilatación edema periférico, fiebre, cefalea, alucinaciones, hipokalemia, hipomagnesemia, náuseas, vómitos, prolongación del intervalo QT.

PRESENTACIÓN: Comprimidos recubiertos: 50-200 mg; F.A.: 200 mg.

OBSERVACIONES: V.O.: administrar 1 hs antes o 1 hs después de las comidas; E.V: infundir en 1-2 hs (máx. velocidad 3 mg/kg/hora). Monitorear la función hepatica, renal y visual.

INTERACCIONES: voriconazol puede aumentar la concentración sérica de: cisapride, pimozida, rifabutina (contraindicada), ciclosporina (disminuir la dosis de ciclosporina 50%) sirolimus (contraindicado), tacrólimus (disminuir la dosis de tacrólimus un 60%), efavirenz, delarvine, benzodiazepinas, bloqueantes de los canales de calcio, metilprednisolona, omeprazol (para dosis de omeprazol > a 40 mg/dia, reducir la dosis del omeprazol un 50%). Rifampicina, difenilhidantoina disminuyen los niveles séricos de voriconazol (ajustar su dosis).

ATC: JO2A C.

FOSCARNET

ACCION TERAPEUTICA: Antivírico que inhibe la replicación de los virus del grupo herpes: virus del herpes simple (VHS) tipos 1 y 2, el herpes virus humano tipo 6, el virus varicela-zoster, el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus (CMV)

INDICACION: Dado que la seguridad de foscarnet en niños no ha sido investigada, ni su efecto sobre el desarrollo de su esqueleto, solo debe administrarse en edad pediátrica cuando el beneficio potencial sea superior a los posibles riesgos **(E: off-label).** Tratamiento de infecciones del grupo herpes resistentes a las terapias convencionales.

POSOLOGIA: Infección por citomegalovirus (CMV) enfermedad del sistema nervioso central [SNC], retinitis o infección diseminada: Inducción (EV): 60 mg/kg/8 h o 90 mg/kg/12 h en infusión durante 1 o 2 horas respectivamente como mínimo. Mantenimiento (EV): 90-120 mg/kg/24 h, en infusión durante 2 horas. Infección por VHS: 40 mg/kg/8 h o 60 mg/kg/12 h en infusión endovenosa durante 1 hora. Infección por varicela-zoster: Varicela sin respuesta a aciclovir: 40-60 mg/kg/8 h durante 7-10 días.
Zóster progresivo: 90 mg/kg/12 h. La dosis de foscarnet debe ser ajustada en pacientes con un aclaramiento de creatinina inferior a 1,4 ml/minuto/kg.

EFECTOS ADVERSOS: Insuficiencia renal, hipercalcemia, hiper o hipofosfatemia, alteraciones metabólicas. Alteraciones del magnesio.

PRESENTACION: Frasco de 500 ml: 24 mg/ml

OBSERVACIONES: Utilizar con cuidado en pacientes con función renal deteriorada y cuando se usan otros agentes nefrotóxicos como anfotericina B, aminoglucósidos, cisplatino, ciclosporina. Interacciona con pentamidina (aumenta la hipocalcemia), ciprofloxacina (aumenta el riesgo de convulsiones). Por catéter central se infunde sin diluir. Por vena periférica la solución debe diluirse a una concentración final máxima de 12 mg/ml. La velocidad de infusión no debe exceder los 60 mg/kg/hora. Cada gramo de Foscarnet sódico contiene 10 mmol de sodio y 3,3 mmol de fosfato. Vigilar creatinina sérica cada dos días durante el tratamiento de inducción y una vez a la semana durante el tratamiento de mantenimiento, llevándose a cabo los ajustes apropiados de la dosis según la función renal. Suspender tratamiento si creatinina igual o mayor 2,9 mg/dl. La toxicidad renal de foscarnet puede reducirse mediante una adecuada hidratación del paciente.Estabilidad: no contiene conservantes y una vez roto el precinto de esterilidad del frasco la solución debe ser utilizada en un plazo de 24 horas.

INTERACCIONES: Foscarnet puede afectar la función renal, se puede producir un efecto nefrotóxico aditivo cuando se administra con otros fármacos nefrotóxicos como aminoglucósidos, anfotericina B y ciclosporina A. Foscarnet puede disminuir los niveles séricos de calcio ionizado, se recomienda una extrema precaución cuando se emplea concomitantemente con otros fármacos que, como la pentamidina intravenosa, afectan los niveles séricos de calcio. En combinación con ritonavir o saquinavir se han descrito casos de función renal anormal. Durante el tratamiento concomitante con Foscarnet y con pentamidina intravenosa, se ha observado el desarrollo de insuficiencia renal y de hipocalcemia sintomática (signos de Trousseau y de Chvostek).

ATC: J05AD